FALLARBEIT · EXAMEN & PRAXIS

92 Fallbeispiele für die Pflege

Klinische Fälle aus 13 Fachgebieten: Situation lesen, an jedem Entscheidungspunkt die beste Handlung wählen – mit ausführlicher Auflösung und Merksatz zu jedem Fall.

Bestehen ist planbar.

Entscheidungen | Priorisierung | Notfall | Merksätze

92	13	A4
Fälle	Fachgebiete	druckfertig

INHALT

1. Innere Medizin
2. Chirurgie
3. Intensivmedizin
4. Pädiatrie
5. Anästhesie
6. Psychiatrie
7. Pflegegrundlagen
8. Neurologie
9. Onkologie
10. … und weitere

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Maßgeblich sind Lehrinhalte, Leitlinien und Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

So arbeitest du mit den Fällen

Jeder Fall hat mehrere Entscheidungspunkte. Wähle jeweils die Handlung, die du als Pflegefachkraft zuerst bzw. am sichersten durchführen würdest. Die Auflösung zeigt, was richtig, vertretbar oder falsch ist – und warum.

BEWERTUNG

RICHTIG beste Wahl
VERTRETBAR möglich, aber nicht optimal
FALSCH gefährlich oder falsch priorisiert

IM UNTERRICHT

Ideal für Lerngruppen und Praxisanleitung: Fall vorlesen, gemeinsam entscheiden, dann auflösen.

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

Innere Medizin

7 Fälle

Fall 1 · Akuter Brustschmerz

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Frau K., 64 J., Diabetikerin: seit 45 min drückender retrosternaler Schmerz, vegetativ (Kaltschweiß, Übelkeit). RR 145/85, Puls 92, SpO_2 96 %.

1 PRIORISIERUNG

Mehrere Maßnahmen sind sinnvoll – womit beginnst du?

A) 12-Kanal-EKG (Ziel < 10 min) + Monitor

B) Sofort O_2 über Maske 10 L geben

C) Erst i.v.-Zugang legen und Troponin abnehmen

2 EKG-BEFUND

EKG: ST-Hebung in II/III/aVF mit reziproker Senkung in I/aVL. Konsequenz?

A) Troponin abwarten, um den Infarkt zu bestätigen

B) Inferiorer STEMI → sofort Reperfusion/Herzkatheter aktivieren

C) Zusätzlich rechtspräkordiale Ableitungen (V4r) ableiten

3 MEDIKATION PRÜFEN

Welcher Punkt ist beim inferioren Infarkt besonders kritisch?

A) Volumengabe grundsätzlich vermeiden

B) Nitrat großzügig geben, senkt ja die Vorlast

C) Nitrate nur vorsichtig/ggf. meiden (mögliche RV-Beteiligung → Vorlastabfall)

4 AKUTE KOMPLIKATION

Bei der Vorbereitung wird die Patientin bewusstlos, am Monitor Kammerflimmern. Reaktion?

A) Erst Puls 10 s tasten und Arzt rufen

B) Sofort Defibrillation + CPR, Notfallteam

C) Amiodaron i.v. zuerst, dann Schock

Fall 2 · Nächtliche Atemnot

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Herr B., 78 J., KHK: nachts schwere Atemnot, Orthopnoe, feuchte RGs beidseits, SpO_2 85 %, RR 195/110, Puls 110.

1 PRIORISIERUNG

Was hat Sofortpriorität?

- A) Zuerst 12-Kanal-EKG, alles andere danach
- B) Sofort hochdosiert i.v.-Furosemid, dann der Rest
- C) Oberkörper hoch / Beine tief, O_2 titrieren, Monitor

2 THERAPIERICHTUNG

RR 195/110 – hypertensives Lungenödem. Was ist führend?

- A) Betablocker i.v. zur Frequenzsenkung
- B) Nitrate (Vor-/Nachlast senken) + Diuretikum, O_2/NIV
- C) Nur hochdosiert Furosemid, keine Nitrate

3 VERSCHLECHTERUNG

Trotz Therapie SpO_2 84 %, zunehmende Erschöpfung, noch ansprechbar. Reaktion?

- A) Weiter nur O_2-Maske, abwarten
- B) Sofort sedieren und intubieren
- C) NIV (CPAP) einleiten, Intensiv informieren

4 ÜBERWACHUNG

Unter NIV bessert es sich. Worauf achtest du besonders?

- A) RR, SpO_2, Atemarbeit, Bilanz/Ausscheidung, Vigilanz, NIV-Toleranz
- B) Nur SpO_2 bis 100 % anstreben

Fall 3 · COPD-Exazerbation

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Frau S., 70 J., schwere COPD: 3 Tage zunehmende Dyspnoe, purulentes Sputum, SpO_2 84 %, leicht somnolent, AF 28.

1 SAUERSTOFFGABE

Wie gibst du Sauerstoff?

- (A) Erst BGA abwarten, bis dahin kein O_2
- (B) Kontrolliert titrieren, Ziel SpO_2 88–92 %, engmaschig
- (C) Reservoirmaske 12–15 L, später runtertitrieren

2 THERAPIE

Was steht therapeutisch im Vordergrund (AO)?

- (A) Sofort NIV für jeden, unabhängig von der BGA
- (B) Kurzwirksame Bronchodilatatoren, systemische Steroide, ggf. Antibiotikum (purulent)
- (C) Sedierung wegen der Unruhe

3 BGA-BEFUND

BGA: pH 7,28, pCO_2 68 mmHg. Was ist indiziert?

- (A) O_2 deutlich erhöhen, um die Sättigung zu pushen
- (B) NIV (respiratorische Azidose), Intensiv informieren
- (C) Weiter nur Inhalation, abwarten

4 ÜBERWACHUNG

Unter NIV bessert sich die BGA. Worauf achtest du?

- (A) SpO_2 auf 100 % anheben
- (B) Vigilanz, AF, SpO_2 (88–92 %), BGA-Verlauf, NIV-Toleranz

Fall 4 · Plötzliche Atemnot postop.

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Herr M., 58 J., 3 Tage nach Knie-TEP: plötzliche Dyspnoe + atemabhängiger Thoraxschmerz, Puls 120, SpO_2 88 %, RR 110/70, einseitig geschwollenes Bein.

1 PRIORISIERUNG

Was hat Vorrang?

A Eigenständig Vollheparinisierung starten

B Erst 12-Kanal-EKG, dann entscheiden

C Monitoring + O_2 titrieren, Patient ruhigstellen, Arzt – V.a. LE

2 DIAGNOSTIK

Aktuell hämodynamisch stabil (RR 110/70). Vorgehen (AO)?

A Erst D-Dimer abwarten, bevor etwas passiert

B CT-Pulmonalisangiografie anstreben; Antikoagulation nach AO

3 AKUTE VERSCHLECHTERUNG

Plötzlich RR 80/50, gestaute Halsvenen, kaltschweißig. Einordnung/Reaktion?

A Großzügig Volumen geben, bis der RR steigt

B Hämodynamisch instabile (Hochrisiko-)LE → Notfallteam, Kreislaufstütze nach AO, Lyse erwägen

C Patienten aufsetzen zur Atemerleichterung

4 ÜBERWACHUNG

Reanimationsbereitschaft. Vorgehen?

A Engmaschig RR/Puls/SpO_2, CPR-Bereitschaft, Lyse/Intensiv nach AO

B Nur die Sättigung überwachen

Fall 5 · Bluterbrechen

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Frau L., 67 J., NSAR + ASS: Hämatemesis (kaffeesatzartig) + Meläna, blass, Puls 112, RR 96/60, unruhig.

1 PRIORISIERUNG

Was hat Vorrang?

- A Kreislauf: 2 großlumige Zugänge, Volumen nach AO, Monitor, Kreuzblut, Arzt
- B Magensonde zum Ausspülen legen
- C Sofort PPI i.v. als Bolus, dann der Rest

2 ZENTRALE MASSNAHME

Stabilisierung läuft. Was ist therapeutisch zentral?

- A Erst beobachten, Endoskopie elektiv am Folgetag
- B Frühe Endoskopie (diagnostisch + therapeutisch), nüchtern, PPI nach AO

3 VERSCHLECHTERUNG

Hb-Abfall, RR 85/55 trotz Volumen, erneute Hämatemesis. Reaktion?

- A Kopftief lagern, um den Kreislauf zu stützen
- B Atemweg schützen (Aspiration!), absaugen, Transfusion nach AO, dringliche Endoskopie/Intensiv
- C Nur weiter Volumen, abwarten

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

- A RR/Puls engmaschig, Bewusstsein, Ausscheidung, Hb-/Gerinnungsverlauf, Rezidivzeichen
- B Einmal RR messen genügt

Fall 6 · Plötzliche Verwirrtheit

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Herr T., 72 J., Insulin + Sulfonylharnstoff: akut verwirrt, zittrig, kaltschweißig. BZ 2,3 mmol/l (41 mg/dl). Noch wach, schluckt sicher.

1 SOFORTMASSNAHME

Wach und schluckfähig – was ist erste Wahl?

- A i.m. Glukagon
- B Orale schnelle KH, 15–20 g (z. B. Traubenzucker/Saft)
- C i.v. Glukose 40 %, obwohl er schlucken kann

2 NACH DER GABE

Wie geht es weiter?

- A Keine Kontrolle, der Patient kann gehen
- B BZ nach 15 min kontrollieren, ggf. wiederholen, dann komplexe KH

3 MEDIKATION BEDENKEN

Welcher Aspekt ist wegen des Sulfonylharnstoffs wichtig?

- A Längere Überwachung (Gefahr protrahierter/rezidivierender Hypoglykämie), Arzt/ggf. stationär
- B Nach Normalisierung sofort entlassen

4 ÜBERWACHUNG / URSACHE

Worauf achtest du?

- A BZ-Verlauf, Bewusstsein, Auslöser (Dosis/Mahlzeit/Niereninsuffizienz), Doku, Arzt
- B Nur einmal nachmessen

Fall 7 · Fieber auf Station

Routine · niedrig | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Frau S., 72 J., fühlt sich seit dem Morgen schlapp und heiß. Du übernimmst die Grundpflege und Beobachtung.

1 SCHICHTBEGINN

Womit beginnst du?

- A Eigenmächtig ein fiebersenkendes Mittel geben
- B Temperatur und weitere Vitalzeichen messen und nach dem Befinden fragen
- C Nur das Fenster öffnen und abwarten

2 BEOBACHTUNG

Temperatur 38,9 °C. Was erfasst du zusätzlich?

- A Bewusstsein, Hautzustand, Trinkmenge und Atmung beobachten und dokumentieren
- B Nur die Temperatur notieren
- C Gar nichts dokumentieren

3 FLÜSSIGKEIT

Die Patientin hat heute kaum getrunken. Was tust du?

- A Den geringen Trinkverlauf ignorieren
- B Getränke anbieten und anreichen, Einfuhr beobachten und melden
- C Sie zum Trinken einer ganzen Kanne drängen

4 MELDUNG

Wie schließt du ab?

- A Befund an die Pflegefachkraft melden und vollständig dokumentieren
- B Erst am Schichtende kurz erwähnen

Chirurgie

7 Fälle

Fall 8 · Akutes Abdomen

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

> Herr R., 24 J.: seit 12 h Bauchschmerz, zunächst periumbilikal, jetzt rechter Unterbauch; Übelkeit, Fieber 38,6 °C, Abwehrspannung, Loslassschmerz.

1 PRIORISIERUNG

Wie gehst du vor?

- A Wärmflasche auf den Bauch zur Schmerzlinderung
- B Abführmittel geben, um den Darm zu entlasten
- C Vitalzeichen, nüchtern lassen, Schmerz/Temperatur erfassen, Arzt informieren

2 ANALGESIE & DIAGNOSTIK

Starke Schmerzen, der Arzt ordnet Diagnostik an. Was ist korrekt?

- A Keine Schmerzmittel, sonst wird die Diagnose verschleiert
- B Analgesie nach AO ist erlaubt und verschleiert die Diagnostik nicht – Labor/Sono/ggf. CT
- C Essen anbieten, damit er zu Kräften kommt

3 VERSCHLECHTERUNG

Plötzlich brettharter Bauch, RR fällt, Puls steigt, hohes Fieber. Reaktion?

- A Schmerzmittel erhöhen und beobachten
- B V.a. Perforation/Peritonitis → sofort Chirurg/OP-Vorbereitung, Volumen, Antibiotika nach AO, Monitoring
- C Erst das CT abwarten, bevor jemand gestört wird

4 ÜBERWACHUNG / OP-VORBEREITUNG

Worauf achtest du?

- A Kreislauf, Bilanz, Temperatur, OP-Vorbereitung (nüchtern, Zugang, Einwilligung), Sepsiszeichen
- B Nur die Temperatur kontrollieren

Fall 9 · Darmverschluss

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Frau D., 71 J., Z.n. Bauch-OPs: zunehmende kolikartige Bauchschmerzen, geblähtes Abdomen, fäkulentes Erbrechen, kein Stuhl/Wind seit 2 Tagen.

1 PRIORISIERUNG

Wie gehst du vor?

- A Abführmittel/Einlauf geben
- B Nüchtern, Magensonde zur Entlastung nach AO, i.v.-Zugang/Volumen, Arzt
- C Reichlich trinken lassen, um den Darm in Gang zu bringen

2 ZENTRALE MASSNAHME

Bildgebung bestätigt mechanischen (Briden-)Ileus. Was ist zentral?

- A Nur Schmerzmittel, abwarten ob es sich löst
- B Magensonden-Entlastung, Bilanz, Elektrolyte ausgleichen, chirurgische Mitbeurteilung

3 VERSCHLECHTERUNG

Plötzlich Dauerschmerz statt Kolik, lokale Abwehr, Fieber, RR fällt. Einordnung?

- A Weiter konservativ abwarten
- B V.a. Strangulation/Ischämie → chirurgischer Notfall, OP-Vorbereitung, Volumen, Antibiotika nach AO

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

- A Nur den Schmerzscore
- B Kreislauf, Bilanz (Sonde/Urin), Elektrolyte, Temperatur, Sepsiszeichen, OP-Vorbereitung

Fall 10 · Plötzlich kaltes Bein

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

> Herr P., 68 J., Vorhofflimmern: plötzlich starker Schmerz im rechten Bein; Bein blass, kalt, kein Fußpuls tastbar, beginnende Gefühlsstörung.

1 PRIORISIERUNG

Wie lagerst und handelst du?

- (A) Bein hochlagern zur Entlastung
- (B) Aktiv mit Wärmflasche erwärmen
- (C) Bein tief lagern, warm halten (nicht aktiv wärmen), Pulsstatus dokumentieren, sofort Gefäßchirurgie/Arzt

2 ZEITKRITISCH

Akuter arterieller Verschluss (embolisch bei VHF). Was ist zeitkritisch (AO)?

- (A) Rasche Revaskularisation (Embolektomie/Lyse); Antikoagulation nach AO; nüchtern (OP)
- (B) Erst abwarten, ob sich die Durchblutung erholt

3 VERSCHLECHTERUNG

Nach Stunden: Schwellung, harte Muskelloge, stärkster Schmerz, Sensomotorik schlechter. Einordnung?

- (A) V.a. Kompartmentsyndrom/fortgeschrittene Ischämie → sofort Chirurg (ggf. Fasziotomie), Monitoring
- (B) Schmerzmittel erhöhen, abwarten

4 ÜBERWACHUNG

Nach Revaskularisation – worauf achtest du?

- (A) Durchblutung/Puls, Sensomotorik, Logenspannung, Nierenwerte/Urin (Reperfusionsschaden), Schmerz
- (B) Nur den Schmerz dokumentieren

Fall 11 · Schmerz im Gips

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Patient, 22 J., nach Unterschenkelfraktur im Gips: zunehmender, unverhältnismäßig starker Schmerz, Schmerz bei passiver Zehenstreckung, pralle Wade, Kribbeln.

1 ERSTES VORGEHEN

Was tust du zuerst?

- A Stärkeres Schmerzmittel geben und abwarten
- B Gips/zirkuläre Verbände sofort spalten, Bein auf Herzhöhe, sofort Arzt
- C Bein hochlagern und kühlen

2 ENTSCHEIDEND

Der Befund spricht für ein drohendes Kompartmentsyndrom. Was ist entscheidend?

- A Erst ein Röntgen abwarten
- B Sofortige chirurgische Beurteilung (Logendruck/Fasziotomie), Durchblutung/Sensomotorik engmaschig

3 VERSCHLECHTERUNG

Trotzdem zunehmender Druck, Sensibilität nimmt ab, Fußpuls jetzt schwächer. Reaktion?

- A Notfall-Fasziotomie veranlassen (Chirurg), Monitoring, Bein auf Herzhöhe
- B Weiter beobachten, der Puls ist ja noch da

4 ÜBERWACHUNG

Nach der Fasziotomie – worauf achtest du?

- A Sensomotorik, Durchblutung, Logenspannung, Nieren-/Urinkontrolle (Rhabdomyolyse), Wunde
- B Nur den Verband kontrollieren

Fall 12 · Postoperative Nachblutung

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Frau H., 60 J., 4 h nach großer Bauch-OP: tachykard (118), RR 95/55, blass, kaltschweißig, Wunddrainage füllt sich rasch mit Blut, unruhig.

1 PRIORISIERUNG

Wie gehst du vor?

- (A) Drainage abklemmen, damit kein Blut mehr verloren geht
- (B) Erst die Schmerzen behandeln, dann weiter
- (C) Kreislauf: Monitor, 2 großlumige Zugänge, Volumen nach AO, Drainagemenge dokumentieren, sofort Chirurg/Arzt

2 DIAGNOSTIK/THERAPIE

Was ist sinnvoll (AO)?

- (A) Labor/Hb, Kreuzblut/Transfusion vorbereiten, Gerinnung prüfen, ggf. operative Revision
- (B) Nur weiter Volumen und beobachten

3 VERSCHLECHTERUNG

Trotz Volumen RR 80/45, Hb fällt, Drainage weiter blutig. Reaktion?

- (A) Weiter nur Kristalloide, abwarten
- (B) Operative Revision anstreben, Transfusion nach AO, Massivtransfusionsbereitschaft, Intensiv

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

- (A) RR/Puls engmaschig, Hb-/Gerinnungsverlauf, Drainagemenge, Bewusstsein, Urin, Wärmeerhalt
- (B) Stündlich RR genügt

Fall 13 · Eingeklemmte Leiste

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

> Herr K., 55 J.: seit 4 h schmerzhafte, nicht reponible Vorwölbung in der Leiste, Übelkeit, Erbrechen; die Schwellung ist prall, gerötet, sehr druckschmerzhaft.

1 PRIORISIERUNG

Wie gehst du vor?

- A Mehrfach kräftig versuchen, die Hernie zurückzudrücken
- B Wärmflasche zur Entspannung auflegen
- C Nüchtern lassen, Vitalzeichen, nicht selbst reponieren, sofort Chirurg/Arzt

2 ZENTRALE MASSNAHME

V.a. Inkarzeration mit drohender Strangulation. Was ist zentral?

- A Abwarten, ob es sich von selbst löst
- B Dringliche operative Versorgung anstreben, nüchtern, Zugang/Volumen, Analgesie nach AO

3 VERSCHLECHTERUNG

Zunehmender Schmerz, Fieber, RR fällt, Abwehrspannung. Einordnung?

- A Noch ein Repositionsversuch
- B V.a. Strangulation/Ileus/Peritonitis → Notfall-OP-Vorbereitung, Volumen, Antibiotika nach AO, Monitoring

4 ÜBERWACHUNG / OP-VORBEREITUNG

Worauf achtest du?

- A Nur den Schmerz dokumentieren
- B Kreislauf, Bilanz, Temperatur, Sepsiszeichen, nüchtern, Zugang, Einwilligung

Fall 14 · Erster Tag nach der OP

Routine · niedrig | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Herr M., 28 J., 1. Tag nach Blinddarm-OP (Appendektomie). Du betreust ihn im Frühdienst und übernimmst Grundpflege und Beobachtung. Er ist wach, klagt aber über Schmerzen.

1 SCHICHTBEGINN

Womit beginnst du sinnvoll deine Betreuung?

- A Ungefragt den Wundverband wechseln
- B Den Patienten sofort zum Aufstehen bewegen
- C Vitalzeichen kontrollieren, nach Befinden und Schmerzen fragen, Verband ansehen

2 SCHMERZ

Herr M. gibt seine Schmerzen mit 6 von 10 an. Wie gehst du vor?

- A Selbst ein Schmerzmittel aus dem Schrank geben
- B Schmerz mit Skala erfassen, an die Pflegefachkraft melden, Gabe nach Anordnung, dokumentieren
- C Abwarten, Schmerzen gehören nach einer OP eben dazu

3 WUNDBEOBACHTUNG

Der Verband ist leicht durchgeblutet. Was tust du?

- A Sofort selbst steril neu verbinden
- B Ausmaß und Farbe beobachten, Stelle markieren, melden und dokumentieren
- C Die Durchblutung ignorieren

4 PROPHYLAXEN

Was ist am 1. Tag nach der OP besonders wichtig?

- A Frühmobilisation nach Anordnung, Thrombose- und Pneumonieprophylaxe, Atemübungen
- B Strikte Bettruhe anordnen, damit die Wunde heilt

Intensivmedizin

7 Fälle

Fall 15 · Septischer Schock

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

> Frau N., 76 J., Dauerkatheter: Fieber 39,4 °C, Schüttelfrost, RR 85/50, Puls 124, verwirrt, Laktat erhöht, warme Peripherie.

1 ERSTE STUNDE

Was tust du im Sepsis-Bündel zuerst?

- (A) Erst fiebersenken (Paracetamol) und beobachten
- (B) Blutkulturen abnehmen, dann zügig Breitband-Antibiotikum nach AO, Volumenbolus, Laktat, Monitoring
- (C) Antibiotikum sofort, Blutkulturen später nachholen

2 VOLUMEN

RR bleibt 85/50 nach erstem Bolus. Vorgehen?

- (A) Sofort Diuretikum, weil wenig Urin kommt
- (B) Weitere balancierte Kristalloid-Boli nach AO, Reevaluation (RR/Laktat/Urin)
- (C) Nur Antibiose, kein weiteres Volumen

3 ESKALATION

Trotz adäquatem Volumen RR 80/45, Laktat steigt. Was ist indiziert?

- (A) Vasopressor (Noradrenalin) nach AO, Intensiv/ZVK, engmaschiges Monitoring
- (B) Weiter literweise Volumen ohne Limit

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

- (A) MAP-Ziel, Laktat-Verlauf, Urinausscheidung, Bewusstsein, Temperatur, Fokuskontrolle (Katheter!)
- (B) Nur die Temperatur

Fall 16 · Beatmungsnotfall

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Beatmeter Intensivpatient: plötzlicher SpO_2-Abfall auf 80 %, Beatmungsdruck-Alarm, zunehmende Zyanose, unruhig.

1 STRUKTURIERT ZUERST

Was tust du?

A) Sedierung erhöhen wegen der Unruhe

B) Sofort den Tubus ziehen

C) 100 % O_2, manuell beatmen (vom Gerät trennen, Beutel), nach DOPES prüfen, Hilfe rufen

2 EINGRENZEN

Manuelles Beatmen schwergängig, einseitig abgeschwächtes Atemgeräusch. Verdacht?

A) Obstruktion vs. Fehllage/einseitige Intubation vs. Pneumothorax → absaugen, Tubuslage prüfen, Arzt

B) Einfach mehr Druck geben

3 VERSCHLECHTERUNG

Gestaute Halsvenen, einseitig fehlendes Atemgeräusch, RR fällt, Trachea verschoben. Einordnung?

A) Weiter beatmen und beobachten

B) V.a. Spannungspneumothorax → sofort Arzt, Entlastungspunktion/Drainage vorbereiten, Monitoring

4 ÜBERWACHUNG

Nach der Entlastung Besserung. Worauf achtest du?

A) Nur SpO_2

B) SpO_2, Beatmungsdrücke, seitengleiches Atemgeräusch, Tubuslage, Drainage/Sog, Kreislauf

Fall 17 · Gefährliches Kalium

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Herr W., 64 J., oligurisches akutes Nierenversagen: Schwäche, Parästhesien; Kalium 6,9 mmol/l; EKG mit hohen spitzen T-Wellen und verbreitertem QRS.

1 PRIORITÄT

Was hat bei EKG-Veränderungen Vorrang?

- A Monitor/EKG, sofort Arzt; Membranstabilisierung mit Kalziumglukonat nach AO
- B Kaliumsenker (Insulin/Glukose) reicht allein, kein Kalzium
- C Erst in Ruhe ein neues Kalium abwarten

2 K^+ SENKEN

Nach Membranstabilisierung – wie wird Kalium gesenkt (AO)?

- A Nur Kationenaustauscher oral, das genügt
- B Insulin + Glukose i.v. (K^+ nach intrazellulär), ggf. Beta-2-Mimetikum; Verlauf (K^+, BZ)

3 DEFINITIV

Anurisch, K^+ bleibt trotz Maßnahmen hoch. Was ist definitiv?

- A Weiter nur Insulin/Glukose wiederholen
- B Dialyse anstreben (definitive Elimination), Intensiv, Monitoring

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

- A Nur einmal K^+ nachbestimmen
- B Kontinuierliches EKG, K^+-/BZ-Verlauf, Diurese/Bilanz, Reanimationsbereitschaft

Fall 18 · Entgleister Zucker

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Frau J., 28 J., Typ-1-Diabetes: Übelkeit/Erbrechen, Bauchschmerz, tiefe Atmung (Kussmaul), exsikkiert; BZ 28 mmol/l, pH 7,12, Ketone positiv, K^+ 3,2 mmol/l.

1 VORRANG

Was hat in der DKA-Therapie Vorrang?

A Natriumbikarbonat zur pH-Korrektur geben

B Großzügige Volumengabe (NaCl) nach AO, Monitoring, Elektrolyte/K^+, Arzt

C Sofort hochdosiert Insulin als Bolus, Volumen später

2 KALIUM BEACHTEN

K^+ ist 3,2 mmol/l. Was ist vor/mit Insulin wichtig?

A Insulin trotzdem sofort hoch, K^+ ignorieren

B Kalium nach AO substituieren; Insulin erst bei adäquatem K^+ starten/begleiten

3 BZ FÄLLT

Unter Therapie sinkt der BZ rasch auf 12 mmol/l, die Azidose ist noch nicht behoben. Vorgehen?

A Insulin sofort stoppen, weil der BZ fast normal ist

B Glukose zur Infusion ergänzen, niedrig dosiertes Insulin weiter bis Azidose/Ketose behoben

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

A Nur BZ alle paar Stunden

B BZ stündlich, K^+/Elektrolyte, BGA/Ketone, Bilanz, Bewusstsein, Herzrhythmus

Fall 19 · Nächtliche Unruhe (Intensiv)

akut | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Herr S., 79 J., 2. Tag nach großer OP auf Intensiv: nachts plötzlich agitiert, desorientiert, zieht an Zugängen, fluktuierende Aufmerksamkeit.

1 ERSTES VORGEHEN

Was tust du zuerst?

A Reversible somatische Ursachen ausschließen (Hypoxie, BZ, Schmerz, Harnverhalt, Medikamente), Monitoring, Arzt

B Ein Benzodiazepin als Schlafmittel geben

C Sofort fixieren und sedieren

2 BASIS DER THERAPIE

Keine akute somatische Ursache gefunden. Was ist die Basis?

A Direkt ein Antipsychotikum als Standard für alle

B Nicht-medikamentös: Reorientierung, Tag-Nacht-Rhythmus, Brille/Hörgerät, Mobilisation, Zugänge sichern, Angehörige

3 EIGENGEFÄHRDUNG

Trotzdem starke Agitation, er reißt am arteriellen Zugang. Vorgehen?

A Niedrig dosiertes Antipsychotikum nach AO, engmaschige Überwachung, weiter nicht-medikamentös

B Hohe Dosis Benzodiazepin zur schnellen Ruhe

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

A Delir-Score (CAM-ICU), Vitalzeichen/QT (bei Antipsychotika), Selbst-/Sturzgefahr, Schlaf, Ursachen reevaluieren

B Nur, ob er ruhig ist

Fall 20 · Reaktion auf Medikament

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Patient erhält ein i.v.-Antibiotikum; innerhalb von Minuten Urtikaria, Atemnot mit Stridor, RR 80/40, Tachykardie, Angst.

1 SOFORT

Was tust du sofort?

- A Erst i.v.-Zugang/Labor sichern, dann Medikamente
- B Auslöser stoppen (Infusion!), Hilfe rufen, Adrenalin i.m. (Oberschenkel) nach AO, O_2, flach mit erhöhten Beinen
- C Zuerst Antihistaminikum + Kortison i.v.

2 WEITER

Nach Adrenalin i.m. – wie weiter?

- A Adrenalin sofort unkontrolliert als i.v.-Bolus nachschieben
- B Volumenbolus (Kristalloid) nach AO, O_2, Monitoring; Adrenalin ggf. wiederholen (alle 5–10 min)

3 ATEMWEG

Zunehmender Stridor / drohende Atemwegsschwellung. Vorgehen?

- A Abwarten, ob das Antihistaminikum wirkt
- B Atemweg sichern (frühe Intubationsbereitschaft/Anästhesie), Adrenalin wiederholen, Intensiv

4 ÜBERWACHUNG

Stabilisierung. Worauf achtest du?

- A Nach Besserung sofort entlassen
- B RR/SpO_2/Atemweg, Reevaluation, längere Überwachung (biphasische Reaktion!), Auslöser dokumentieren

Fall 21 · Grundpflege beim beatmeten Patienten

Routine · mittel | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Herr K. liegt beatmet und bewusstlos auf der Intensivstation. Du unterstützt unter Anleitung bei der Grundpflege.

1 HALTUNG

Wie gehst du den bewusstlosen Patienten an?

- A) Wortlos und ohne Vorstellung pflegen
- B) Trotz Bewusstlosigkeit ansprechen, Würde wahren, vorher Händedesinfektion
- C) Ohne Händedesinfektion und Handschuhe arbeiten

2 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du am Monitor?

- A) Einen Alarm einfach wegdrücken
- B) Nur auf den Patienten schauen, nicht auf den Monitor
- C) Puls, SpO_2 und Blutdruck im Blick behalten und Auffälligkeiten der Fachkraft melden

3 PROPHYLAXE

Welche Pflege ist besonders wichtig?

- A) Mund-, Augen- und Hautpflege sowie Lagerung zur Prophylaxe, nur unter Anleitung
- B) Eigenständig am Beatmungsschlauch hantieren
- C) Nur waschen, alles andere weglassen

4 ABSCHLUSS

Wie schließt du ab?

- A) Nur das Waschen notieren
- B) Alles dokumentieren und im Team kommunizieren

Pädiatrie

7 Fälle

Fall 22 · Krampfanfall bei Fieber

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Leon, 18 Monate, hohes Fieber: zu Hause generalisierter Krampfanfall, jetzt seit 2 min tonisch-klonisch zuckend, die Eltern sind panisch.

1 WÄHREND DES ANFALLS

Was tust du?

(A) Vor Verletzung schützen, Seitenlage wenn möglich, nichts in den Mund, Dauer messen, Atemweg/SpO_2 beobachten, Hilfe

(B) Etwas zwischen die Zähne schieben (Zungenbiss)

(C) Das Kind festhalten und die Zuckungen unterdrücken

2 ANFALLSDAUER

Der Anfall dauert nun > 5 min an. Was ist indiziert (AO)?

(A) Weiter abwarten, hört von selbst auf

(B) Antikonvulsivum nach Notfallschema (z. B. Benzodiazepin, gewichtsadaptiert), Atemweg/SpO_2 überwachen

(C) Sofort Fieber mit kaltem Wasser/Eis senken

3 NACH DEM ANFALL

Der Anfall sistiert, das Kind ist postiktal schläfrig. Vorgehen?

(A) Stabile Seitenlage, Atemweg/SpO_2/Vitalzeichen, Temperatur, ärztliche Abklärung der Ursache, Eltern aufklären

(B) Kind sofort nach Hause, war ja nur Fieber

4 RED FLAGS

Worauf achtest du besonders?

(A) Nur die Temperatur dokumentieren

(B) Bewusstsein/Wiederholung, Nackensteife/Petechien (Meningitis ausschließen!), Atmung, Temperatur, Elternberatung

Fall 23 · Bellender Husten nachts

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Mia, 2 Jahre, nachts: bellender Husten, heisere Stimme, inspiratorischer Stridor in Ruhe, leichte Einziehungen, subfebril, ängstlich.

1 ERSTES VORGEHEN

Was ist sinnvoll?

A Kind flach hinlegen und Racheninspektion mit Spatel

B Ruhe bewahren, Kind aufrecht auf dem Arm der Eltern lassen, nicht aufregen, kühle/feuchte Luft, SpO_2/Atmung beobachten, Arzt

C Sofort unter Zwang mit kaltem Vernebler inhalieren

2 THERAPIE

Stridor in Ruhe – was ist Standard (AO)?

A Fiebersenker reicht aus

B Glukokortikoid (z. B. Dexamethason/Prednisolon) nach AO; bei schwerem Stridor vernebeltes Adrenalin

C Antibiotikum, weil Infektion

3 VERSCHLECHTERUNG

Zunehmender Stridor in Ruhe, stärkere Einziehungen, Blässe, Unruhe. Reaktion?

A Beruhigend einreden und weiter abwarten

B Vernebeltes Adrenalin nach AO, O_2, Kind ruhig lassen, sofort Arzt/Klinik, Monitoring

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

A Nur die Temperatur

B Stridor/Atemarbeit, SpO_2, Bewusstsein/Erschöpfung, nach Adrenalin Nachbeobachtung (Rebound), Eltern einbeziehen

Fall 24 · Atemnot beim Säugling

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Säugling, 4 Monate: seit 2 Tagen Schnupfen, jetzt Trinkschwäche, Tachypnoe, Nasenflügeln, Einziehungen, exspiratorisches Giemen, SpO_2 90 %.

1 ERSTES VORGEHEN

Was ist sinnvoll?

- A Sofort Antibiotikum, weil Infekt
- B Kind flach lagern und ein Beruhigungsmittel geben
- C Oberkörper leicht erhöht, Nase freihalten (absaugen), O_2 titrieren, Trinkmenge/Atmung beobachten, Arzt

2 FLÜSSIGKEIT

Trinkschwäche bei Tachypnoe. Was ist sinnvoll (AO)?

- A Kleine häufige Mahlzeiten / ggf. Sonden- oder i.v.-Flüssigkeit nach AO; Aspirationsrisiko beachten
- B Zwingen, große Mengen auf einmal zu trinken

3 VERSCHLECHTERUNG

Zunehmende Atemnot, SpO_2 86 %, Apnoe-Phasen. Reaktion?

- A O_2 erhöhen/Monitoring, sofort Arzt/Klinik, Apnoe-Überwachung, ggf. Atemunterstützung (High-Flow/CPAP)
- B Inhalieren und abwarten

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

- A Nur SpO_2 bis 100 % anstreben
- B SpO_2, Atemarbeit, Apnoe, Trinkmenge/Ausscheidung, Bewusstsein, Temperatur

Fall 25 · Erbrechen & Durchfall

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Emil, 14 Monate: seit 2 Tagen Erbrechen + wässrige Durchfälle. Trinkt wenig, eingesunkene Augen, trockene Schleimhäute, verlängerte Rekap-Zeit, wenige nasse Windeln, müde.

1 EINSCHÄTZUNG

Erste Maßnahme?

A Durchfall sofort mit Loperamid stoppen

B Hydratationszustand/Vitalzeichen erfassen, orale Rehydratationslösung (ORS) in kleinen Schlucken, Arzt, Bilanz (Windeln/Gewicht)

C Reines Wasser oder Saft/Cola in großen Mengen geben

2 ORS-VORGEHEN

Das Kind erbricht die erste größere Menge. Wie weiter (AO)?

A Aufgeben und nur abwarten

B ORS löffel-/schluckweise sehr häufig (kleine Mengen), Geduld; bei Versagen/Verschlechterung i.v.-Rehydratation

3 VERSCHLECHTERUNG

Zunehmend lethargisch, Rekap > 3 s, Tachykardie, kaum Urin (schwere Dehydratation/ Schock). Reaktion?

A Weiter nur ORS löffelweise

B i.v.-Zugang, Volumenbolus (Kristalloid) nach AO, Monitoring, Klinik/Intensiv, Elektrolyte/BZ

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

A Nur, ob es noch erbricht

B Vitalzeichen, Bewusstsein, Rekap-Zeit, Ausscheidung/Bilanz/Gewicht, Elektrolyte/BZ, Hautturgor

Fall 26 · Fieber mit Hautflecken

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Hanna, 5 Jahre: hohes Fieber, zunehmend schläfrig, Kopfschmerz, Nackensteife; jetzt rasch auftretende, nicht wegdrückbare petechiale Hautflecken, RR niedrig-normal, Rekap verlängert.

1 ERKENNEN

Was ist hier entscheidend?

A Notfall erkennen (V.a. Meningokokken-Sepsis/Meningitis), sofort Arzt/Notfallteam, Monitoring, i.v.-Zugang, isolieren

B Erst beobachten, ob sich die Flecken ausbreiten

C Fiebersenker geben und in 1 h neu beurteilen

2 ZEITKRITISCH

Was ist zeitkritisch (AO)?

A Erst Lumbalpunktion abwarten, vorher keine Antibiose

B Sofortige i.v.-Antibiose (so früh wie möglich) nach AO, Volumen, O_2, Klinik/Intensiv; Umgebungsprophylaxe bedenken

3 VERSCHLECHTERUNG

RR fällt weiter, Marmorierung, zunehmende Eintrübung (septischer Schock). Reaktion?

A Volumenboli nach AO, Vasopressor/Intensiv nach AO, Monitoring, Reanimationsbereitschaft

B Nur Antibiose, kein Volumen

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

A Kreislauf/MAP, Bewusstsein, Ausbreitung der Petechien, Diurese, Temperatur, neurologische Zeichen, Isolation/Schutz

B Nur die Temperatur

Fall 27 · Verschlucktes Kleinteil

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Paul, 1 Jahr, beim Spielen mit Kleinteilen: plötzlich heftiger Husten, dann Würgen, jetzt Atemnot mit Stridor; er hustet noch kräftig, ist aber sichtlich in Not.

1 EINSCHÄTZUNG

Das Kind hustet noch kräftig (effektiver Husten). Was tust du?

A Zum Weiterhusten ermutigen, NICHT auf den Rücken schlagen, beobachten, Hilfe rufen, bereit sein einzugreifen

B Sofort kräftig auf den Rücken schlagen

C Sofort blind mit den Fingern im Mund nach dem Objekt suchen

2 INEFFEKTIVER HUSTEN

Der Husten wird leise, das Kind bekommt kaum noch Luft (ineffektiver Husten), ist aber bei Bewusstsein. Vorgehen (Säugling/Kleinkind)?

A 5 Rückenschläge, dann 5 Thoraxkompressionen (Säugling) im Wechsel; bei größerem Kind ggf. Bauchstöße; Notruf

B Kräftige Bauchstöße (Heimlich) beim Säugling

3 BEWUSSTLOSIGKEIT

Das Kind wird bewusstlos. Reaktion?

A Weiter nur auf den Rücken klopfen

B Reanimation beginnen (Thoraxkompressionen); bei Beatmung Mund auf sichtbaren Fremdkörper prüfen; Notruf/Notfallteam

4 NACH ERFOLG

Der Fremdkörper löst sich / die Atmung kehrt zurück. Worauf achtest du?

A Kind nach Hause schicken, geht ja wieder

B Atmung/SpO_2, Bewusstsein, ärztliche Kontrolle (Restmaterial/Schleimhautschaden, ggf. Bronchoskopie), Eltern

Fall 28 · Fieber beim Kind

Routine · niedrig | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Lena, 4 J., hat 39,2 °C Fieber. Die Eltern sind besorgt am Bett. Du sollst Lena betreuen und beobachten.

1 KONTAKT

Wie gehst du auf Kind und Eltern zu?

- A Das Kind rasch festhalten und schnell durchmessen
- B Die Eltern hinausschicken
- C Ruhig und kindgerecht erklären, die Eltern einbeziehen, dann messen

2 MASSNAHMEN

Wie senkst du das Fieber unterstützend?

- A Warm zudecken, damit es schwitzt
- B Maßnahmen nach Anordnung, ausreichend trinken, Wadenwickel nur bei warmen Beinen
- C Das Kind kalt abduschen

3 BEOBACHTUNG

Worauf achtest du besonders?

- A Nichts weiter beobachten
- B Bewusstsein, Trinkverhalten, Atmung und Hautausschlag beobachten
- C Nur die Temperatur erneut messen

4 ABSCHLUSS

Wie schließt du ab?

- A Nur mündlich der Kollegin sagen
- B Eltern anleiten, Befund melden und dokumentieren

Anästhesie

7 Fälle

Fall 29 · Plötzlicher CO_2-Anstieg intraop.

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Intraoperativ unter Sevofluran: unerklärter $etCO_2$-Anstieg, Tachykardie, Masseterspasmus nach Succinylcholin, beginnender Temperaturanstieg, Azidose.

1 ERKENNEN

Erstes Vorgehen bei Verdacht auf maligne Hyperthermie?

A Erst die Temperatur abwarten, bevor etwas geändert wird

B Trigger sofort stoppen (volatile Anästhetika/Succinylcholin), Hilfe rufen, 100 % O_2 mit hohem Flow, Operateur informieren

C Narkose mit mehr Sevofluran vertiefen

2 SPEZIFISCHE THERAPIE

Was ist die spezifische Therapie (AO)?

A Betablocker gegen die Tachykardie

B Nur kühlen, Dantrolen ist nicht nötig

C Dantrolen schnellstmöglich (gewichtsadaptiert), Team zur Aufbereitung, weiter 100 % O_2/Hyperventilation

3 BEGLEITMASSNAHMEN

Während Dantrolen läuft – welche Begleitmaßnahmen?

A Aktiv kühlen, BGA/Elektrolyte, Hyperkaliämie und Azidose behandeln, Diurese fördern, Monitoring

B Nur die Temperatur senken, Labor ist unwichtig

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du danach?

A $etCO_2$, Temperatur, K^+/BGA, CK/Myoglobin (Rhabdomyolyse), Urin, Kreislauf; Intensivverlegung

B Nach Stabilisierung sofort auf Normalstation

Fall 30 · Stridor nach Extubation

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Direkt nach Extubation (flache Narkose): inspiratorischer Stridor, paradoxe Atembewegungen, rascher SpO_2-Abfall, keine effektive Beatmung möglich.

1 SOFORT

Erstes Vorgehen beim Laryngospasmus?

A Sofort erneut intubieren ohne weitere Maßnahmen

B Patienten zum tiefen Durchatmen auffordern

C 100 % O_2, Esmarch-Handgriff, kräftiger Masken-CPAP, Hilfe rufen, Reize (Sekret/Manipulation) beseitigen

2 PERSISTENZ

Der Spasmus persistiert, SpO_2 fällt weiter. Was ist indiziert (AO)?

A Weiter nur CPAP, abwarten

B Narkose vertiefen (z. B. Propofol) und/oder kleine Dosis Succinylcholin nach AO, weiter 100 % O_2/CPAP

3 NACH DEM DURCHBRECHEN

Der Spasmus löst sich, der Patient wird beatmet. Woran denkst du?

A Nichts weiter, ist ja vorbei

B Oxygenierung sichern und an Negativdruck-Lungenödem denken (nach starkem Sog), Auskultation, Monitoring

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du im Aufwachraum?

A SpO_2, Atemarbeit, Auskultation (Lungenödem?), Wachheit, Sekret, Re-Spasmus-Gefahr

B Nur SpO_2

Fall 31 · Regurgitation bei Einleitung

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Nicht-nüchterner Notfallpatient (Ileus): bei der Einleitung Regurgitation von Mageninhalt, Mageninhalt im Rachen, SpO_2 beginnt zu fallen.

1 SOFORT

Erstes Vorgehen bei beobachteter Regurgitation/Aspiration?

- A Sofort eine aufwändige Zusatzdiagnostik veranlassen
- B Kopftief-/Seitenlage, sofort absaugen, 100 % O_2, Atemweg mit Cuff sichern, Operateur/Hilfe
- C Erst kräftig mit der Maske beatmen, um die Sättigung zu halten

2 NACH ATEMWEGSSICHERUNG

Der Atemweg ist gesichert. Wie weiter (AO)?

- A Routinemäßig sofort Antibiotikum + Kortison für alle
- B Tracheobronchial absaugen, 100 % O_2, ggf. Bronchoskopie nach AO, Beatmung anpassen (PEEP), Monitoring

3 VERSCHLECHTERUNG

SpO_2 bleibt niedrig, steigende Beatmungsdrücke, Giemen. Reaktion?

- A O_2/PEEP optimieren, absaugen, Bronchospasmus nach AO behandeln, Intensiv
- B Beatmungsdruck einfach maximal erhöhen

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

- A Nur SpO_2
- B SpO_2, Beatmungsdrücke, Auskultation, Röntgen-Verlauf, Temperatur/Infektzeichen, Intensivüberwachung

Fall 32 · Symptome nach Regionalanästhesie

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Während/nach Regionalanästhesie mit hoher Lokalanästhetika-Dosis: periorale Taubheit, metallischer Geschmack, Ohrensausen, Unruhe, dann Muskelzuckungen, beginnende Herzrhythmusstörung.

1 ERKENNEN

Erstes Vorgehen bei Verdacht auf Lokalanästhetika-Intoxikation (LAST)?

A Injektion sofort stoppen, Hilfe rufen, 100 % O_2, Monitoring, auf Krampf/Arrhythmie vorbereiten

B Mehr Lokalanästhetikum, um die Wirkung zu sichern

C Erst abwarten, ob sich die Symptome von selbst legen

2 SPEZIFISCHE THERAPIE

Was ist die spezifische Therapie (AO)?

A Nur den Krampf behandeln, Lipid ist nicht nötig

B Lipidemulsion (20 %) als Bolus + Infusion nach Schema, Atemweg/O_2 sichern, Krampf durchbrechen (Benzodiazepin)

3 KREISLAUFSTILLSTAND

Es kommt zum (LAST-bedingten) Kreislaufstillstand. Was ist zu beachten?

A Hochdosiertes Standard-Adrenalin wie üblich

B Reanimation nach ALS, aber prolongiert (gute Prognose!), Lipidemulsion weiter, kleine Adrenalindosen, Amiodaron bei Bedarf

4 ÜBERWACHUNG

Nach ROSC – worauf achtest du?

A Nach Stabilisierung rasch entlassen

B Längere Intensivüberwachung (Rezidivgefahr!), Rhythmus/Kreislauf, Neurostatus, Lipid nach Schema, Auslöser dokumentieren

Fall 33 · Flache Atmung im Aufwachraum

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Im Aufwachraum nach Allgemeinanästhesie: Patient zunehmend somnolent, flache langsame Atmung (AF 6), SpO_2 88 %, enge Pupillen; intraoperativ Opioide.

1 ERSTES VORGEHEN

Erste Maßnahme bei postoperativer Atemdepression?

(A) Stimulieren/ansprechen, Atemweg freimachen, 100 % O_2, zur Atmung auffordern, Monitoring, Hilfe

(B) Patienten schlafen lassen, er ist nur müde

(C) Sofort hochdosiert Naloxon als großer Bolus

2 URSACHE/THERAPIE

Verdacht auf Opioidüberhang. Vorgehen (AO)?

(A) Naloxon titriert (kleine Schritte) nach AO, dabei O_2/Beatmung sichern; an Relaxansüberhang/andere Ursachen denken

(B) Nur O_2 geben, sonst nichts

3 DIFFERENZIAL

Nach Naloxon bessert sich die Atmung nur teilweise; der Patient ist schwach, kann den Kopf nicht halten. Verdacht?

(A) Sicher nur noch müde, abwarten

(B) Relaxansüberhang (Restkurarisierung) → TOF/Relaxometrie, ggf. Antagonisierung nach AO, weiter O_2/Beatmungsbereitschaft

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

(A) Nach kurzer Besserung sofort auf Station verlegen

(B) AF/SpO_2/Vigilanz, Re-Sedierung beachten (Naloxon kürzer wirksam als Opioid!), Muskelkraft/TOF, Schmerz, Kreislauf

Fall 34 · Kreislauf nach Spinalanästhesie

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Kurz nach Spinalanästhesie: RR fällt auf 80/45, Bradykardie 48/min, Übelkeit/Schwindel; die sensible Blockade steigt höher als erwartet.

1 ERSTES VORGEHEN

Erste Maßnahmen bei Hypotonie/Bradykardie nach Spinalanästhesie?

A Patienten aufsetzen, damit ihm nicht schwindelig wird

B Beine hoch / Linksseitenlage (bei Schwangeren!), O_2, Volumen nach AO, Vasopressor (z. B. Akrinor/Ephedrin/Noradrenalin) nach AO, Monitoring

C Erst abwarten, der Druck reguliert sich

2 BRADYKARDIE

Die Bradykardie nimmt zu (40/min) mit Hypotonie. Vorgehen (AO)?

A Atropin nach AO gegen die Bradykardie, Vasopressor/Volumen weiter, O_2, engmaschig Monitoring

B Nur weiter Volumen, Bradykardie ignorieren

3 AUFSTEIGENDE BLOCKADE

Der Patient klagt über Atemnot und Kribbeln in den Händen, die Blockade steigt weiter. Reaktion?

A Beruhigen und weiter beobachten

B Atemweg/O_2 sichern, Beatmungsbereitschaft (Atemmuskulatur!), Kreislauf weiter stützen, Anästhesist/Notfallteam, ggf. Intubation

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

A RR/HF, Atmung/SpO_2, Blockadehöhe/Sensomotorik, Bewusstsein, Übelkeit, Rückbildung der Blockade

B Nur den Blutdruck einmal messen

Fall 35 · Vorbereitung zur Narkose

Routine · niedrig | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Frau D., 60 J., soll heute operiert werden. Du bereitest sie für den OP vor.

1 IDENTITÄT

Wie startest du die Vorbereitung?

- A Nur nach dem Namen fragen
- B Identität sichern, Nüchternheit prüfen und kontrollieren, ob Aufklärung/Einwilligung vorliegen
- C Sie ohne Prüfung in den OP fahren

2 CHECKLISTE

Was gehört zur OP-Vorbereitung?

- A Schmuck darf drangelassen werden
- B Allergien nicht erfragen
- C Schmuck, Prothesen und Nagellack entfernen, OP-Hemd, Allergien erfragen

3 ANGST

Frau D. ist sehr ängstlich. Wie reagierst du?

- A Zuwenden, verständlich informieren, beruhigen, Prämedikation nur nach Anordnung
- B Das Thema übergehen
- C Ihr sagen, sie solle sich nicht so anstellen

4 ÜBERGABE

Wie schließt du die Vorbereitung ab?

- A Nur das Wichtigste mündlich nennen
- B Vollständige Übergabe an das OP-Team und sorgfältige Dokumentation

Psychiatrie

7 Fälle

Fall 36 · Hoffnungslosigkeit und Rückzug

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient auf Station wirkt zunehmend zurückgezogen, äußert Hoffnungslosigkeit ('Es hat alles keinen Sinn mehr') und zieht sich von Mitpatienten zurück. Du bist im Gespräch mit ihm.

1 HALTUNG

Wie reagierst du auf die Hoffnungslosigkeit?

A Aufmuntern ('So schlimm ist es doch nicht') und das Thema wechseln

B Ruhig, zugewandt, ernst nehmen, Zeit nehmen, offen und ohne Wertung nachfragen, wie es ihm geht

C Ihn allein lassen, damit er zur Ruhe kommt

2 OFFEN ANSPRECHEN

Wie gehst du mit dem Verdacht auf Suizidalität um?

A Suizidgedanken offen, einfühlsam und direkt ansprechen

B Das Thema meiden, um ihn nicht 'auf Ideen zu bringen'

3 SICHERHEIT

Er bejaht Suizidgedanken. Was ist jetzt wichtig?

A Bei ihm bleiben/Betreuung sicherstellen, Arzt/zuständiges Team umgehend informieren, für eine sichere Umgebung sorgen

B Ihm versprechen, dass es ein Geheimnis bleibt

4 WEITERES VORGEHEN

Wie geht es im Verlauf weiter?

A Nach dem ersten Gespräch wie gewohnt weiterarbeiten

B Engmaschige Betreuung nach Anordnung, sichere Umgebung, im Gespräch bleiben, Dokumentation, ärztliche Einschätzung/Therapieplanung umsetzen

Fall 37 · Angespannter, gereizter Patient

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein akut psychotischer Patient ist zunehmend angespannt, läuft auf und ab, spricht laut, fühlt sich bedroht und reagiert gereizt auf Ansprache. Andere Patienten werden unruhig.

1 ERSTE REAKTION

Wie gehst du auf den erregten Patienten zu?

(A) Ruhig und respektvoll, Distanz wahren, reizarme Umgebung schaffen, ruhige Stimme, Bedürfnisse erfragen (Deeskalation)

(B) Bestimmt und laut Grenzen setzen, ihn zur Ruhe ermahnen

(C) Ihn festhalten, damit er sich beruhigt

2 DEESKALATION

Womit deeskalierst du weiter?

(A) Über seine Wahninhalte diskutieren und sie widerlegen

(B) Zuhören, ernst nehmen, einfache klare Sätze, Wahlmöglichkeiten anbieten, Sicherheit signalisieren, Fluchtweg/ Eigenschutz beachten

3 SICHERHEIT/TEAM

Die Erregung bleibt hoch, eine Gefährdung ist möglich. Vorgehen?

(A) Team hinzuziehen, Eigen- und Fremdschutz sichern, Arzt informieren, Medikation nach AO anbieten, weiter deeskalieren

(B) Allein mit ihm im Raum bleiben und weiter reden

4 LETZTES MITTEL / RECHT

Wenn freiwillige Maßnahmen nicht ausreichen und akute Gefahr besteht – was gilt?

(A) Eigenständig fixieren, ohne weitere Formalitäten

(B) Freiheitsentziehende Maßnahmen nur als letztes Mittel bei akuter Gefahr, ärztliche Anordnung, rechtliche Voraussetzungen (Unterbringungsrecht/PsychKG), engmaschige Überwachung und Dokumentation

Fall 38 · Getriebene, rastlose Patientin

subakut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine Patientin in manischer Episode ist getrieben, redet ununterbrochen, schläft kaum, hat überschießende Pläne, kaum Krankheitseinsicht, gibt viel Geld aus, überschätzt sich und reagiert gereizt auf Grenzen.

1 HALTUNG

Wie begegnest du ihr?

A Mit strengen Verboten und Konfrontation Grenzen setzen

B Ruhig, wertschätzend, klare einfache Struktur, reizarme Umgebung, Beziehung halten, nicht provozieren

C Auf alle Pläne enthusiastisch eingehen und sie bestärken

2 SCHUTZ/STRUKTUR

Worauf achtest du im Alltag?

A Reizarme Umgebung, Tagesstruktur, Schlaf fördern, vor riskanten Folgen schützen (z. B. finanzielle/soziale Selbstgefährdung), Essen/Trinken anbieten

B Ihr volle Freiheit lassen, sie weiß schon, was sie tut

3 KÖRPERLICHES

Sie isst/trinkt kaum und ist ständig in Bewegung. Risiko?

A Auf Erschöpfung, Dehydratation und Mangelernährung achten, Vitalzeichen/Allgemeinzustand beobachten, Grundbedürfnisse anbieten, Arzt informieren

B Nur das Verhalten beobachten, Körperliches ist hier nebensächlich

4 THERAPIE/RECHT

Sie lehnt Medikamente und Klinik ab, gefährdet sich aber. Vorgehen?

A Medikamente heimlich untermischen

B Beziehung/Motivation, Medikation nach AO anbieten; bei akuter Selbst-/Fremdgefährdung ärztliche Einschätzung, ggf. Unterbringungsrecht (PsychKG) als letztes Mittel, Schutz und Dokumentation

Fall 39 · Tremor und Unruhe ohne Alkohol

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient (bekannte Alkoholabhängigkeit), seit etwa 1 Tag ohne Alkohol: Tremor, Schwitzen, Unruhe, Tachykardie, leicht erhöhter Blutdruck, Übelkeit; er ist ängstlich-gereizt.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du die Symptome ein und reagierst zuerst?

(A) Symptome als reine Nervosität abtun

(B) Alkoholentzugssyndrom erkennen, ruhig zuwenden, Vitalzeichen, Schweregrad einschätzen (z. B. Skala), Arzt informieren

(C) Ihm Alkohol geben, damit es ihm besser geht

2 THERAPIE/PROPHYLAXE

Was ist Teil der Behandlung (AO)?

(A) Nur abwarten, das geht von allein vorbei

(B) Medikamentöse Entzugsbehandlung nach Schema (z. B. Benzodiazepine), Thiamin (Vitamin B1) zur Wernicke-Prophylaxe, Flüssigkeit/Elektrolyte, engmaschige Überwachung

3 KOMPLIKATIONEN

Worauf achtest du, um Komplikationen früh zu erkennen?

(A) Nur den Tremor beobachten

(B) Auf Delirzeichen (Desorientierung, Halluzinationen, starke vegetative Entgleisung) und Krampfanfälle achten, Vitalzeichen/Bewusstsein engmaschig, reizarme sichere Umgebung, Sturz-/Eigenschutz

4 ÜBERWACHUNG

Wie gestaltest du die Betreuung?

(A) Nach Symptomlinderung die Überwachung beenden

(B) Engmaschige Überwachung (Skala/Vitalzeichen), ruhige reizarme Umgebung, Orientierung geben, Flüssigkeit/Ernährung, Medikation nach Schema, Dokumentation; bei Verschlechterung Arzt/Intensiv

Fall 40 · Plötzliche Atemnot und Todesangst

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine Patientin bekommt plötzlich Herzrasen, Atemnot, Engegefühl in der Brust, Kribbeln in den Händen, Schwindel und Todesangst ('Ich bekomme keine Luft, ich glaube, ich sterbe'); sie hyperventiliert.

1 ERSTE REAKTION

Wie reagierst du?

A Ruhig und präsent bleiben, beruhigend ansprechen, bei ihr bleiben, Sicherheit vermitteln, langsames Atmen anleiten

B Hektisch viele Geräte anschließen und Aufregung zeigen

C Ihr sagen, sie solle sich zusammenreißen, es sei nichts

2 SOMATIK BEDENKEN

Woran denkst du trotz wahrscheinlicher Panikattacke?

A Bedrohliche körperliche Ursachen im Blick behalten (z. B. Herz/Atmung), Vitalzeichen/SpO_2 prüfen, im Zweifel ärztlich abklären lassen

B Sicher nur psychisch, eine körperliche Abklärung ist überflüssig

3 ATEMFÜHRUNG

Sie hyperventiliert weiter. Wie hilfst du?

A Ruhig langsames Atmen vormachen/anleiten, Aufmerksamkeit lenken, beruhigen, bei ihr bleiben (kein Druck)

B Sie auffordern, kräftig und schnell weiterzuatmen

4 NACHSORGE

Die Attacke klingt ab. Was ist sinnvoll?

A Da bleiben, Erlebtes besprechen/normalisieren, über Panikattacken aufklären, Auslöser/Hilfe thematisieren, Behandlungsteam einbeziehen, dokumentieren

B Sofort allein lassen, ist ja vorbei

Fall 41 · Fieber und Rigor unter Neuroleptika

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient unter Neuroleptika (kürzlich Dosissteigerung) entwickelt hohes Fieber, ausgeprägte Muskelsteifigkeit (Rigor), Bewusstseinstrübung, Schwitzen, Tachykardie und schwankenden Blutdruck.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Verdacht auf malignes neuroleptisches Syndrom (MNS), Notfall: Vitalzeichen, Arzt/Hilfe sofort, Monitoring, an Absetzen des Neuroleptikums denken

(B) Die Neuroleptika-Dosis weiter erhöhen

(C) Fieber als Infekt behandeln und abwarten

2 SOFORTMASSNAHMEN

Was ist jetzt wichtig (AO)?

(A) Nur fiebersenkende Tabletten geben

(B) Auslösendes Neuroleptikum absetzen (nach AO), Vitalfunktionen sichern, kühlen, Flüssigkeit/Elektrolyte, engmaschiges Monitoring, Intensiv vorbereiten

3 KOMPLIKATIONEN

Worauf achtest du wegen drohender Komplikationen?

(A) Komplikationen sind unwahrscheinlich, nur Temperatur messen

(B) Auf Rhabdomyolyse/Nierenversagen (CK, dunkler Urin), Elektrolytentgleisung, Kreislauf-/Atemkomplikationen achten, Bilanz, Labor nach AO

4 ÜBERWACHUNG

Wie geht es weiter?

(A) Intensivüberwachung, Vitalzeichen/Bewusstsein, Temperatur, CK/Niere/Elektrolyte, Flüssigkeit, weitere Therapie nach AO, Dokumentation

(B) Nach erster Fiebersenkung zurück auf Normalstation

Fall 42 · Das erste Gespräch

Routine · niedrig | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Herr A., 35 J., ist zurückgezogen und antriebslos. Du sollst eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen und ihn begleiten.

1 KONTAKT

Wie nimmst du Kontakt auf?

- A) Ihn betont fröhlich aufmuntern und zum Reden drängen
- B) Ruhig und wertschätzend Kontakt anbieten, Zeit geben und zuhören
- C) Ihn einfach in Ruhe lassen und nicht ansprechen

2 BEOBACHTUNG

Worauf achtest du im Verlauf?

- A) Gar nichts beobachten
- B) Stimmung, Antrieb, Tagesstruktur sowie Essen und Trinken beobachten
- C) Nur darauf, ob er am Programm teilnimmt

3 TEAM

Im Gespräch deutet er Hoffnungslosigkeit an. Was tust du?

- A) Ihm versprechen, es für dich zu behalten
- B) Das Thema schnell wechseln
- C) Ihn ernst nehmen, zuhören und die Beobachtung umgehend im Team / an die Fachkraft weitergeben

4 BEGLEITUNG

Wie unterstützt du weiter?

- A) Tagesstruktur fördern, verlässlich da sein und dokumentieren
- B) Ihn sich selbst überlassen

Pflegegrundlagen

8 Fälle

Fall 43 · Wundliegen vorbeugen

Grundlagen · 1. Ausbildungsjahr

Frau Klein (84) ist nach einem Sturz bettlägerig, kann sich kaum selbst bewegen und liegt viel auf dem Rücken. Die Haut am Gesäß ist an einer Stelle gerötet.

1 BEOBACHTEN

Du entdeckst die Rötung am Steiß. Wie prüfst du, ob ein Dekubitus droht?

(A) Fingertest: kurz auf die Rötung drücken – wird sie weiß (wegdrückbar) oder bleibt sie rot? Hautstelle dokumentieren und melden

(B) Die Stelle kräftig massieren, um die Durchblutung anzuregen

(C) Erstmal abwarten, Rötungen verschwinden meist von allein

2 VORBEUGEN

Was ist die wichtigste vorbeugende Maßnahme?

(A) Regelmäßige Druckentlastung: Position nach Plan wechseln, Druckstellen frei lagern, Haut pflegen und trocken halten

(B) Ein dickes Kissen genau punktuell unter die gerötete Stelle legen

3 RESSOURCEN FÖRDERN

Frau Klein kann sich ein wenig mitbewegen. Wie gehst du vor?

(A) Ihr alles abnehmen, sie soll sich gar nicht anstrengen

(B) Eigenbewegung fördern, zu kleinen Lagewechseln anleiten, Bewegung in den Alltag einbauen, Maßnahmen dokumentieren

Fall 44 · Sicher auf den Beinen

Grundlagen | 1. Ausbildungsjahr

Herr Berg (78) ist nach einem Infekt geschwächt, etwas unsicher beim Gehen und möchte nachts allein zur Toilette. Der Boden ist teils mit Kabeln und einem Teppich belegt.

1 EINSCHÄTZEN

Wie schätzt du das Sturzrisiko ein und reagierst?

A Risiko erkennen (Schwäche, Unsicherheit, nächtlicher Toilettengang), Umfeld sichern, Maßnahmen mit ihm besprechen, im Team melden/dokumentieren

B Nichts tun, er ist erwachsen und entscheidet selbst

C Ein Bettgitter hochziehen und ihn nachts 'im Bett halten'

2 UMFELD SICHERN

Was ist eine sinnvolle Maßnahme?

A Den Toilettengang verbieten und einen Dauerkatheter vorschlagen

B Stolperfallen beseitigen (Kabel/Teppich), Nachtlicht, Rufanlage in Reichweite, Gehhilfe bereitstellen, Weg frei halten

3 BEGLEITEN

Nachts klingelt er, um zur Toilette zu gehen. Wie gehst du vor?

A Sagen, er soll schnell allein gehen, du hast keine Zeit

B Zeitnah kommen, beim Aufstehen/Gehen begleiten, Tempo anpassen, festes Schuhwerk/Gehhilfe nutzen, Selbstständigkeit fördern

Fall 45 · Werte deuten und melden

Grundlagen · 1. Ausbildungsjahr

Bei der Routinekontrolle von Frau Sander (70, 2. Tag nach OP) misst du: Temperatur 38,9 °C, Puls 104/min. Sie wirkt matt und klagt über Unwohlsein.

1 BEOBACHTEN

Wie gehst du mit dem auffälligen Wert um?

A Den Wert ignorieren, eine einzelne Messung sagt nichts aus

B Werte vollständig erfassen (Temp, Puls, RR, Atmung, ggf. SpO_2), Allgemeinzustand beobachten, dokumentieren und zeitnah an Pflegefachkraft/Arzt melden

C Eigenmächtig ein fiebersenkendes Medikament aus dem Schrank geben

2 MELDEN

Was gehört zu einer guten Weitergabe?

A Strukturiert melden: wer/was/seit wann, gemessene Werte, Allgemeinzustand, Auffälligkeiten – sachlich und vollständig

B Nur kurz 'der geht's nicht gut' sagen, ohne Werte

3 ÜBERWACHEN

Bis zur ärztlichen Anordnung – wie verhältst du dich?

A Patientin im Blick behalten, Werte nach Vorgabe erneut kontrollieren, auf Verschlechterung achten, für Wohlbefinden sorgen, dokumentieren

B Dich anderem zuwenden und nicht mehr nachschauen

Fall 46 · Ankommen und Vertrauen schaffen

Grundlagen · 1. Ausbildungsjahr

Frau Yilmaz (68) wird zur geplanten OP aufgenommen. Sie wirkt angespannt, spricht leise, hat viele Fragen und schämt sich, dass sie Hilfe braucht.

1 BEGEGNUNG

Wie gestaltest du das Aufnahmegespräch?

A Schnell die Checkliste abarbeiten und Fragen abwürgen, du hast viel zu tun

B Sich vorstellen, freundlich zugewandt sein, Zeit nehmen, aktiv zuhören, in verständlicher Sprache erklären, Fragen ernst nehmen

C Über ihren Kopf hinweg mit den Angehörigen reden statt mit ihr

2 VERSTÄNDNIS SICHERN

Sie versteht einen Fachbegriff nicht. Wie reagierst du?

A In einfacher Sprache erklären, nachfragen ob es verständlich war, bei Sprachbarriere Hilfen anbieten (z. B. Dolmetscher nach Möglichkeit)

B Den Begriff genauso wiederholen, nur lauter

3 WÜRDE

Sie schämt sich, dass sie beim Umziehen Hilfe braucht. Wie gehst du vor?

A Verständnis zeigen, Intimsphäre wahren (Sichtschutz, ruhig erklären), Selbstständigkeit fördern, nur so viel helfen wie nötig

B Es als 'nicht so schlimm' abtun und einfach loslegen

Fall 47 · Körperpflege mit Würde

Grundlagen · 1. Ausbildungsjahr

Du unterstützt Herrn Os (80) bei der morgendlichen Körperpflege. Gesicht und Arme kann er selbst waschen, am Rücken und an den Beinen braucht er Hilfe.

1 HALTUNG

Wie gehst du die Körperpflege an?

(A) Ressourcen nutzen: ihn selbst waschen lassen, was er kann; nur unterstützen, wo nötig; vorher erklären und Einverständnis einholen

(B) Bei offener Tür und ohne Vorankündigung loslegen

(C) Alles komplett übernehmen, das geht schneller

2 INTIMSPHÄRE

Worauf achtest du während der Pflege?

(A) Ihn länger unbedeckt liegen lassen und nebenbei mit Kollegen plaudern

(B) Sichtschutz, nur den Bereich freilegen, der gewaschen wird, angenehme Wassertemperatur, Privatsphäre schützen, Hautzustand beobachten

3 BEOBACHTEN

Beim Waschen fällt dir eine gerötete Hautstelle am Rücken auf. Wie reagierst du?

(A) Hautstelle beobachten/dokumentieren, melden, auf Druckentlastung achten, Pflege schonend fortsetzen

(B) Nichts sagen, das ist sicher nichts

Fall 48 · Atmen nach der OP

Grundlagen | 1. Ausbildungsjahr

Frau Lang (72) liegt nach einer Bauch-OP im Bett. Wegen Schmerzen atmet sie flach, hustet kaum und möchte nur liegen bleiben.

1 RISIKO ERKENNEN

Warum ist das ein Problem und was tust du?

A Ihr eigenmächtig ein Hustenmittel geben, damit Ruhe ist

B Sie liegen und flach atmen lassen, Schonung ist am besten

C Pneumoniegefahr erkennen (flache Atmung, wenig Husten, Immobilität) – Atmung fördern: aufrechte Position, zu tiefem Atmen anregen, Schmerz ansprechen/melden

2 MASSNAHMEN

Welche Maßnahme fördert die Belüftung der Lunge?

A Oberkörper hoch/aufsetzen, tiefe Atemzüge und Abhusten anleiten, Atemübung/Hilfsmittel nach Vorgabe, regelmäßig mobilisieren

B Sie flach hinlegen und die Decke fest bis zum Hals ziehen

3 SCHMERZ & MOBILISATION

Sie traut sich wegen Schmerzen nicht zu husten oder zu bewegen. Wie hilfst du?

A Ihr sagen, sie soll sich zusammenreißen

B Schmerz ernst nehmen und melden (Therapie nach AO), Wunde beim Abhusten stützen lassen, schrittweise mobilisieren, motivieren

Fall 49 · Genug trinken im Alter

Grundlagen · 1. Ausbildungsjahr

Frau Vogt (86) im Pflegeheim wirkt müder als sonst, ihre Lippen sind trocken, die Haut steht in einer Falte kurz 'stehen', und sie hat heute kaum etwas getrunken.

1 BEOBACHTEN

Welche Zeichen deuten auf Flüssigkeitsmangel und wie reagierst du?

(A) Exsikkose-Zeichen erkennen (trockene Schleimhäute, stehende Hautfalte, Müdigkeit, wenig Trinken), Trinken anbieten, Ein-/Ausfuhr im Blick, melden/dokumentieren

(B) Davon ausgehen, dass alte Menschen eben wenig brauchen

(C) Abwarten, vielleicht trinkt sie später von allein

2 TRINKEN FÖRDERN

Wie förderst du, dass sie mehr trinkt?

(A) Sie zwingen, schnell einen Liter auf einmal zu trinken

(B) Lieblingsgetränke in Reichweite, regelmäßig kleine Mengen anbieten und erinnern, beim Trinken helfen, Trinkmenge erfassen

3 MELDEN

Trotz Angebot trinkt sie weiterhin sehr wenig und wird zunehmend matt. Wie gehst du vor?

(A) Es bei dir behalten und nichts melden

(B) An Pflegefachkraft/Arzt melden, Beobachtungen dokumentieren, weiter Trinken anbieten, auf Verschlechterung achten

Fall 50 · Wenn der Appetit fehlt

Grundlagen · 1. Ausbildungsjahr

Herr Frey (79) lässt seit Tagen viel auf dem Teller liegen, hat an Gewicht verloren und sagt, das Essen schmecke ihm nicht und das Kauen falle schwer.

1 BEOBACHTEN

Wie gehst du mit den Hinweisen auf Mangelernährung um?

A Ihn drängen, den Teller schnell leer zu essen

B Den vollen Teller einfach kommentarlos abräumen

C Warnzeichen erkennen (wenig Essen, Gewichtsverlust, Kauprobleme), Essmenge/Gewicht beobachten und dokumentieren, Ursachen ansprechen, melden

2 ANPASSEN

Was hilft konkret bei fehlendem Appetit und Kauproblemen?

A Wünsche/Vorlieben berücksichtigen, Konsistenz anpassen (z. B. weiche Kost), kleine appetitliche Portionen, in Ruhe und aufrecht essen, ggf. Hilfsmittel

B Immer dasselbe in großer Menge servieren

3 MELDEN & BEGLEITEN

Trotzdem isst er weiter wenig und nimmt ab. Wie gehst du vor?

A Es als 'Alter' hinnehmen und nichts weiter tun

B An Pflegefachkraft/Arzt melden, Essprotokoll/Gewicht dokumentieren, weitere Maßnahmen nach Vorgabe, weiter unterstützen

Neurologie

7 Fälle

Fall 51 · Plötzliche Halbseitensymptomatik

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient zeigt plötzlich eine hängende Mundpartie, einseitige Armschwäche und verwaschene Sprache. Symptombeginn vor ca. 40 Minuten.

1 ERKENNEN

Wie reagierst du zuerst?

A Erst abwarten, ob sich die Symptome von selbst bessern

B FAST erkennen (Face/Arm/Speech/Time), sofort Stroke-Unit/Notfall alarmieren, genauen Symptombeginn (Zeitfenster!) feststellen, Vitalzeichen, nüchtern lassen

C Dem Patienten zur Beruhigung etwas zu trinken geben

2 DIAGNOSTIK

Was ist jetzt wichtig (AO)?

A Rasch CT/Bildgebung (Blutung vs. Ischämie), BZ messen, Vitalzeichen/SpO_2, i.v.-Zugang, auf Lyse/Thrombektomie vorbereiten

B Sofort den Blutdruck stark senken

3 SCHLUCKEN & LAGERUNG

Worauf achtest du in der Pflege?

A Flach lagern und normal Essen anbieten

B Nüchtern bis zum Schluck-Screening, Oberkörper ~30°, SpO_2/O_2 nach AO, engmaschiger Neurostatus, Aspirations- und Sturzschutz

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du im Verlauf?

A Nur einmal den Blutdruck messen

B Neurostatus, Vitalzeichen/BZ, SpO_2, Schluckfunktion, auf Verschlechterung (Einblutung/Hirndruck) achten, Zeitprotokoll führen

Fall 52 · Anhaltender Krampfanfall

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient krampft generalisiert tonisch-klonisch; der Anfall dauert bereits über 5 Minuten an und sistiert nicht.

1 SOFORTMASSNAHMEN

Erstes Vorgehen beim anhaltenden Krampfanfall?

(A) Patient vor Verletzung schützen, nichts in den Mund, soweit möglich Seitenlage, Atemweg/O_2, Dauer messen, Hilfe rufen

(B) Erst abwarten, Anfälle hören meist von allein auf

(C) Den Patienten festhalten und die Zunge mit einem Spatel sichern

2 THERAPIE

Vorgehen (AO)?

(A) Benzodiazepin nach Notfallschema/AO, BZ messen, i.v.-Zugang, O_2, Monitoring, Reanimationsbereitschaft

(B) Sofort hochdosiert mehrere Medikamente gleichzeitig geben

3 NACH DEM ANFALL

Der Anfall sistiert. Worauf achtest du?

(A) Sofort mobilisieren und Essen anbieten

(B) Atemweg/Atmung/SpO_2 (postiktale/medikamentöse Atemdepression), Seitenlage, BZ/Vitalzeichen, Ursache abklären, auf erneuten Anfall vorbereitet sein

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Vigilanz/Atmung/SpO_2/BZ überwachen, auf erneuten Anfall achten, Auslöser/Antikonvulsiva nach AO, Dokumentation, Sturzschutz

(B) Die Überwachung sofort beenden

Fall 53 · Vernichtungskopfschmerz

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient klagt über einen plötzlichen, noch nie erlebten 'Vernichtungskopfschmerz' (Donnerschlag), dazu Übelkeit, Nackensteife und Lichtscheu.

1 ERKENNEN

Erstes Vorgehen?

(A) An Subarachnoidalblutung denken (Donnerschlagkopfschmerz!), sofort Arzt/Notfall, Vitalzeichen/Bewusstsein, Ruhe und Reizabschirmung

(B) Als gewöhnliche Migräne einordnen, Schmerzmittel geben und abwarten

2 DIAGNOSTIK

Wie weiter (AO)?

(A) Rasche Bildgebung (CT), Vitalzeichen/Neurostatus, Blutdruckmanagement nach AO, reizarme Umgebung, Monitoring

(B) Den Patienten mobilisieren und Pressen/Anstrengung erlauben

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Strenge Ruhe, Reizabschirmung (Licht/Lärm), Oberkörper leicht hoch, Blutdruck-/Neuromonitoring, Stuhlregulierung (Pressen vermeiden), auf Vigilanzabfall achten

(B) Helles Licht und Aktivierung zur Orientierung

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Engmaschig Bewusstsein/Pupillen/Vitalzeichen, auf Nachblutung/Hirndruck/Vasospasmus achten, Bilanz, Intensivüberwachung

(B) Nur den Schmerz dokumentieren

Fall 54 · Eintrübung mit weiter Pupille

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient mit bekannter intrakranieller Raumforderung wird zunehmend somnolent, klagt über Kopfschmerz und Erbrechen; eine Pupille wird weiter, der Blutdruck steigt, der Puls wird langsam.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Zeichen erhöhten Hirndrucks/drohender Einklemmung (Vigilanzabfall, weite Pupille, Cushing-Reflex: RR hoch/Puls langsam) – Notfall, sofort Arzt, Vitalzeichen/Pupillen, Oberkörper ~30° (Kopf gerade)

(B) Als Müdigkeit deuten und schlafen lassen

2 MASSNAHMEN

Was ist wichtig (AO)?

(A) Kopf tief und flach lagern

(B) Oberkörper ~30° hoch, Kopf in Mittelstellung (venösen Abfluss sichern), O_2/Atemweg, hirndrucksteigernde Faktoren meiden, Bildgebung/Intensiv, Medikamente nach AO

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Den Patienten kräftig stimulieren und ohne Schutz absaugen

(B) Engmaschig Bewusstsein (GCS)/Pupillen/Vitalzeichen, hirndrucksteigernde Faktoren minimieren (Pressen, Husten, Schmerz, Abknicken des Halses), reizarm, O_2/Normoventilation nach AO

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Kontinuierlich GCS/Pupillen/Vitalzeichen, auf weitere Verschlechterung/Einklemmung achten, Intensiv, Dokumentation, Arzt sofort bei Veränderung

(B) Nur stündlich den Blutdruck messen

Fall 55 · Zunehmende Muskelschwäche

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Eine Patientin mit Myasthenia gravis ist zunehmend geschwächt, hat Schluckbeschwerden, eine schwache, näselnde Sprache, Doppelbilder und zunehmende Atemnot.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Zur Stärkung erst eine größere Mahlzeit anbieten

B Verdacht auf myasthene Krise (zunehmende Muskel-/Atemschwäche): Atmung/SpO_2/Schlucken beobachten, Arzt sofort, Aspiration vermeiden (nüchtern bei Schluckstörung), Beatmungsbereitschaft

2 ATMUNG ÜBERWACHEN

Worauf liegt der Fokus (AO)?

A Atemfunktion engmaschig (Atemfrequenz, SpO_2, Vitalkapazität), Zeichen der respiratorischen Erschöpfung erkennen, O_2/Beatmungsbereitschaft, Intensiv, Medikation nach AO

B Nur einmal die SpO_2 messen und die Patientin allein lassen

3 PFLEGE

Worauf achtest du noch?

A Aspirationsschutz (Schluckstörung!), Oberkörper hoch, Kräfte schonen (Belastung dosieren), Kommunikation sichern, Medikamente exakt nach AO, auf Verschlechterung achten

B Zur Mobilisation maximal fordern

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Atmung/SpO_2/Vitalkapazität/Schlucken engmaschig, Beatmungsbereitschaft, Medikation nach AO, Intensiv, Dokumentation

B Überwachung reduzieren, sobald es etwas besser wirkt

Fall 56 · Rückenschmerz mit Taubheit

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Patient mit starken Rückenschmerzen berichtet neu über Taubheit im Reithosenbereich (Damm/Innenseite Oberschenkel), Schwäche in den Beinen und kann seit Stunden kein Wasser mehr lassen.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Als gewöhnliche Rückenschmerzen mit Schonung und Schmerzmittel abtun

B Red Flags für ein Cauda-equina-Syndrom (Reithosenanästhesie, Blasenentleerungsstörung, Beinschwäche) – neurochirurgischer Notfall, sofort Arzt, Neurostatus, nicht abwarten

2 DIAGNOSTIK

Wie weiter (AO)?

A Erst einige Tage konservativ abwarten

B Dringende Bildgebung (MRT), neurologische Befunde dokumentieren (Sensibilität/Kraft/Blase-Mastdarm), Blasenfunktion prüfen (Restharn), rasche neurochirurgische Vorstellung

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Neurostatus engmaschig (Zunahme der Ausfälle?), Blasenfunktion/Restharn beobachten (ggf. Katheter nach AO), Schmerzmanagement, OP-Vorbereitung, Haut-/Dekubitus- und Sturzschutz

B Nur Schmerzmittel geben, die neurologischen Zeichen sind nebensächlich

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Engmaschig Sensibilität/Kraft/Blase-Mastdarm, auf Zunahme achten, OP-Vorbereitung/Dringlichkeit, Dokumentation, Arzt bei Verschlechterung

B Abwarten bis zur Routinevisite

Fall 57 · Sturzgefahr nach Schlaganfall

Routine · mittel | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Herr B., 68 J., nach Schlaganfall halbseitig geschwächt, möchte allein zur Toilette aufstehen. Du bist im Zimmer.

1 SOFORTREAKTION

Wie reagierst du?

A) Ihn allein gehen lassen, er kennt sich ja

B) Ihn vorsichtshalber im Bett festbinden

C) Hilfe anbieten, ihn nicht allein aufstehen lassen, Klingel in Reichweite legen

2 TRANSFER

Wie unterstützt du den Toilettengang?

A) Ihn auf Socken laufen lassen

B) Zu zweit oder mit Hilfsmittel, betroffene Seite sichern, festes Schuhwerk

C) Ihn schnell allein ziehen, geht schon

3 BEOBACHTUNG

Worauf achtest du bei ihm?

A) Nur die Gehstrecke notieren

B) Nichts beobachten

C) Orientierung, Sprache und Schluckvermögen beobachten und Auffälligkeiten melden

4 UMGEBUNG

Wie sicherst du die Umgebung?

A) Nur die Bremsen am Bett prüfen

B) Hindernisse entfernen, Licht an, Klingel erreichbar, dokumentieren

Onkologie

7 Fälle

Fall 58 · Fieber unter Chemotherapie

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient unter Chemotherapie (bekannte Neutropenie) bekommt Fieber 38,8 °C und Schüttelfrost; lokale Entzündungszeichen fehlen weitgehend.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Fieber bei Neutropenie = onkologischer Notfall: sofort Arzt, Vitalzeichen, Blutkulturen vor Antibiose nach AO, auf Sepsis achten

(B) Erst Fieber senken und bis zur nächsten Visite abwarten

2 THERAPIE

Was ist entscheidend (AO)?

(A) Auf das Ergebnis der Blutkultur warten, bevor Antibiotika gegeben werden

(B) Rasche kalkulierte Antibiotikagabe nach AO (zeitnah!), Blutkulturen/Fokussuche vorher nach AO, Volumen/Kreislauf, engmaschiges Monitoring

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Strenge Hygiene/Schutzisolation, Vitalzeichen engmaschig (Sepsiszeichen!), Infektionsquellen meiden, Bilanz, Temperatur, Patienten beobachten

(B) Besuch und gemeinsame Sanitärnutzung wie üblich erlauben

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach erster Fiebersenkung die Überwachung beenden

(B) Vitalzeichen/Temperatur engmaschig, auf Sepsis/Schock achten, Antibiose/Diagnostik nach AO, Bilanz, Intensiv bei Verschlechterung, Dokumentation

Fall 59 · Entgleisung nach Chemo-Start

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Kurz nach Beginn einer Chemotherapie (großer, rasch wachsender Tumor) wird der Patient zunehmend unwohl; im Labor stark erhöhtes Kalium, Phosphat und Harnsäure, erniedrigtes Kalzium, die Urinausscheidung sinkt.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Als harmlose Begleiterscheinung der Chemo werten und abwarten

B Verdacht auf Tumorlyse-Syndrom (Zellzerfall: Hyperkaliämie/-phosphatämie/-urikämie, Hypokalzämie, Nierengefahr) – Arzt sofort, Monitoring (EKG!), Bilanz, Vitalzeichen

2 THERAPIE

Was ist wichtig (AO)?

A Die Trinkmenge/Infusion reduzieren, um die Niere zu 'schonen'

B Ausreichende Hydrierung nach AO, Elektrolyte engmaschig, Hyperkaliämie behandeln nach AO, EKG-Monitoring, harnsäuresenkende Therapie nach AO, Bilanz/Nierenfunktion

3 PFLEGE

Worauf achtest du besonders?

A EKG/Herzrhythmus (Hyperkaliämie!), Vitalzeichen, Ein-/Ausfuhr und Nierenfunktion, Elektrolytkontrollen nach AO, auf Herzrhythmusstörungen/Tetanie achten

B Nur die Temperatur kontrollieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Engmaschig Elektrolyte/EKG/Nierenwerte/Bilanz, auf Verschlechterung achten, Therapie nach AO, ggf. Intensiv/Dialyse-Bereitschaft, Dokumentation

B Nach erster Besserung die Kontrollen einstellen

Fall 60 · Gestaute Halsvenen, Atemnot

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Patient mit bekanntem Thoraxtumor entwickelt eine zunehmende Schwellung von Gesicht und Hals, gestaute Halsvenen, Atemnot und ein Druckgefühl im Kopf, verstärkt im Liegen.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Den Patienten flach hinlegen, damit der Kreislauf stabil bleibt

(B) Verdacht auf obere Einflussstauung (Tumor komprimiert die V. cava superior) – Arzt informieren, Oberkörper hochlagern, O_2 nach AO, Atmung/Vitalzeichen, beruhigen

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Zugang/Blutdruckmessung am betroffenen, gestauten Arm anlegen

(B) Oberkörper hoch, O_2 nach AO, Atmung/SpO_2 überwachen, rasche Bildgebung/onkologische Therapieplanung nach AO, ruhige Umgebung, Medikamente nach AO

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Atmung/SpO_2 engmaschig, Oberkörper hoch, auf zunehmende Atemnot/Schwellung achten, Angst reduzieren, Zugänge eher untere Extremität/nach AO, Verlauf dokumentieren

(B) Zur Mobilisation flach lagern und Anstrengung fördern

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nur einmal die SpO_2 messen

(B) Atmung/SpO_2/Schwellung/Bewusstsein überwachen, auf Atemwegsverlegung/Hirndruckzeichen achten, Therapie nach AO, Intensiv bei Verschlechterung, Dokumentation

Fall 61 · Verwirrt und exsikkiert

subakut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine Patientin mit fortgeschrittenem Tumor wird zunehmend müde, verwirrt, klagt über Übelkeit, Verstopfung und starken Durst; sie hat viel Urin ausgeschieden und wirkt exsikkiert. Das Kalzium ist deutlich erhöht.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Die Verwirrtheit allein dem Tumorleiden zuschreiben und abwarten

(B) Verdacht auf maligne Hyperkalzämie (Müdigkeit/Verwirrtheit, Übelkeit, Obstipation, Polyurie/Exsikkose) – Arzt, Vitalzeichen/Bewusstsein, Bilanz, Sturz-/Schutzmaßnahmen

2 THERAPIE

Was ist zentral (AO)?

(A) Die Trinkmenge wegen der Polyurie einschränken

(B) Ausreichende Hydrierung/Volumengabe nach AO (Exsikkose!), Elektrolyte/EKG, kalziumsenkende Therapie nach AO, Bilanz/Nierenfunktion, Bewusstsein

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Bewusstsein/Vitalzeichen/EKG, Ein-/Ausfuhr und Hydratation, Sturz-/Verwirrtheitsschutz, Obstipationsmanagement, Übelkeit behandeln nach AO, Mobilisation dosiert

(B) Die verwirrte Patientin unbeaufsichtigt mobilisieren lassen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Bewusstsein/Vitalzeichen/EKG/Kalzium/Bilanz engmaschig, auf Verschlechterung achten, Therapie nach AO, Dokumentation

(B) Nach leichter Besserung die Kontrollen einstellen

Fall 62 · Brennen an der Infusionsstelle

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Während einer laufenden Chemotherapie über einen peripheren Zugang klagt der Patient über Brennen und Schmerz an der Einstichstelle; dort zeigen sich Schwellung und Rötung, der Rücklauf ist fraglich.

1 SOFORTMASSNAHMEN

Erstes Vorgehen bei Verdacht auf ein Paravasat?

A Die Infusion einfach weiterlaufen lassen, das ist sicher harmlos

B Infusion sofort stoppen (Zugang zunächst belassen), Arzt informieren, Reste/Substanz nach Standard aspirieren, betroffene Stelle markieren, Extremität hochlagern

C Sofort die Kanüle ziehen und kräftig über die Stelle massieren

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO/Standard)?

A Substanzspezifische Maßnahmen nach Standard/AO (z. B. trockene Kälte oder Wärme je nach Substanz, ggf. Antidot), Foto-/Dokumentation, weitere Überwachung

B Pauschal immer warm auflegen, egal welche Substanz

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Die Stelle fest verbinden und nicht mehr ansehen

B Betroffene Stelle/Extremität beobachten und hochlagern, Schmerz behandeln nach AO, Verlauf/Hautbefund dokumentieren, auf Nekrose-/Komplikationszeichen achten, Patienten informieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Keine weitere Kontrolle nötig

B Hautbefund/Schmerz/Funktion im Verlauf kontrollieren, ggf. Fachstelle (z. B. plastische Chirurgie) nach AO, Dokumentation, Patientenedukation

Fall 63 · Plötzliche Schmerzkrise

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Tumorpatient mit fester Schmerz-Basismedikation hat plötzlich stark zunehmende Schmerzen (NRS 9), ist angespannt und kann kaum sprechen.

1 ERSTES VORGEHEN

Wie reagierst du auf den Durchbruchschmerz?

(A) Schmerz strukturiert erfassen (Stärke/Lokalisation/Auslöser), bei ihm bleiben, schnell wirksame Bedarfsmedikation nach AO geben, beruhigen, Lagerung

(B) Nur mit Atemübungen/Ablenkung arbeiten, keine Medikamente

(C) Auf die nächste planmäßige Gabe der Basismedikation warten

2 NACH DER GABE

Nach der Bedarfsmedikation – wie weiter (AO)?

(A) Sofort eigenständig die Dosis stark erhöhen und wiederholen

(B) Wirkung nach angemessener Zeit reevaluieren (NRS), bei unzureichender Wirkung nach AO nachsteuern, auf Nebenwirkungen (Sedierung/Atemdepression) achten

3 PFLEGE

Worauf achtest du noch?

(A) Vigilanz/Atmung (Opioid-Nebenwirkungen), Obstipations-/Übelkeitsprophylaxe nach AO, Ursache der Schmerzverstärkung bedenken, Dokumentation, Angst ernst nehmen

(B) Nach Linderung sind keine weiteren Beobachtungen nötig

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Schmerz/Atmung/Vigilanz reevaluieren, bei häufigem Durchbruchschmerz die Basismedikation mit dem Arzt überprüfen, Nebenwirkungen managen, Dokumentation

(B) Nur einmal nach dem Schmerz fragen

Fall 64 · Patientin unter Chemotherapie

Routine · mittel | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Frau W., 58 J., erhält eine Chemotherapie und ist dadurch infektanfällig. Du betreust sie und hast selbst einen leichten Schnupfen.

1 INFEKTIONSSCHUTZ

Wie gehst du mit deinem Schnupfen um?

- A Trotzdem ohne Maßnahmen pflegen
- B Maske nur tragen, wenn du daran denkst
- C Vorgesetzte informieren, Schutzmaßnahmen klären, strikte Händehygiene

2 GRUNDPFLEGE

Worauf achtest du in der Pflege besonders?

- A Mundpflege, Hautbeobachtung, Ernährung und Übelkeit beobachten
- B Mundpflege weglassen
- C Nur die Körperpflege durchführen

3 FIEBER

Frau W. bekommt 38,5 °C Fieber. Was bedeutet das?

- A Bei Abwehrschwäche ist Fieber ein Notfall – sofort melden
- B Abwarten und beobachten
- C Erst bei über 39 °C reagieren

4 ABSCHLUSS

Wie schließt du ab?

- A Nur das Fieber notieren
- B Einfühlsam kommunizieren, melden und dokumentieren

Urologie

7 Fälle

Fall 65 · Akuter Hodenschmerz

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein 16-jähriger Patient kommt mit plötzlich einsetzendem, heftigem einseitigem Hodenschmerz, Übelkeit und geschwollenem, hochstehendem Hoden. Beginn vor gut einer Stunde.

1 ERKENNEN

Wie reagierst du zuerst?

A Als harmlose Reizung abtun, kühlen und nach Hause schicken

B Erst etwas zu essen/trinken zur Beruhigung geben

C Verdacht auf Hodentorsion (plötzlicher heftiger Hodenschmerz, Schwellung, Übelkeit) – urologischer Notfall mit engem Zeitfenster, sofort Arzt/Urologie, nüchtern lassen (OP!), Vitalzeichen

2 DIAGNOSTIK

Wie weiter (AO)?

A Nur Schmerzmittel geben und den Verlauf abwarten

B Dringende urologische Abklärung (Doppler-Sonografie), nüchtern lassen, OP-Vorbereitung, Schmerz nach AO, Zeit dokumentieren

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Selbst versuchen, den Hoden 'zurückzudrehen'

B Nüchtern halten, OP-Vorbereitung, Schmerzmanagement nach AO, Patienten/Eltern informieren und beruhigen, Vitalzeichen, Dringlichkeit beachten (Hodenrettung zeitabhängig)

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Vitalzeichen/Schmerz, nüchtern, OP-Vorbereitung zügig, Zeitprotokoll, Patienten begleiten, bei Verschlechterung sofort Arzt

B Die Dringlichkeit unterschätzen und Zeit lassen

Fall 66 · Kein Wasserlassen möglich

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein älterer Patient kann seit vielen Stunden kein Wasser lassen, hat starke Unterbauchschmerzen und einen prall tastbaren, kugeligen Unterbauch; er ist unruhig.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Kräftig auf den Unterbauch drücken, damit es 'läuft'

B Abwarten, das kommt sicher von allein wieder

C Akuten Harnverhalt erkennen (kein Wasserlassen, praller Unterbauch/Blase, Schmerz), Vitalzeichen, Arzt informieren, Entlastung nach AO vorbereiten

2 ENTLASTUNG

Wie wird entlastet (AO)?

A Blasenkatheter nach AO legen (aseptisch), kontrolliert entlasten, Urinmenge erfassen, dokumentieren

B Die volle Blase auf einmal komplett und sehr schnell entleeren

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Ein-/Ausfuhr/Bilanz, Vitalzeichen, auf Entlastungsblutung/Kreislauf achten, Ursache abklären lassen, Patienten beruhigen

B Die abgelassene Urinmenge nicht erfassen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Nach Entlastung nicht weiter beobachten

B Urinfluss/Bilanz, Vitalzeichen, auf erneuten Harnverhalt achten, Ursache (z. B. Prostata) abklären lassen, dokumentieren

Fall 67 · Heftiger Flankenschmerz

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Patient krümmt sich mit plötzlichen, wellenartigen, sehr starken Flankenschmerzen, die in die Leiste ausstrahlen, dazu Übelkeit und ausgeprägte Bewegungsunruhe.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Eine begleitende Temperaturerhöhung gar nicht beachten

B An eine Nierenkolik (Harnstein) denken, Schmerz erfassen, Vitalzeichen/Temperatur, Arzt informieren, auf Fieber (Urosepsis-Zeichen) achten

C Als Rückenverspannung abtun und abwarten

2 THERAPIE

Wie weiter (AO)?

A Ohne Schmerztherapie einfach abwarten

B Analgesie/Spasmolyse nach AO (Wärme kann lindern), Urin auf Steinabgang sieben nach AO, Flüssigkeit nach AO, Temperatur überwachen

3 WARNZEICHEN

Worauf achtest du besonders?

A Schmerzverlauf, auf Fieber/Schüttelfrost (Urosepsis!) und Harnverhalt achten, Urin beobachten/sieben, Bilanz, bei Fieber sofort melden

B Auftretendes Fieber als 'normal' abtun

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Schmerz/Temperatur/Urin überwachen, auf Urosepsis-/Harnverhaltzeichen achten, Flüssigkeit/Therapie nach AO, dokumentieren

B Nur einmalig den Schmerz erfragen

Fall 68 · Katheter läuft nicht

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Bei einer Patientin mit Dauerkatheter kommt seit Stunden kaum noch Urin; sie klagt über Unterbauchdruck und Unruhe, der Unterbauch ist prall.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Katheterobstruktion vermuten (kein Urinfluss, praller Unterbauch, Druck), System prüfen (Abknickung, Lage, Beutel), Vitalzeichen, Arzt/AO beachten

(B) Abwarten, es läuft sicher gleich wieder

(C) Kräftig am Katheter ziehen

2 PROBLEMLÖSUNG

Wie gehst du vor (AO/Standard)?

(A) Einfache Ursachen beheben (Abknickung lösen, Beutel tiefer, Lage prüfen); bei fortbestehender Obstruktion Anspülen/Wechsel nach AO/Standard, aseptisch

(B) Sofort mit hohem Druck blind spülen, ohne Standard/AO

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Urinfluss/Menge, Unterbauch/Blase, Vitalzeichen, auf erneute Obstruktion achten, Bilanz, aseptisch arbeiten, dokumentieren

(B) Menge und Verlauf nicht dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach kurzem Fluss nicht weiter beobachten

(B) Urinfluss/Bilanz, Blase, Vitalzeichen, auf erneute Obstruktion/Harnverhalt achten, dokumentieren

Fall 69 · Blutiger Urin, plötzlich kein Abfluss

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient hat stark blutigen Urin mit Koageln; plötzlich kommt kein Urin mehr, der Unterbauch ist prall und schmerzhaft, der Patient ist unruhig und blass.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Abwarten, der blutige Urin hört sicher von allein auf

(B) Den Kreislauf/die Vitalzeichen nicht beachten

(C) Starke Makrohämaturie mit Blasentamponade vermuten (Koagel verlegen die Blase → Harnverhalt, praller Unterbauch), Vitalzeichen (Blutung/Kreislauf!), sofort Arzt/Urologie

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Spülkatheter/Dauerspülung nach AO, Koagel ausspülen nach AO/Standard, Kreislauf überwachen, Volumen/Transfusion nach AO, Bilanz

(B) Nur Schmerzmittel geben, der Kreislauf ist nebensächlich

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Die Spülung stoppen, obwohl noch Koagel/Blutung da sind

(B) Vitalzeichen/Kreislauf engmaschig (Blutverlust!), Spülung/Abfluss überwachen, Urinfarbe/Koagel beobachten, Bilanz, auf erneute Tamponade achten, beruhigen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nur einmal den Blutdruck messen

(B) Kreislauf/Vitalzeichen, Spülabfluss/Urinfarbe, Bilanz, Hb-Verlauf nach AO, auf Schock/erneute Tamponade achten, Intensiv bei Verschlechterung

Fall 70 · Verwirrt nach Prostata-OP

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Nach einer transurethralen Prostataresektion (TUR-P) mit Spülung wird der Patient zunehmend verwirrt, klagt über Übelkeit und Kopfschmerz; Blutdruck und Puls verändern sich, er wirkt unruhig.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) An ein TUR-Syndrom denken (Aufnahme von Spülflüssigkeit → Verdünnungshyponatriämie: Verwirrtheit, Übelkeit, Kopfschmerz, Kreislaufveränderung) – Arzt sofort, Vitalzeichen/Bewusstsein, OP-/Spülsituation bedenken

(B) Die Verwirrtheit als bloßes 'Aufwachen aus der Narkose' abtun, abwarten

(C) Nur gegen den Kopfschmerz behandeln

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Großzügig zusätzlich freie Flüssigkeit i.v. geben

(B) Arzt/Anästhesie, Vitalzeichen/Neurostatus engmaschig, Elektrolyte (Natrium!) nach AO, Bilanz/Einfuhr beachten, Monitoring, Therapie nach AO

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Bewusstsein/Vitalzeichen/Atmung, Ein-/Ausfuhr genau, auf Verschlechterung (Krampf/Ödeme) achten, Elektrolytkontrollen nach AO, Intensivüberwachung

(B) Nur einmal den Blutdruck messen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach kurzer Besserung die Kontrollen einstellen

(B) Bewusstsein/Vitalzeichen/Natrium/Bilanz engmaschig, auf Verschlechterung achten, Therapie nach AO, Intensiv, Dokumentation

Fall 71 · Der Blasenkatheter

Routine · niedrig | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Herr T., 70 J., hat einen transurethralen Dauerkatheter. Du übernimmst Pflege und Beobachtung.

1 UMGANG

Worauf achtest du beim Katheter?

- A) Urinmenge und Farbe beobachten, Beutel unter Blasenniveau, geschlossenes System belassen
- B) Den Beutel zur Sicherheit aufs Bett legen
- C) Den Katheter kurz abklemmen

2 HYGIENE

Wie beugst du einer Infektion vor?

- A) Ohne Händedesinfektion arbeiten
- B) Händedesinfektion, sorgfältige Katheter- und Intimpflege, auf Infektzeichen achten
- C) Nur einmal täglich kurz abwischen

3 BILANZ

Es kommt auffällig wenig Urin. Was tust du?

- A) Die geringe Menge ignorieren
- B) Einfach mehr trinken lassen ohne Meldung
- C) Ein- und Ausfuhr bilanzieren, Katheter auf Abknicken prüfen und melden

4 ABSCHLUSS

Wie schließt du ab?

- A) Werte dokumentieren und Auffälligkeiten melden
- B) Nur die Trinkmenge notieren

Gynäkologie

7 Fälle

Fall 72 · Starke Blutung nach der Geburt

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Kurz nach einer vaginalen Geburt blutet die Wöchnerin stark und anhaltend aus der Scheide; die Gebärmutter tastet sich weich und schlecht kontrahiert, sie wird zunehmend blass und unruhig.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Die Blutung als normalen Wochenfluss abtun und abwarten

(B) Postpartale Blutung erkennen (starke anhaltende Blutung, weicher Uterus = Atonie), sofort Hilfe/Arzt/Hebamme, Vitalzeichen (Schock!), Blutung/Vorlagen einschätzen

(C) Den Kreislauf/die Vitalzeichen nicht beachten

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Fundus massieren/reiben (Uterus zur Kontraktion anregen), Blase entleeren lassen, uteruskontrahierende Medikamente nach AO, Zugang/Volumen, Kreislauf überwachen

(B) Die Fundusmassage unterlassen und nur zuschauen

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Vitalzeichen/Kreislauf engmaschig (Blutverlust!), Blutungsstärke/Uterustonus beobachten, Volumen/Transfusion nach AO, Bilanz, beruhigen, Wärme

(B) Den Blutverlust nicht abschätzen/dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Kreislauf/Vitalzeichen, Blutung/Uterustonus, Bilanz, Hb-Verlauf nach AO, auf Schock achten, Intensiv bei Verschlechterung, Dokumentation

(B) Nur einmal den Blutdruck messen

Fall 73 · Hoher Blutdruck mit Warnzeichen

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Eine Hochschwangere hat stark erhöhten Blutdruck, klagt über starke Kopfschmerzen, Augenflimmern und Oberbauchschmerzen; sie wirkt zunehmend reizbar und überempfindlich gegen Licht und Lärm.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Kopfschmerz und Flimmern als banal abtun und abwarten

B Warnzeichen einer (drohenden) Eklampsie erkennen (Hypertonie + Kopfschmerz/Sehstörung/Oberbauchschmerz = Präeklampsie mit Krampfgefahr), sofort Arzt, reizarme Umgebung, Vitalzeichen

C Für helles Licht und Aktivierung sorgen

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

A Reizarme, ruhige Umgebung, Vitalzeichen/RR engmaschig, Krampfprophylaxe/Medikation (z. B. Magnesium) nach AO, Krampf-/Notfallbereitschaft, CTG/Überwachung nach AO

B Die Patientin allein und unüberwacht lassen

3 KRAMPF

Es kommt zum Krampfanfall. Wie gehst du vor?

A Etwas in den Mund schieben und die Patientin festhalten

B Schützen (nichts in den Mund), Atemweg/O_2, reizarm, Magnesium/Therapie nach AO, Mutter und Kind überwachen, Sturz-/Verletzungsschutz

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A RR/Vitalzeichen/Bewusstsein, Krampfbereitschaft, Magnesium/Therapie nach AO, Mutter und Kind (CTG) überwachen, Dokumentation

B Nach dem Anfall die Überwachung beenden

Fall 74 · Akuter Unterbauchschmerz in der Frühschwangerschaft

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Eine Frau in der Frühschwangerschaft bekommt plötzlich heftige einseitige Unterbauchschmerzen, ist blass, schwindelig, hat einen schnellen Puls und niedrigen Blutdruck; dazu etwas vaginale Blutung.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) An eine (rupturierte) Eileiterschwangerschaft denken (Frühschwangerschaft + akuter einseitiger Unterbauchschmerz + Schockzeichen) – lebensbedrohlich, sofort Arzt/Notfall, Vitalzeichen, Zugang

(B) Als gewöhnliche 'Regelschmerzen' abtun und abwarten

(C) Die Kreislaufzeichen nicht beachten

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Erst etwas zu essen/trinken anbieten

(B) Kreislauf stabilisieren (Zugang, Volumen nach AO), nüchtern lassen (OP!), rasche Diagnostik/OP-Vorbereitung, Vitalzeichen engmaschig, Transfusionsbereitschaft nach AO

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Vitalzeichen/Schockzeichen engmaschig, Blutung beobachten, OP-Vorbereitung, beruhigen, Bilanz, nüchtern halten

(B) Nur Schmerzmittel geben und sonst abwarten

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nur einmal den Blutdruck messen

(B) Kreislauf/Vitalzeichen engmaschig, Blutung, OP-Vorbereitung zügig, Transfusionsbereitschaft nach AO, Intensiv bei Verschlechterung, Dokumentation

Fall 75 · Brustentzündung in der Stillzeit

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine stillende Mutter hat eine schmerzhafte, gerötete, überwärmte Stelle an der Brust, fühlt sich grippig und hat Fieber.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Stillen/Entleeren komplett stoppen und die Brust ruhigstellen

B Mastitis (Brustentzündung) in der Stillzeit erkennen (lokale Rötung/Schmerz/Überwärmung + Fieber), Vitalzeichen, Arzt informieren, weiteres Entleeren/Anlegen unterstützen

C Fieber und Schmerz abwarten

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

A Regelmäßiges Entleeren/Stillen fördern (Milchstau lösen), schonende Maßnahmen (z. B. Wärme vor, Kühlung nach dem Stillen nach Vorgabe), Schmerz-/Fiebermanagement nach AO, Antibiotika nur nach AO

B Eigenmächtig Antibiotika/Medikamente geben

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Zunehmende Schwellung/Eiterhinweise ignorieren

B Brust/Verlauf beobachten (auf Abszess achten), Stillberatung/Unterstützung, Schmerz-/Fiebermanagement nach AO, Flüssigkeit/Ruhe, dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Nach erster Linderung nicht weiter beobachten

B Temperatur/Schmerz/Brustbefund, auf Besserung oder Abszess achten, Stillunterstützung, Therapie nach AO, dokumentieren

Fall 76 · Starkes Erbrechen in der Schwangerschaft

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine Schwangere im ersten Trimenon erbricht seit Tagen sehr häufig, kann kaum etwas bei sich behalten, hat abgenommen, trockene Schleimhäute und wirkt schwach.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Ausgeprägtes Schwangerschaftserbrechen (Hyperemesis) mit Exsikkose-Zeichen erkennen, Vitalzeichen, Arzt informieren, Flüssigkeits-/Ernährungszustand einschätzen, Bilanz

(B) Als 'normale' Schwangerschaftsübelkeit abtun und abwarten

(C) Die Schwangere zwingen, große Mahlzeiten zu essen

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Eigenmächtig Antiemetika geben

(B) Flüssigkeit/Elektrolyte nach AO (oft i.v.), Antiemetika nach AO, kleine leichte Mahlzeiten/Schlucke anbieten, Bilanz, Ruhe

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Ein-/Ausfuhr/Gewicht, Exsikkose-/Verschlechterungszeichen, Mundpflege, Reize/Gerüche meiden, kleine Mengen, dokumentieren

(B) Bilanz und Gewicht nicht erfassen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach kurzer Besserung nicht weiter beobachten

(B) Ein-/Ausfuhr/Gewicht, Vitalzeichen, auf zunehmende Exsikkose/Elektrolytentgleisung achten, Therapie nach AO, dokumentieren

Fall 77 · Schwindel in Rückenlage (Schwangerschaft)

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine Hochschwangere wird beim flachen Liegen auf dem Rücken plötzlich blass, schwindelig und übel, der Blutdruck fällt, der Puls steigt.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Die Schwangere weiter flach auf dem Rücken liegen lassen

(B) V.-cava-Kompressionssyndrom erkennen (in Rückenlage drückt die Gebärmutter auf die untere Hohlvene → Blutdruckabfall), sofort die Lagerung ändern: in Linksseitenlage bringen

(C) Sie schnell und ruckartig aufsetzen/aufstehen lassen

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Nichts tun, das wird schon von allein

(B) Linksseitenlage (oder linke Hüfte unterpolstern), Vitalzeichen kontrollieren, beruhigen, O_2 nach AO bei Bedarf, Arzt informieren – meist rasche Besserung

3 PFLEGE & PROPHYLAXE

Worauf achtest du?

(A) Künftig Rückenlage meiden (Seiten-/leichte Kippung), Vitalzeichen/Befinden beobachten, Mutter und Kind im Blick, Schwangere anleiten, dokumentieren

(B) Keine Aufklärung zur Lagerung geben

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Befinden/Vitalzeichen, Mutter und Kind, Lagerung beibehalten/anleiten, bei erneuten Beschwerden Arzt, dokumentieren

(B) Nach Besserung nicht weiter beachten

Fall 78 · Im Wochenbett

Routine · niedrig | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Frau L., 1. Tag nach der Geburt. Du übernimmst Grundpflege und Beobachtung im Wochenbett.

1 SCHICHTBEGINN

Wie beginnst du?

- (A) Befinden und Vitalzeichen erfassen und behutsam nach Blutung und Schmerzen fragen
- (B) Ungefragt die Vorlage kontrollieren
- (C) Intime Themen aus Scham ganz weglassen

2 WOCHENFLUSS

Worauf achtest du beim Wochenfluss (Lochien)?

- (A) Den Wochenfluss nicht beachten
- (B) Nur fragen, ob alles in Ordnung ist
- (C) Menge, Farbe und Geruch beobachten und die Intimhygiene anleiten

3 UNTERSTÜTZUNG

Wie unterstützt du sie weiter?

- (A) Sie ganz sich selbst überlassen
- (B) Bei Mobilisation und Stillen helfen, an Thromboseprophylaxe denken
- (C) Strikte Bettruhe empfehlen

4 ABSCHLUSS

Wie schließt du ab?

- (A) Auffälligkeiten melden und vollständig dokumentieren
- (B) Nur kurz mündlich übergeben

HNO

7 Fälle

Fall 79 · Starkes Nasenbluten

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Patient hat plötzlich starkes Nasenbluten, das nicht von allein aufhört; er ist unruhig, Blut läuft auch in den Rachen.

1 SOFORTMASSNAHMEN

Wie reagierst du zuerst?

A Aufrecht hinsetzen, Kopf nach vorne neigen, Nasenflügel 10–15 min fest zusammendrücken, Nacken kühlen, beruhigen, Blut ausspucken lassen (nicht schlucken)

B Vitalzeichen/Kreislauf gar nicht beachten

C Den Kopf in den Nacken legen

2 VERLAUF

Die Blutung sistiert nicht. Wie weiter (AO)?

A Arzt/HNO informieren, abschwellende/blutstillende Maßnahmen bzw. Tamponade nach AO, Vitalzeichen, Blutungsstärke, Ursache (Antikoagulation/Hypertonie) bedenken

B Zwischendurch immer wieder loslassen, um nachzuschauen

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Die Blutungsmenge nicht beachten

B Vitalzeichen/Kreislauf beobachten (Blutverlust!), bei Tamponade Pflege/Beobachtung, beruhigen, Blut ausspucken lassen, Ursache abklären lassen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Nach kurzem Stillstand nicht weiter beobachten

B Vitalzeichen/Kreislauf, Blutung, bei Tamponade Beobachtung, Ursache (RR/Gerinnung) abklären lassen, dokumentieren

Fall 80 · Atemnot bei Tracheostoma

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient mit Tracheostoma und Trachealkanüle bekommt zunehmend Atemnot, ist unruhig, die Atmung ist rasselnd und erschwert, die SpO_2 fällt; Verdacht auf eine Sekret-/Borkenverlegung der Kanüle.

1 ERKENNEN

Wie reagierst du zuerst?

(A) Nur über Mund/Nase O_2 geben und das Stoma ignorieren

(B) Atemnot durch verlegte Kanüle erkennen, Hilfe rufen, O_2 anbieten, Oberkörper hoch, absaugen nach Standard, Innenkanüle prüfen/entfernen und reinigen (falls vorhanden) nach Standard

(C) Abwarten, das beruhigt sich sicher wieder

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO/Standard)?

(A) Absaugen nach Standard, Innenkanüle wechseln/reinigen nach Standard, bei fortbestehender Verlegung Arzt/Notfall (ggf. Kanülenwechsel), O_2, SpO_2/Atmung überwachen, Notfallset (Ersatzkanülen) bereit

(B) Tief und unkontrolliert blind absaugen, ohne Standard

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Notfallset/Ersatzkanüle nicht bereithalten

(B) Atmung/SpO_2 engmaschig, Sekret/Borken, Befeuchtung/Inhalation nach AO, Ersatzkanülen/Notfallset griffbereit, beruhigen, dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach kurzer Besserung nicht weiter überwachen

(B) Atmung/SpO_2 engmaschig, Sekretmanagement/Befeuchtung nach AO, auf erneute Verlegung achten, Ersatzkanülen bereit, dokumentieren

Fall 81 · Nachblutung nach Mandel-OP

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Einige Stunden nach einer Mandeloperation (Tonsillektomie) beginnt der Patient (z. B. ein Kind) vermehrt zu schlucken, spuckt frisches Blut, wirkt unruhig und blass.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Als 'normal nach der OP' abtun und abwarten

B Den Kreislauf nicht beachten

C Nachblutung nach Tonsillektomie erkennen (häufiges Schlucken, frisches Blut, Blässe) – Notfall, sofort Arzt/HNO, Vitalzeichen, Oberkörper hoch/Kopf zur Seite (Blut ausspucken/abfließen lassen, Aspiration vermeiden), nüchtern lassen (mögliche OP)

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

A Zur Beruhigung etwas zu trinken/essen geben

B Sofort Arzt/HNO, nüchtern lassen, Vitalzeichen/Kreislauf engmaschig, kühlen (Eiskrawatte) nach AO, OP-Vorbereitung, Zugang/Volumen nach AO, Blut ausspucken lassen

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Verschlucktes/erbrochenes Blut nicht beachten

B Vitalzeichen/Kreislauf (Blutverlust – Kinder verschlucken Blut, Menge wird unterschätzt!), Aspirationsschutz (Seitenlage/aufrecht, Blut ausspucken), beruhigen (Kind/Eltern), nüchtern, OP-Vorbereitung

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Nur einmal den Blutdruck messen

B Kreislauf/Vitalzeichen engmaschig, Blutung/Schlucken, Aspirationsschutz, nüchtern, OP-Vorbereitung, Intensiv bei Verschlechterung, dokumentieren

Fall 82 · Atemnot mit Speichelfluss

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient bekommt rasch hohes Fieber, starke Halsschmerzen, eine kloßige Sprache und Speichelfluss (kann kaum schlucken) und sitzt vornübergebeugt, um besser Luft zu bekommen; die Atemnot nimmt zu.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Verdacht auf Epiglottitis (akute Kehldeckelentzündung: hohes Fieber, kloßige Sprache, Speichelfluss, Atemnot, sitzende vornübergebeugte Haltung) – akuter Atemwegsnotfall, sofort Arzt/Notfall, Ruhe, sitzen lassen, O_2 nach AO, nicht reizen

(B) Mit einem Spatel in den Rachen schauen / eine Racheninspektion erzwingen

(C) Den Patienten flach hinlegen

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Sitzende Position belassen, Ruhe / nicht aufregen (v. a. Kinder), O_2 nach AO, Notfall-/Intubationsbereitschaft (Anästhesie/HNO), nichts in den Mund, Vitalzeichen/SpO_2, nüchtern

(B) Zur Beruhigung etwas zu trinken geben

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Atmung/SpO_2 engmaschig, sitzende Position, ruhige reizarme Umgebung, Notfallteam/Intubationsbereitschaft, nichts in den Mund, beruhigen, dokumentieren

(B) Den Patienten allein lassen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach kurzer scheinbarer Besserung die Überwachung lockern

(B) Atmung/SpO_2 engmaschig, sitzende Position, Intubations-/Notfallbereitschaft, ruhig, nüchtern, dokumentieren

Fall 83 · Heftiger Drehschwindel-Anfall

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine Patientin mit bekanntem Morbus Menière bekommt einen heftigen Drehschwindelanfall mit Übelkeit und Fallneigung; sie kann kaum sicher stehen.

1 SOFORTMASSNAHMEN

Wie reagierst du zuerst?

(A) Sturzgefahr erkennen, für Sicherheit sorgen (hinsetzen/-legen, nicht allein gehen lassen), reizarme ruhige Umgebung, beruhigen, Vitalzeichen, Arzt/AO

(B) Sie zum Toilettengang allein losschicken

(C) Für helle, unruhige Umgebung sorgen

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Eigenmächtig Medikamente geben

(B) Antiemetika/Antivertiginosa nach AO, Erbrechen managen, ruhige Lagerung, Begleitung, Flüssigkeit nach Verträglichkeit, Vitalzeichen

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Sturzprophylaxe, Begleitung beim Gehen, reizarm, Erbrechen/Übelkeit beobachten, beruhigen, Edukation zu Verhalten im Anfall, dokumentieren

(B) Die Patientin im Anfall unbeaufsichtigt aufstehen lassen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach leichter Besserung nicht weiter beachten

(B) Befinden/Vitalzeichen, Sturzprophylaxe/Begleitung, Übelkeit, Therapie nach AO, Edukation, dokumentieren

Fall 84 · Plötzliche einseitige Hörminderung

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Patient berichtet über eine plötzliche einseitige Hörminderung mit 'Wattegefühl' und Ohrgeräusch (Tinnitus), ohne Schmerzen; er ist erschrocken und sorgt sich um sein Gehör.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) An einen Hörsturz denken (plötzliche einseitige Hörminderung, oft Tinnitus, schmerzlos) – als HNO-Eilfall behandeln, zeitnah Arzt/HNO, Ruhe/Stressreduktion, beruhigen

(B) 'Das wird schon wieder' – tagelang abwarten

(C) Eigenmächtig Ohrentropfen/Medikamente geben

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Am Ohr manipulieren/spülen

(B) Zeitnahe HNO-Abklärung, Medikamente (z. B. Kortison) nur nach AO, Wirkung/Nebenwirkung beobachten, Ruhe/Stressreduktion fördern

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Ruhe/Stressreduktion, bei begleitendem Schwindel Sturzprophylaxe, psychische Unterstützung (Angst ums Gehör), Edukation zu Therapie/Verlauf, dokumentieren

(B) Die Sorge ums Gehör abtun/nicht ernst nehmen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach erster Besserung nicht weiter begleiten

(B) Therapie/Wirkung nach AO beobachten, Ruhe, bei Schwindel Sturzprophylaxe, psychische Unterstützung, Edukation, dokumentieren

Fall 85 · Nach der Mandel-OP

Routine · mittel | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Tim, 16 J., einige Stunden nach Mandel-OP (Tonsillektomie). Du betreust ihn auf Station.

1 BEOBACHTUNG

Worauf achtest du als Erstes?

- A Auf Zeichen einer Nachblutung achten (häufiges Schlucken) und Vitalzeichen prüfen
- B Erst einmal abwarten
- C Ihm warmen Tee und Suppe anbieten

2 MASSNAHMEN

Was empfiehlst du ihm?

- A Kräftig Hals freiräuspern
- B Kühle, weiche Kost, kühlen, nicht räuspern, Kopf etwas erhöht
- C Flach hinlegen ohne Erhöhung

3 WARNZEICHEN

Welche Zeichen sprechen für eine Nachblutung?

- A Nur sichtbares Erbrechen von Blut zählt
- B Häufiges Schlucken, Blut im Mund, Blässe und Unruhe sofort melden
- C Solche Zeichen ignorieren

4 ABSCHLUSS

Wie schließt du ab?

- A Nur am Ende kurz erwähnen
- B Beobachtungen melden und dokumentieren

Orthopädie

7 Fälle

Fall 86 · Sturz mit Hüftschmerz im Alter

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine ältere Patientin ist gestürzt und klagt über starke Hüftschmerzen; das betroffene Bein ist verkürzt und nach außen gedreht, sie kann nicht auftreten.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Die Patientin zum Aufstehen/Gehen auffordern

B Verdacht auf hüftgelenknahe Fraktur (Sturz, Schmerz, verkürztes/außenrotiertes Bein) erkennen, Bein ruhigstellen/nicht belasten, Schmerz erfassen, Vitalzeichen, Arzt informieren, DMS (Durchblutung/Motorik/Sensibilität) prüfen

C Den Schmerz nicht weiter beachten

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

A Zur Stärkung etwas zu essen/trinken geben

B Bein schonend lagern/ruhigstellen, Schmerztherapie nach AO, nüchtern lassen (mögliche OP), Diagnostik/OP-Vorbereitung, DMS kontrollieren, Druckstellen beachten

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Die Prophylaxen (Dekubitus/Thrombose/Pneumonie) vernachlässigen

B Schmerz-/Lagerungsmanagement, Prophylaxen (Dekubitus, Thrombose, Pneumonie), auf Verwirrtheit/Delir achten (alter Mensch!), Vitalzeichen, OP-Vorbereitung, beruhigen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Schmerz/DMS/Vitalzeichen, Prophylaxen, auf Delir/Verschlechterung achten, OP-Vorbereitung, dokumentieren

B Nur einmal den Schmerz erfragen

Fall 87 · Atemnot Tage nach Knochenbruch

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient mit Oberschenkelbruch wird 1–2 Tage nach dem Trauma zunehmend kurzatmig und verwirrt; es zeigen sich kleine punktförmige Hauteinblutungen (Petechien), die SpO_2 fällt.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Nur den Frakturschmerz behandeln

B Atemnot und Verwirrtheit als 'Erschöpfung' abtun und abwarten

C An ein Fettembolie-Syndrom denken (1–3 Tage nach Röhrenknochenbruch: Atemnot + Verwirrtheit + Petechien) – Notfall, sofort Arzt, O_2 nach AO, Vitalzeichen/SpO_2, Atmung/Bewusstsein

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

A O_2 nach AO, Vitalzeichen/SpO_2/Bewusstsein engmaschig, Arzt/Intensiv, Bettruhe/schonende Lagerung, Monitoring, Therapie nach AO

B Den Patienten trotz Atemnot kräftig mobilisieren

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Nur einmal die SpO_2 messen

B Atmung/SpO_2/Bewusstsein engmaschig, O_2 nach AO, auf Verschlechterung achten, Intensivüberwachung, Frakturruhigstellung, dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Nach kurzer Besserung die Überwachung beenden

B Atmung/SpO_2/Bewusstsein/Vitalzeichen engmaschig, O_2/Therapie nach AO, Intensiv, dokumentieren

Fall 88 · Schmerzen und Taubheit unter dem Gips

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Patient mit frischem Unterschenkelgips klagt über zunehmende, starke Schmerzen, Kribbeln und Taubheit der Zehen; die Zehen wirken blass und kühl, die Schwellung nimmt zu.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Den Schmerz mit Schmerzmittel überdecken und abwarten

B Das Bein tief lagern

C Drohende Durchblutungs-/Nervenstörung unter dem Gips erkennen (zunehmender Schmerz, Kribbeln/Taubheit, blasse/kühle Zehen) – DMS prüfen (Durchblutung/Motorik/Sensibilität), Bein hochlagern, sofort Arzt, Gips nach AO spalten/lockern

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

A Den Gips/Verband noch enger wickeln

B Bein hochlagern, Gips nach AO spalten/aufschneiden/lockern, DMS engmaschig kontrollieren, Arzt, nicht abwarten (drohende Durchblutungsstörung/Kompartment)

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Nur Schmerzmittel geben

B DMS engmaschig (Zehen: Farbe/Wärme/Bewegung/Gefühl), Schwellung/Schmerz beobachten, Hochlagern, bei Verschlechterung sofort Arzt, dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Nach kurzer Besserung nicht weiter kontrollieren

B DMS/Schwellung/Schmerz engmaschig, hochlagern, bei Verschlechterung sofort Arzt, dokumentieren

Fall 89 · Geschwollene, schmerzhafte Wade

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Patient nach längerer Immobilisation/OP klagt über eine einseitig geschwollene, überwärmte, schmerzhafte Wade; die Haut ist gespannt und gerötet.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Die Wade massieren/ausstreichen, um den Schmerz zu lindern

B Verdacht auf tiefe Venenthrombose erkennen (einseitige Schwellung/Überwärmung/Schmerz, Spannung), Bein ruhigstellen, NICHT massieren/kneten, Arzt informieren, Vitalzeichen, auf Lungenembolie-Zeichen achten

C Kräftig mobilisieren – 'laufen ist gut'

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

A Arzt/Diagnostik, Antikoagulation nach AO, Bein nach AO lagern, nicht massieren, auf plötzliche Atemnot/ Brustschmerz (Lungenembolie!) achten, Vitalzeichen

B Eigenmächtig Medikamente geben

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Bein beobachten (Umfang/Schmerz), nicht massieren, Therapie nach AO, auf Lungenembolie-Zeichen (Atemnot/ Brustschmerz/Tachykardie) achten und sofort melden, Edukation, dokumentieren

B Plötzliche Atemnot nicht ernst nehmen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Nach Therapiestart nicht weiter beobachten

B Bein/Umfang/Schmerz, Therapie nach AO, engmaschig auf Lungenembolie-Zeichen achten, Vitalzeichen, Edukation, dokumentieren

Fall 90 · Erste Mobilisation nach Hüft-TEP

subakut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine Patientin nach Hüft-TEP (künstliches Hüftgelenk) soll erstmals mobilisiert werden; sie möchte sich aus dem Bett drehen und dabei die Beine übereinanderschlagen.

1 LAGERUNG

Wie gehst du die Mobilisation an?

(A) Luxationsprophylaxe beachten (verbotene Bewegungen vermeiden: Beine nicht übereinanderschlagen/überkreuzen, keine starke Beugung über 90°, nicht nach innen drehen), Beine z. B. mit Kissen abspreizen, ruhig erklären

(B) Sie tief in die Hocke / über 90° beugen lassen

(C) Sie die Beine übereinanderschlagen lassen

2 MOBILISATION

Wie weiter (nach Vorgabe)?

(A) Sie ruckartig und ohne Hilfsmittel aufstehen lassen

(B) Nach Vorgabe/Physiotherapie mobilisieren, erlaubte Bewegungen anleiten, Hilfsmittel nutzen, langsam und sicher, Schmerz beachten, DMS/Wunde beobachten

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Die Prophylaxen vernachlässigen

(B) Luxationsprophylaxe/erlaubte Bewegungen, Thrombose-/Dekubitus-/Pneumonieprophylaxe, Schmerzmanagement, Wunde/DMS beobachten, Edukation, dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Erlaubte Bewegungen/Luxationsprophylaxe, Prophylaxen, Schmerz/Wunde/DMS, sichere Mobilisation, Edukation, dokumentieren

(B) Nach erstem Aufstehen nicht weiter anleiten

Fall 91 · Sturz aus Höhe mit Rückenschmerz

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient ist aus größerer Höhe gestürzt und klagt über starke Rückenschmerzen, Kribbeln in den Beinen und Schwäche; er liegt am Boden.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Den Patienten aufsetzen/hinstellen lassen

B An eine mögliche (instabile) Wirbelsäulenverletzung denken (Sturz aus Höhe + Rückenschmerz + neurologische Zeichen) – Patienten möglichst nicht bewegen/aufsetzen, flach und ruhig liegen lassen, HWS/Achse schützen, sofort Notfall/Arzt, Vitalzeichen, neurologische Zeichen erfassen

C Ihn schnell und unkoordiniert umlagern

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (nach Vorgabe)?

A Den Patienten allein und ruckartig umlagern

B Immobilisation/Achse wahren, Bewegungen nur koordiniert (Logroll) im Team nach Vorgabe, neurologische Befunde dokumentieren, Notfallteam, Vitalzeichen, Wärmeerhalt

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Die neurologischen Zeichen nicht beachten

B Achse/Immobilisation, Neurostatus engmaschig (Sensibilität/Kraft), Vitalzeichen, koordinierte Bewegungen im Team, Druckstellen/Wärme, beruhigen, dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Achse/Immobilisation, Neurostatus/Vitalzeichen engmaschig, koordinierte Bewegungen, Wärmeerhalt, bei Verschlechterung sofort Arzt, dokumentieren

B Nach kurzer Zeit die Achse nicht mehr beachten

Fall 92 · Nach der neuen Hüfte

Routine · mittel | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Frau R., 74 J., 1. Tag nach Hüft-TEP (künstliches Hüftgelenk). Du übernimmst Lagerung und Beobachtung.

1 LAGERUNG

Worauf achtest du bei der Lagerung?

- A) Frau R. flach und ohne Hilfsmittel lagern
- B) Abduktionskissen nutzen, keine Beugung über 90°, Beine nicht überkreuzen
- C) Das Bein frei in jede Richtung bewegen lassen

2 PROPHYLAXE

Welche Prophylaxe ist jetzt wichtig?

- A) Thromboseprophylaxe: Bewegung der Füße, Kompressionsstrümpfe und Heparin nach Anordnung
- B) Strikte, völlige Ruhigstellung
- C) Gar keine Prophylaxe

3 MOBILISATION

Wie mobilisierst du sie?

- A) Allein und ohne Hilfsmittel aufstehen lassen
- B) Nach Anordnung, mit Gehhilfe und Anleitung, auf Sturzprophylaxe achten
- C) Vorsichtshalber gar nicht mobilisieren

4 ABSCHLUSS

Wie schließt du ab?

- A) Nur die Mobilisation notieren
- B) Wunde und Durchblutung beobachten, melden und dokumentieren

Auflösungen

Zu jedem Entscheidungspunkt: Bewertung aller Antworten mit Begründung und der Merksatz zum Fall.

Fall 1 · Akuter Brustschmerz

1A	RICHTIG	Richtig – das frühe 12-Kanal-EKG steuert alle weiteren Entscheidungen.
1B	VERTRETBAR	O_2 nur bei SpO_2 < 90 % – hier 96 %. Unnötige Hyperoxie kann schaden; EKG hat Vorrang.
1C	VERTRETBAR	Vertretbar, aber nachrangig: Troponin ist früh oft negativ und darf die Reperfusion nicht verzögern. EKG zuerst.
2A	FALSCH	Bei eindeutiger ST-Hebung kein Warten auf Laborwerte.
2B	RICHTIG	Korrekt – eindeutige ST-Hebung = sofortige Reperfusion.
2C	RICHTIG	Sehr gut mitgedacht – inferiorer Infarkt kann den rechten Ventrikel betreffen.
3A	VERTRETBAR	Nicht pauschal: bei RV-Infarkt mit Hypotonie ist vorsichtige Volumengabe sogar hilfreich.
3B	VERTRETBAR	Riskant beim inferioren/RV-Infarkt – Gefahr schwerer Hypotonie.
3C	RICHTIG	Sehr gut – bei rechtsventrikulärer Beteiligung kann Nitrat den RR einbrechen lassen.
4A	VERTRETBAR	Bei sichtbarem VF + Bewusstlosigkeit nicht zögern.
4B	RICHTIG	Korrekt – bei VF sofort defibrillieren.
4C	VERTRETBAR	Defibrillation hat Vorrang; Amiodaron erst nach dem 3. erfolglosen Schock.

Merke: STEMI: EKG < 10 min steuert alles. Beim inferioren Infarkt an RV-Beteiligung denken (Nitrat-Vorsicht, Volumen kann helfen). Bei VF sofort defibrillieren.

Fall 2 · Nächtliche Atemnot

1A	VERTRETBAR	EKG ist wichtig (Ischämie/Rhythmus), aber Lagerung und O_2 haben Sofortpriorität.
1B	VERTRETBAR	Diuretikum gehört dazu, aber beim hypertensiven Ödem wirken Lagerung/O_2/Nitrate früher.
1C	RICHTIG	Richtig – Lagerung und O_2 wirken sofort, parallel Monitoring.
2A	FALSCH	Im akut dekompensierten Ödem kontraindiziert – verschlechtert die Pumpfunktion.
2B	RICHTIG	Korrekt – beim hypertensiven Ödem sind Nitrate zentral.
2C	VERTRETBAR	Furosemid hilft, aber ohne Nachlastsenkung bleibt der hohe Druck bestehen.
3A	VERTRETBAR	Bei Erschöpfung reicht das oft nicht – NIV erwägen.
3B	VERTRETBAR	Intubation erst, wenn NIV scheitert; Sedierung hier gefährlich.
3C	RICHTIG	Sehr gut – CPAP verbessert Oxygenierung und senkt die Vorlast.
4A	RICHTIG	Sehr gut.
4B	VERTRETBAR	Ziel ist ausreichende, nicht maximale Sättigung; RR/Bilanz fehlen.

Merke: Hypertensives Lungenödem: Lagerung + O_2/NIV (CPAP) + Nitrate/Diuretikum. Betablocker akut kontraindiziert, keine Volumenzufuhr.

Fall 3 · COPD-Exazerbation

1A	FALSCH	Hypoxie nicht unbehandelt lassen – kontrolliert sofort geben.
1B	RICHTIG	Richtig – bei COPD kontrollierte O_2-Gabe.

1C	VERTRETBAR	Initial kontrolliert beginnen – hohe Flüsse riskieren CO_2-Anstieg/Somnolenz.
2A	VERTRETBAR	NIV ist stark bei respiratorischer Azidose – nicht reflexhaft vor Bronchodilatation/BGA.
2B	RICHTIG	Korrekt.
2C	FALSCH	Dämpft den Atemantrieb – gefährlich.
3A	VERTRETBAR	Verstärkt den CO_2-Anstieg.
3B	RICHTIG	Sehr gut – hier ist NIV evidenzbasiert.
3C	VERTRETBAR	Bei pH 7,28 reicht das oft nicht.
4A	VERTRETBAR	Bei COPD riskant – Zielbereich einhalten.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: COPD-Exazerbation: kontrollierte O_2 (88–92 %), Bronchodilatatoren + Steroide (+ AB bei purulent), NIV bei respiratorischer Azidose; keine Sedierung.

Fall 4 · Plötzliche Atemnot postop.

1A	VERTRETBAR	Antikoagulation ist zentral, aber nach ärztlicher Anordnung/Risikoabwägung – nicht eigenmächtig.
1B	VERTRETBAR	EKG ist sinnvoll (Rechtsherzbelastung/DD), aber Monitoring/O_2 und Arztinfo laufen parallel.
1C	RICHTIG	Richtig.
2A	VERTRETBAR	Bei hoher klinischer Wahrscheinlichkeit ist D-Dimer wenig hilfreich – Bildgebung.
2B	RICHTIG	Korrekt beim stabilen Patienten.
3A	VERTRETBAR	Aggressive Volumengabe kann den überlasteten rechten Ventrikel verschlechtern.
3B	RICHTIG	Sehr gut erkannt.
3C	FALSCH	Bei Schock flach/Schocklagerung, nicht aufsetzen.
4A	RICHTIG	Sehr gut.
4B	VERTRETBAR	Der Kreislauf steht im Vordergrund.

Merke: Postop LE: keine Mobilisation, O_2/Monitoring. Stabil → CT-Angio + Antikoagulation; instabil → Hochrisiko-LE (Lyse/Intensiv). Volumen nur vorsichtig (RV!).

Fall 5 · Bluterbrechen

1A	RICHTIG	Richtig – Hämodynamik zuerst.
1B	VERTRETBAR	Nicht primär entscheidend und bei aktiver Hämatemesis ohne Atemwegsschutz riskant.
1C	VERTRETBAR	PPI ist sinnvoll, aber Kreislaufsicherung und Zugänge haben Vorrang.
2A	VERTRETBAR	Bei aktiver Blutung/Instabilität ist die frühe Endoskopie indiziert.
2B	RICHTIG	Korrekt.
3A	VERTRETBAR	Kopftieflage erhöht die Aspirationsgefahr bei Hämatemesis.
3B	RICHTIG	Sehr gut – Aspiration und Schock im Blick.
3C	VERTRETBAR	Allein Volumen reicht bei aktiver Blutung nicht.
4A	RICHTIG	Sehr gut.

4B VERTRETBAR Engmaschig wegen Rezidivblutung.

Merke: Obere GI-Blutung: Kreislauf zuerst (2 Zugänge, Volumen/Transfusion), nüchtern, frühe Endoskopie, Aspirationsschutz; PPI begleitend, nicht statt Kreislauf.

Fall 6 · Plötzliche Verwirrtheit

1A VERTRETBAR Eher wenn keine orale Gabe/kein Zugang möglich; bei Sulfonylharnstoff zudem weniger zuverlässig.

1B RICHTIG Richtig – orale Gabe nach der 15er-Regel.

1C VERTRETBAR Vertretbar bei liegendem Zugang, aber bei sicher schluckfähigem Patienten ist oral erste Wahl.

2A VERTRETBAR Gerade bei Sulfonylharnstoff drohen protrahierte/erneute Hypoglykämien.

2B RICHTIG Korrekt.

3A RICHTIG Sehr gut – Sulfonylharnstoffe wirken lang.

3B VERTRETBAR Zu früh – Rückfallgefahr über Stunden.

4A RICHTIG Sehr gut.

4B VERTRETBAR Verlauf und Ursache sind wichtig.

Merke: Hypoglykämie: wach → orale KH (15er-Regel). Sulfonylharnstoff/lang wirkendes Insulin → längere Überwachung (Rezidiv!). Bewusstlos → nie oral, i.v. Glukose/Glukagon.

Fall 7 · Fieber auf Station

1A FALSCH Keine Medikamentengabe ohne ärztliche Anordnung.

1B RICHTIG Richtig – erst messen und einschätzen.

1C VERTRETBAR Lüften schadet nicht, ersetzt aber keine Einschätzung.

2A RICHTIG Sehr gut – umfassende Beobachtung.

2B VERTRETBAR Zu wenig – der Gesamtzustand zählt.

2C FALSCH Ohne Dokumentation fehlt die Verlaufskontrolle.

3A FALSCH Flüssigkeitsmangel kann rasch gefährlich werden.

3B RICHTIG Richtig – Exsikkosegefahr bei älteren Menschen.

3C VERTRETBAR Zwang vermeiden – lieber regelmäßig kleine Mengen anbieten.

4A RICHTIG Genau richtig.

4B VERTRETBAR Auffälligkeiten gehören zeitnah gemeldet.

Merke: 1. Lernjahr: Vitalzeichen messen, Gesamtzustand beobachten, Flüssigkeit im Blick behalten, zeitnah melden und dokumentieren.

Fall 8 · Akutes Abdomen

1A VERTRETBAR Wärme ist bei akutem Abdomen ungünstig (kann eine Perforation begünstigen) – eher nüchtern/kühlen.

1B FALSCH Laxanzien/Klysmen sind beim akuten Abdomen kontraindiziert – Perforationsgefahr.

1C RICHTIG Richtig – Basismonitoring und nüchtern (mögliche OP).

2A

VERTRETBAR Veraltet – Analgesie darf gegeben werden; nur den Befund vorher dokumentieren.

2B RICHTIG Korrekt – moderne Analgesie verschleiert die Diagnose nicht.

2C FALSCH Nüchtern lassen wegen möglicher OP/Aspiration.

3A VERTRETBAR Analgesie ja, aber die OP-Indikation darf nicht verzögert werden.

3B RICHTIG Sehr gut – septisch-chirurgischer Notfall.

3C VERTRETBAR Bei bretthartem Abdomen + Kreislaufreaktion sofort eskalieren.

4A RICHTIG Sehr gut.

4B VERTRETBAR Kreislauf und Sepsis stehen im Vordergrund.

Merke: Akutes Abdomen: nüchtern, keine Wärme/Laxanzien, Analgesie nach AO erlaubt; bei Perforation/Peritonitis sofortige OP plus Sepsisbündel.

Fall 9 · Darmverschluss

1A FALSCH Beim mechanischen Ileus kontraindiziert (Perforationsgefahr).

1B RICHTIG Richtig – Entlastung plus Flüssigkeits-/Elektrolytausgleich.

1C VERTRETBAR Bei Ileus nüchtern – orale Zufuhr verschlimmert Erbrechen/Aspiration.

2A VERTRETBAR Analgesie ja, aber Entlastung/Bilanz und chirurgische Beurteilung sind nötig.

2B RICHTIG Korrekt.

3A VERTRETBAR Dauerschmerz + Fieber + Kreislauf = Strangulation, sofort eskalieren.

3B RICHTIG Sehr gut – Kolik → Dauerschmerz ist ein Alarmzeichen.

4A VERTRETBAR Kreislauf/Bilanz/Sepsis im Vordergrund.

4B RICHTIG Sehr gut.

Merke: Mechanischer Ileus: nüchtern, Magensonden-Entlastung, Volumen/Elektrolyte, keine Laxanzien/Einläufe; Dauerschmerz + Fieber = Strangulation → OP.

Fall 10 · Plötzlich kaltes Bein

1A VERTRETBAR Bei arterieller Ischämie eher tief lagern – Hochlagern verschlechtert die Perfusion.

1B FALSCH Aktive Wärme steigert den O_2-Bedarf im ischämischen Gewebe – schädlich.

1C RICHTIG Richtig – tief lagern, polstern, Zeit ist Gewebe (6 P).

2A RICHTIG Korrekt – Revaskularisation im Zeitfenster.

2B VERTRETBAR Die Ischämietoleranz ist begrenzt – kein Abwarten.

3A RICHTIG Sehr gut erkannt.

3B VERTRETBAR Harte Loge + Schmerz = Kompartment – sofort eskalieren.

4A RICHTIG Sehr gut – an das Reperfusionssyndrom denken.

4B VERTRETBAR Reperfusion/Kompartment/Niere im Blick behalten.

Merke: Akute Extremitätenischämie (6 P): tief lagern, polstern, NICHT aktiv wärmen, schnelle Revaskularisation; nach Reperfusion auf Kompartment und Niere achten.

Fall 11 · Schmerz im Gips

1A	FALSCH	Der Schmerz ist das Leitsymptom – Analgesie darf das Kompartment nicht verschleiern.
1B	RICHTIG	Richtig – einengende Verbände öffnen, nicht hochlagern (Perfusion!).
1C	VERTRETBAR	Hochlagern senkt den Perfusionsdruck zusätzlich – auf Herzhöhe belassen.
2A	VERTRETBAR	Das Kompartmentsyndrom ist eine klinische Diagnose – nicht auf Bildgebung warten.
2B	RICHTIG	Korrekt – die Fasziotomie ist zeitkritisch.
3A	RICHTIG	Sehr gut – jetzt Notfall.
3B	VERTRETBAR	Pulsverlust ist ein Spätzeichen – nicht darauf warten.
4A	RICHTIG	Sehr gut – an Rhabdomyolyse/Niere denken.
4B	VERTRETBAR	Durchblutung und Niere stehen im Vordergrund.

Merke: Kompartmentsyndrom: klinische Diagnose, einengende Verbände sofort öffnen, Bein auf Herzhöhe (nicht hoch); Pulsverlust ist Spätzeichen; Fasziotomie zeitkritisch; Rhabdomyolyse beachten.

Fall 12 · Postoperative Nachblutung

1A	FALSCH	Abklemmen verschleiert die Blutung und kann zu Verhalt/Tamponade führen – nicht eigenmächtig.
1B	VERTRETBAR	Analgesie ist wichtig, aber Schock/Blutung haben Vorrang.
1C	RICHTIG	Richtig – Schockzeichen + Drainageblut = Nachblutung, Kreislauf zuerst.
2A	RICHTIG	Korrekt.
2B	VERTRETBAR	Volumen ja, aber Transfusionsbereitschaft und ggf. Revision sind nötig.
3A	VERTRETBAR	Bei anhaltender chirurgischer Blutung reicht Volumen nicht.
3B	RICHTIG	Sehr gut – eine chirurgische Blutung muss meist operativ gestillt werden.
4A	RICHTIG	Sehr gut.
4B	VERTRETBAR	Engmaschiger wegen der akuten Blutung.

Merke: Postop Nachblutung: Schock erkennen, Kreislauf zuerst (2 Zugänge, Volumen/Transfusion), Drainage beobachten (nicht eigenmächtig abklemmen), chirurgische Blutung meist operativ stillen.

Fall 13 · Eingeklemmte Leiste

1A	FALSCH	Forcierte Reposition kann ischämischen Darm zurückverlagern (Perforationsgefahr).
1B	VERTRETBAR	Wärme ist bei möglicher Inkarzeration/Ischämie ungünstig; nüchtern + chirurgische Beurteilung.
1C	RICHTIG	Richtig – bei schmerzhafter, irreponibler Hernie keine forcierte Reposition; OP-Bereitschaft.
2A	VERTRETBAR	Bei Inkarzeration mit Ischämiezeichen kein Abwarten.
2B	RICHTIG	Korrekt.
3A	VERTRETBAR	Jetzt erst recht keine Reposition – Not-OP.
3B	RICHTIG	Sehr gut.
4A	VERTRETBAR	Kreislauf und Sepsis stehen im Vordergrund.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: Inkarzerierte Hernie: nicht forciert reponieren, nüchtern, dringliche OP; Strangulation ist ein Notfall mit Ischämie-/Peritonitis-Gefahr.

Fall 14 · Erster Tag nach der OP

1A	FALSCH	Ein Verbandwechsel erfolgt nur nach Anordnung und mit Anleitung – nicht eigenmächtig.
1B	VERTRETBAR	Mobilisation ist wichtig, aber zuerst gehört eine kurze Einschätzung von Zustand und Kreislauf.
1C	RICHTIG	Richtig – erst den aktuellen Zustand erfassen, bevor du handelst.
2A	FALSCH	Keine eigenmächtige Medikamentengabe – immer nur nach ärztlicher Anordnung.
2B	RICHTIG	Genau so – strukturiert erfassen, weitergeben und dokumentieren.
2C	VERTRETBAR	Schmerz muss ernst genommen werden – unbehandelt behindert er Atmung und Mobilisation.
3A	VERTRETBAR	Ein Verbandwechsel erfolgt nach Anordnung und unter Anleitung, nicht spontan allein.
3B	RICHTIG	Sehr gut – beobachten, melden, dokumentieren ist der richtige Weg.
3C	FALSCH	Eine Nachblutung darf nie übersehen werden.
4A	RICHTIG	Richtig – Bewegung und Prophylaxen beugen Komplikationen vor.
4B	VERTRETBAR	Längere Bettruhe fördert Thrombose und Lungenentzündung – dosierte Mobilisation ist besser.

Merke: 1. Lernjahr postoperativ: zuerst beobachten (Vitalzeichen, Schmerz, Wunde), strukturiert melden und dokumentieren, keine eigenmächtige Medikamentengabe, frühe Mobilisation mit Prophylaxen.

Fall 15 · Septischer Schock

1A	VERTRETBAR	Fiebersenkung ist nebensächlich – Kulturen, Antibiose, Volumen haben Priorität.
1B	RICHTIG	Richtig – Kulturen vor AB, frühe Antibiose + Volumen (1-h-Bündel).
1C	VERTRETBAR	Wenn ohne Verzug möglich: Kulturen VOR der ersten Gabe – die Antibiose aber nie lange aufschieben.
2A	FALSCH	Bei Hypovolämie/Schock kontraindiziert – verschlechtert die Perfusion.
2B	RICHTIG	Korrekt – Volumenresuscitation, dann neu bewerten.
2C	VERTRETBAR	Antibiose allein behebt den Volumenmangel nicht.
3A	RICHTIG	Sehr gut – volumenrefraktär = Vasopressor (septischer Schock).
3B	VERTRETBAR	Unbegrenztes Volumen → Ödeme; jetzt Vasopressor.
4A	RICHTIG	Sehr gut – Fokussanierung (DK-Wechsel) nicht vergessen.
4B	VERTRETBAR	MAP/Laktat/Urin/Fokus stehen im Vordergrund.

Merke: Sepsis-1-h-Bündel: Kulturen → frühe Antibiose, Volumen, Laktat. Volumenrefraktär → Vasopressor. Fokussanierung (z. B. DK-Wechsel) nicht vergessen.

Fall 16 · Beatmungsnotfall

1A	FALSCH	Unruhe ist ein Hypoxiezeichen – nicht sedieren, sondern Ursache beheben.
1B	FALSCH	Nicht blind extubieren – erst Ursache abklären.
1C	RICHTIG	Richtig – DOPES (Dislokation, Obstruktion, Pneu, Equipment, Stomach); manuelle Beatmung deckt Geräteursachen auf.
2A	RICHTIG	Korrekt – systematisch abklären.

2B	VERTRETBAR	Hoher Druck bei Pneu ist gefährlich – erst Ursache klären.
3A	VERTRETBAR	Ein Spannungspneu muss sofort entlastet werden.
3B	RICHTIG	Sehr gut – lebensbedrohlich, sofortige Entlastung.
4A	VERTRETBAR	Drücke/Drainage/Kreislauf gehören dazu.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: Beatmungsnotfall: DOPES strukturiert abarbeiten, 100 % O_2 + manuelle Beatmung, nicht blind extubieren/sedieren, Spannungspneu sofort entlasten.

Fall 17 · Gefährliches Kalium

1A	RICHTIG	Richtig – bei EKG-Veränderungen zuerst Kalzium zum Herzschutz.
1B	VERTRETBAR	Insulin/Glukose senkt K^+, schützt das Herz aber nicht sofort – bei EKG-Veränderungen Kalzium voran.
1C	VERTRETBAR	Bei lebensbedrohlichem EKG kein Abwarten – Kalzium gibt Zeit.
2A	VERTRETBAR	Wirkt zu langsam für eine akut bedrohliche Hyperkaliämie.
2B	RICHTIG	Korrekt – verschiebt K^+ rasch; BZ kontrollieren.
3A	VERTRETBAR	Die Verschiebung ist nur temporär – bei Anurie ist Dialyse nötig.
3B	RICHTIG	Sehr gut – bei anurischem ANV ist Dialyse die definitive Therapie.
4A	VERTRETBAR	Engmaschig EKG/K^+ – Arrhythmiegefahr.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: Schwere Hyperkaliämie mit EKG-Veränderungen: 1) Kalzium (Herzschutz), 2) Insulin/Glukose (±Beta-2) zum Verschieben, 3) Dialyse zur Elimination (v. a. anurisch). EKG-Monitoring.

Fall 18 · Entgleister Zucker

1A	VERTRETBAR	Bikarbonat nur in Ausnahmefällen – nicht routinemäßig in der DKA.
1B	RICHTIG	Richtig – der Volumenmangel ist führend, Flüssigkeit zuerst.
1C	VERTRETBAR	Insulin gehört dazu, aber Volumen und K^+-Beachtung zuerst – Insulin nicht vor dem K^+-Check hochfahren.
2A	FALSCH	Gefährliche Hypokaliämie/Arrhythmie.
2B	RICHTIG	Korrekt – Insulin treibt K^+ in die Zelle; bei niedrigem K^+ erst ausgleichen.
3A	VERTRETBAR	Ein Insulinstopp lässt die Ketoazidose persistieren.
3B	RICHTIG	Sehr gut – Insulin nicht stoppen, sondern Glukose zugeben.
4A	VERTRETBAR	K^+/BGA/Bilanz engmaschig – Komplikationsgefahr.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: DKA: 1) Volumen, 2) Kalium beachten (Insulin senkt K^+), 3) niedrig dosiertes Insulin weiter (bei BZ-Abfall Glukose zugeben, nicht stoppen). Bikarbonat nur ausnahmsweise.

Fall 19 · Nächtliche Unruhe (Intensiv)

1A	RICHTIG	Richtig – Delir ist ein Symptom; zuerst reversible Ursachen suchen.
1B		

FALSCH Benzodiazepine können das Delir verschlimmern (außer Entzugsdelir).

1C	VERTRETBAR	Erst Ursache + nicht-medikamentöse Maßnahmen; Fixierung/Sedierung sind nachrangig und riskant.
2A	VERTRETBAR	Medikamente nur bei starker Agitation/Eigengefährdung, nicht als Erstmaßnahme für jeden.
2B	RICHTIG	Korrekt – nicht-medikamentöse Maßnahmen zuerst.
3A	RICHTIG	Sehr gut – gezielt und überwacht.
3B	VERTRETBAR	Benzodiazepine verschlechtern das Delir meist – vermeiden.
4A	RICHTIG	Sehr gut – QT-Kontrolle bei Antipsychotika.
4B	VERTRETBAR	Score/QT/Ursachen gehören dazu.

Merke: ICU-Delir: reversible Ursachen ausschließen, nicht-medikamentöse Maßnahmen zuerst, Benzodiazepine meiden (außer Entzug), Antipsychotika nur gezielt (QT beachten), CAM-ICU.

Fall 20 · Reaktion auf Medikament

1A	VERTRETBAR	Zugang parallel, aber Adrenalin i.m. darf nicht warten.
1B	RICHTIG	Richtig – Adrenalin i.m. ist die wichtigste Sofortmaßnahme.
1C	VERTRETBAR	Wichtig, aber Second-Line – Adrenalin i.m. zuerst (lebensrettend).
2A	VERTRETBAR	i.v.-Adrenalin nur verdünnt/titriert unter Monitoring (Arrhythmiegefahr) – sonst i.m.
2B	RICHTIG	Korrekt.
3A	VERTRETBAR	Bei Atemwegsschwellung kein Abwarten.
3B	RICHTIG	Sehr gut – der Atemweg hat höchste Priorität.
4A	VERTRETBAR	Biphasische Reaktion möglich – ausreichend lange überwachen.
4B	RICHTIG	Sehr gut – an die biphasische Reaktion denken.

Merke: Anaphylaxie: Auslöser stoppen, Adrenalin i.m. zuerst (i.v. nur titriert), Volumen + O_2, früh Atemweg sichern; Antihistaminikum/Kortison Second-Line; biphasische Reaktion → längere Überwachung.

Fall 21 · Grundpflege beim beatmeten Patienten

1A	VERTRETBAR	Auch bewusstlose Patienten ansprechen.
1B	RICHTIG	Richtig – Ansprache und Hygiene gehören dazu.
1C	FALSCH	Hohe Infektionsgefahr auf der Intensivstation.
2A	FALSCH	Alarme müssen abgeklärt werden.
2B	VERTRETBAR	Monitorwerte sind hier zentral.
2C	RICHTIG	Sehr gut – kontinuierliche Beobachtung.
3A	RICHTIG	Richtig – spezielle Prophylaxen beim beatmeten Patienten.
3B	FALSCH	Nur Fachpersonal – Gefahr für den Patienten.
3C	VERTRETBAR	Mund-/Augenpflege sind hier unverzichtbar.
4A	VERTRETBAR	Beobachtungen vollständig dokumentieren.
4B	RICHTIG	Genau richtig.

Merke: 1. Lernjahr Intensiv: Patienten ansprechen, strikte Hygiene, Monitor beobachten, Spezialpflege nur unter Anleitung, Alarme ernst nehmen.

Fall 22 · Krampfanfall bei Fieber

1A	RICHTIG	Richtig – schützen, nichts in den Mund, Dauer messen.
1B	FALSCH	Nichts in den Mund – Verletzungs-/Aspirationsgefahr.
1C	VERTRETBAR	Nicht festhalten/fixieren – nur vor Verletzung schützen.
2A	VERTRETBAR	> 5 min = drohender Status epilepticus – behandeln.
2B	RICHTIG	Korrekt – ab ca. 5 min medikamentös durchbrechen (Status-Gefahr).
2C	VERTRETBAR	Fiebersenkung ist nachrangig; aggressive Kühlung ungünstig – erst Anfall + Atemweg.
3A	RICHTIG	Sehr gut – Ursachensuche + Beobachtung.
3B	VERTRETBAR	Ein (erstmaliger) Fieberkrampf gehört ärztlich abgeklärt.
4A	VERTRETBAR	Meningitis-Zeichen/Wiederholung/Atmung gehören dazu.
4B	RICHTIG	Sehr gut – Meningitis-Zeichen aktiv ausschließen.

Merke: Fieberkrampf: schützen (nichts in den Mund, nicht festhalten), Dauer messen, > 5 min medikamentös durchbrechen, danach Ursache/Red Flags (Meningitis!) abklären.

Fall 23 · Bellender Husten nachts

1A	FALSCH	Racheninspektion/Aufregung kann den Atemweg verschlechtern (cave Epiglottitis) – vermeiden.
1B	RICHTIG	Richtig – Aufregung verschlimmert den Stridor.
1C	VERTRETBAR	Inhalation kann helfen, aber kein Zwang – erst beruhigen.
2A	VERTRETBAR	Behandelt nicht die Atemwegsobstruktion.
2B	RICHTIG	Korrekt – Steroid ist Standard, vernebeltes Adrenalin bei schwerem Stridor.
2C	VERTRETBAR	Pseudokrupp ist meist viral – Antibiotika nicht primär.
3A	VERTRETBAR	Bei zunehmendem Stridor/Einziehungen eskalieren.
3B	RICHTIG	Sehr gut – schwerer Krupp: Adrenalininhalation + Eskalation.
4A	VERTRETBAR	Atemarbeit/SpO_2/Erschöpfung im Vordergrund.
4B	RICHTIG	Sehr gut – nach Adrenalin auf Rebound achten.

Merke: Pseudokrupp: Ruhe/aufrecht bei den Eltern, keine Racheninspektion, Steroid als Standard, vernebeltes Adrenalin bei schwerem Stridor; nach Adrenalin Rebound beachten; leiser Stridor + Erschöpfung = Alarm.

Fall 24 · Atemnot beim Säugling

1A	VERTRETBAR	Bronchiolitis ist meist viral (RSV) – Antibiotika nicht primär.
1B	FALSCH	Sedativa bei Atemnot kontraindiziert (Atemdepression); flach lagern ungünstig.
1C	RICHTIG	Richtig – Atemwege freihalten, O_2 titrieren, Ernährung/Atmung im Blick.
2A	RICHTIG	Korrekt – Flüssigkeit sichern, Aspiration vermeiden.
2B	VERTRETBAR	Bei Tachypnoe Aspirationsgefahr – kleine Mengen/Sonde.

3A	RICHTIG	Sehr gut – Apnoen beim jungen Säugling sind Warnzeichen.
3B	VERTRETBAR	Bei Apnoen/SpO_2-Abfall eskalieren – nicht nur abwarten.
4A	VERTRETBAR	Zielgerechte Sättigung; Apnoe/Trinkmenge gehören dazu.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: Bronchiolitis (RSV): Atemwege freihalten/absaugen, O_2 titrieren, Flüssigkeit sichern (Aspiration vermeiden), keine Sedativa; Apnoen beim jungen Säugling = Warnzeichen; Antibiotika nicht primär.

Fall 25 · Erbrechen & Durchfall

1A	FALSCH	Motilitätshemmer sind bei Kleinkindern/infektiösem Durchfall nicht indiziert.
1B	RICHTIG	Richtig – bei leichter/mittlerer Exsikkose ist ORS erste Wahl.
1C	VERTRETBAR	Cola/Saft (zuckerreich, elektrolytarm) ist ungeeignet – spezielle ORS, kleine Mengen.
2A	VERTRETBAR	Bei fortgesetzten Verlusten droht Verschlechterung – dranbleiben/eskalieren.
2B	RICHTIG	Korrekt – kleine Mengen häufig, bei Versagen i.v.
3A	VERTRETBAR	Bei Schock reicht oral nicht – i.v.
3B	RICHTIG	Sehr gut – schwere Dehydratation/Schock = i.v.-Rehydratation.
4A	VERTRETBAR	Vitalzeichen/Bilanz/Elektrolyte gehören dazu.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: Exsikkose bei Gastroenteritis: Grad einschätzen, ORS (kleine Mengen häufig) bei leicht/mittel, i.v. bei schwerer Dehydratation/Schock; keine Motilitätshemmer, kein Cola/Saft; Bilanz/Gewicht/Elektrolyte.

Fall 26 · Fieber mit Hautflecken

1A	RICHTIG	Richtig – nicht wegdrückbare Petechien + Fieber + Vigilanzminderung = Notfall.
1B	VERTRETBAR	Kein Abwarten – rasch progrediente Petechien sind ein Alarmzeichen.
1C	FALSCH	Bei septischen Petechien kein Abwarten – sofort handeln.
2A	VERTRETBAR	Die LP darf die Antibiose nicht verzögern – bei Sepsiszeichen Antibiose zuerst.
2B	RICHTIG	Korrekt – frühe Antibiose ist lebensentscheidend.
3A	RICHTIG	Sehr gut – septischer Schock, aggressive Stabilisierung.
3B	VERTRETBAR	Im Schock auch Kreislaufstabilisierung nötig.
4A	RICHTIG	Sehr gut – auch an Personalschutz/Umgebungsprophylaxe denken.
4B	VERTRETBAR	Kreislauf/Neuro/Diurese im Vordergrund.

Merke: Meningokokken-Sepsis: nicht wegdrückbare Petechien + Fieber = Notfall; frühe i.v.-Antibiose (nicht durch LP verzögern), Kreislauf stabilisieren, Intensiv; Isolation/Personalschutz + Umgebungsprophylaxe.

Fall 27 · Verschlucktes Kleinteil

1A	RICHTIG	Richtig – bei effektivem Husten nicht eingreifen, nur ermutigen und beobachten.
1B	VERTRETBAR	Solange der Husten effektiv ist, nicht schlagen – zuerst husten lassen.
1C		

FALSCH Blindes Auswischen kann den Fremdkörper tiefer schieben – verboten.

2A RICHTIG Korrekt – bei ineffektivem Husten Rückenschläge + Thoraxkompressionen, Notruf.

2B VERTRETBAR Beim Säugling keine Bauchstöße – Rückenschläge + Thoraxkompressionen.

3A VERTRETBAR Bei Bewusstlosigkeit CPR beginnen.

3B RICHTIG Sehr gut – CPR; nur sichtbaren Fremdkörper entfernen.

4A VERTRETBAR Nach Aspiration ärztliche Kontrolle nötig (Restmaterial/Komplikationen).

4B RICHTIG Sehr gut – immer ärztlich abklären.

Merke: Fremdkörperaspiration: effektiver Husten → ermutigen, nicht eingreifen, nie blind auswischen; ineffektiver Husten beim Säugling → 5 Rückenschläge + 5 Thoraxkompressionen (keine Bauchstöße!); Bewusstlosigkeit → CPR; danach immer ärztliche Kontrolle.

Fall 28 · Fieber beim Kind

1A VERTRETBAR Möglichst ohne Zwang – das erhöht sonst die Angst.

1B FALSCH Bezugspersonen geben dem Kind Sicherheit.

1C RICHTIG Richtig – Vertrauen nimmt dem Kind die Angst.

2A VERTRETBAR Wärmestau vermeiden – eher leicht bekleiden.

2B RICHTIG Sehr gut – Wickel nur bei warmer Peripherie.

2C FALSCH Kälteschock vermeiden – das ist kontraproduktiv.

3A FALSCH Bei Kindern kann sich der Zustand schnell ändern.

3B RICHTIG Richtig – Warnzeichen früh erkennen.

3C VERTRETBAR Zu eng – der Gesamtzustand zählt.

4A VERTRETBAR Dokumentation nicht vergessen.

4B RICHTIG Genau richtig.

Merke: 1. Lernjahr Pädiatrie: kindgerechte Kommunikation, Eltern einbeziehen, schonende Maßnahmen, Warnzeichen beobachten.

Fall 29 · Plötzlicher CO_2-Anstieg intraop.

1A FALSCH Bei etCO_2-Anstieg + Masseterspasmus kein Abwarten – Trigger sofort stoppen.

1B RICHTIG Richtig – Trigger weg, 100 % O_2, Team alarmieren.

1C FALSCH Volatile Anästhetika sind der Trigger – das verschlimmert die Krise.

2A VERTRETBAR Symptomatisch und riskant – die Ursache muss mit Dantrolen behandelt werden.

2B VERTRETBAR Kühlung ist Begleitmaßnahme – ohne Dantrolen bleibt die Krise unbehandelt.

2C RICHTIG Korrekt – Dantrolen ist die kausale Therapie.

3A RICHTIG Sehr gut – Hyperkaliämie, Azidose, Temperatur und Niere im Blick.

3B VERTRETBAR Hyperkaliämie/Azidose/CK sind kritisch – Labor und Behandlung gehören dazu.

4A RICHTIG Sehr gut – Intensivüberwachung, Rhabdomyolyse/Niere beachten.

4B

VERTRETBAR MH erfordert Intensivüberwachung (Rezidiv/Komplikationen).

Merke: Maligne Hyperthermie: Trigger sofort stoppen (volatile/Succinylcholin), 100 % O_2/Hyperventilation, Dantrolen schnellstmöglich, Hyperkaliämie/Azidose/Temperatur behandeln, Rhabdomyolyse/Niere überwachen, Intensiv.

Fall 30 · Stridor nach Extubation

1A	VERTRETBAR	Erst Atemwegsmanöver/CPAP; nicht in flacher Narkose blind intubieren.
1B	FALSCH	Bei Laryngospasmus/flacher Narkose nicht zielführend – aktiv den Atemweg öffnen.
1C	RICHTIG	Richtig – Atemwegsmanöver + CPAP mit 100 % O_2, störende Reize entfernen.
2A	VERTRETBAR	Bei anhaltender Hypoxie nicht nur abwarten.
2B	RICHTIG	Korrekt – Vertiefung bzw. Muskelrelaxans durchbricht den Spasmus.
3A	VERTRETBAR	Komplikation (Negativdruck-Lungenödem) möglich – weiter überwachen.
3B	RICHTIG	Sehr gut – nach Laryngospasmus kann ein Negativdruck-Lungenödem auftreten.
4A	RICHTIG	Sehr gut.
4B	VERTRETBAR	Auskultation/Atemarbeit/Re-Spasmus gehören dazu.

Merke: Laryngospasmus: 100 % O_2, Esmarch + CPAP, Reize entfernen; bei Persistenz Vertiefung/Succinylcholin nach AO; danach an Negativdruck-Lungenödem denken; nicht in flacher Narkose blind intubieren.

Fall 31 · Regurgitation bei Einleitung

1A	FALSCH	Nicht zielführend im Akutmoment – der Atemweg hat Priorität.
1B	RICHTIG	Richtig – Atemweg schützen: absaugen, intubieren/cuffen, O_2.
1C	VERTRETBAR	Maskenbeatmung kann Mageninhalt verteilen/insufflieren – erst absaugen und Atemweg sichern.
2A	VERTRETBAR	Nicht routinemäßig – Antibiotika nur bei Infektzeichen, Steroide werden nicht empfohlen.
2B	RICHTIG	Korrekt – absaugen, oxygenieren, ggf. Bronchoskopie.
3A	RICHTIG	Sehr gut – Aspirationspneumonitis/Bronchospasmus behandeln.
3B	VERTRETBAR	Unkontrolliert hoher Druck riskiert ein Barotrauma.
4A	VERTRETBAR	Drücke/Auskultation/Verlauf gehören dazu.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: Aspiration bei Einleitung: Kopftief/Seitenlage + sofort absaugen, Atemweg mit Cuff sichern (vor Maskenbeatmung), tracheobronchial absaugen, O_2/PEEP, ggf. Bronchoskopie; keine pauschalen Antibiotika/Steroide. Prävention: RSI bei nicht-Nüchternen.

Fall 32 · Symptome nach Regionalanästhesie

1A	RICHTIG	Richtig – Zufuhr stoppen, O_2, Team; LAST früh erkennen.
1B	FALSCH	Erhöht die Toxizität – absolut kontraindiziert.
1C	FALSCH	Bei Prodromi/Zuckungen kein Abwarten – LAST kann rasch in Krampf/Stillstand übergehen.
2A	VERTRETBAR	Die Lipidemulsion ist bei LAST entscheidend.
2B	RICHTIG	Korrekt – Lipidrescue ist die spezifische Therapie.

3A	VERTRETBAR	Bei LAST eher reduzierte Adrenalindosen; Lipidrescue steht im Vordergrund.
3B	RICHTIG	Sehr gut – bei LAST länger reanimieren, Adrenalin niedrig dosieren, Lipid weiter.
4A	VERTRETBAR	Rezidivgefahr – ausreichend lange überwachen.
4B	RICHTIG	Sehr gut – LAST kann rezidivieren, lange überwachen.

Merke: LAST: Zufuhr sofort stoppen, O_2/Atemweg, Krampf durchbrechen, Lipidemulsion 20 % (Lipidrescue) als spezifische Therapie; bei Stillstand prolongierte Reanimation mit reduzierten Adrenalindosen; längere Intensivüberwachung (Rezidiv).

Fall 33 · Flache Atmung im Aufwachraum

1A	RICHTIG	Richtig – stimulieren, Atemweg/O_2, Vitalüberwachung.
1B	FALSCH	Bei AF 6 + SpO_2 88 % keine harmlose Müdigkeit – Atemdepression behandeln.
1C	VERTRETBAR	Naloxon vorsichtig titrieren (Schmerz/Entzug/Lungenödem!) – nicht reflexartig als großer Bolus.
2A	RICHTIG	Korrekt – Naloxon titrieren; differenzialdiagnostisch auch Relaxansüberhang.
2B	VERTRETBAR	O_2 allein behebt die zentrale Atemdepression oft nicht – Ursache angehen.
3A	VERTRETBAR	Muskelschwäche spricht für Relaxansüberhang – nicht ignorieren.
3B	RICHTIG	Sehr gut – an Restrelaxierung denken (TOF), ggf. antagonisieren.
4A	VERTRETBAR	Re-Sedierung möglich – ausreichend lange überwachen.
4B	RICHTIG	Sehr gut – Naloxon wirkt kürzer als das Opioid → Re-Sedierung möglich.

Merke: Postoperative Atemdepression: stimulieren, Atemweg/O_2; Opioidüberhang → Naloxon titriert (kein großer Bolus; Re-Sedierung beachten, da kürzere Wirkdauer); an Relaxansüberhang denken (TOF, Antagonisierung); lange überwachen.

Fall 34 · Kreislauf nach Spinalanästhesie

1A	FALSCH	Aufsetzen lässt Blockade/Hypotonie verschlimmern – flach/Beine hoch.
1B	RICHTIG	Richtig – Lagerung, Volumen, Vasopressor; bei Schwangeren aortocavale Kompression vermeiden.
1C	VERTRETBAR	Bei symptomatischer Hypotonie/Bradykardie nicht abwarten.
2A	RICHTIG	Korrekt – Atropin bei symptomatischer Bradykardie, Kreislauf stützen.
2B	VERTRETBAR	Symptomatische Bradykardie braucht Atropin – nicht nur Volumen.
3A	VERTRETBAR	Aufsteigende Blockade mit Atemnot ist bedrohlich – Atemweg/Beatmung vorbereiten.
3B	RICHTIG	Sehr gut – hohe/totale Spinale kann die Atemmuskulatur lähmen.
4A	RICHTIG	Sehr gut.
4B	VERTRETBAR	HF/Atmung/Blockadehöhe engmaschig.

Merke: Hypotonie/Bradykardie nach Spinalanästhesie: flach/Beine hoch (Schwangere: Linksseitenlage gegen aortocavale Kompression), Volumen + Vasopressor, Atropin bei symptomatischer Bradykardie; bei hoher/totaler Spinale Atemweg/Beatmung sichern.

Fall 35 · Vorbereitung zur Narkose

1A	VERTRETBAR	Identität und Checkliste gehören vollständig geprüft.
1B	RICHTIG	Richtig – Patientensicherheit zuerst.

1C FALSCH Schwerer Sicherheitsfehler.

2A VERTRETBAR Schmuck muss vor der OP entfernt werden.

2B FALSCH Allergien sind sicherheitsrelevant.

2C RICHTIG Sehr gut – vollständige Vorbereitung.

3A RICHTIG Richtig – Sicherheit durch Information und Zuwendung.

3B VERTRETBAR Ängste ernst nehmen ist Teil der Vorbereitung.

3C FALSCH Respektlos und nicht hilfreich.

4A VERTRETBAR Übergabe und Doku müssen vollständig sein.

4B RICHTIG Genau richtig.

Merke: 1. Lernjahr Anästhesie: Identität und Nüchternheit prüfen, Checkliste vollständig, Ängste ernst nehmen, lückenlose Übergabe.

Fall 36 · Hoffnungslosigkeit und Rückzug

1A FALSCH Bagatellisieren/Ablenken signalisiert, dass das Thema unerwünscht ist – ernst nehmen und zuhören.

1B RICHTIG Richtig – ernst nehmen, präsent sein, wertfrei ins Gespräch gehen.

1C FALSCH Bei möglicher Suizidalität nicht allein lassen – Beziehung halten.

2A RICHTIG Korrekt – offenes Ansprechen erhöht das Risiko nicht, sondern entlastet und schafft Klarheit.

2B VERTRETBAR Ein Mythos – offenes Ansprechen bringt niemanden auf Ideen, sondern öffnet das Gespräch.

3A RICHTIG Sehr gut – Sicherheit, nicht allein lassen, Arzt/Team einbeziehen.

3B FALSCH Keine Geheimhaltung bei Suizidalität – Schutz geht vor, das Team muss informiert werden.

4A VERTRETBAR Suizidalität erfordert ein abgestimmtes, engmaschiges Vorgehen – nicht zur Tagesordnung übergehen.

4B RICHTIG Sehr gut – Schutz, Beziehung, ärztliche Einschätzung und Dokumentation.

Merke: Akute Suizidalität: ernst nehmen, präsent bleiben/nicht allein lassen, Suizidgedanken offen und wertfrei ansprechen (erhöht das Risiko nicht), keine Geheimhaltung, sichere Umgebung, Arzt/zuständiges Team umgehend einbeziehen, engmaschige Betreuung und Dokumentation.

Fall 37 · Angespannter, gereizter Patient

1A RICHTIG Richtig – Ruhe, Distanz, reizarm, Deeskalation durch Beziehung.

1B VERTRETBAR Lautes, konfrontatives Auftreten eskaliert oft – deeskalierend bleiben.

1C FALSCH Körperlicher Zwang ist kein Erstmittel – zuerst deeskalieren, Zwang nur als letztes Mittel mit klaren Voraussetzungen.

2A VERTRETBAR Wahn lässt sich nicht 'wegdiskutieren' – nicht bestätigen, aber auch nicht streiten; bei den Gefühlen bleiben.

2B RICHTIG Korrekt – Beziehung, klare einfache Kommunikation, Eigenschutz.

3A RICHTIG Sehr gut – Team, Schutz, Arzt/Medikation nach AO, weiter deeskalieren.

3B VERTRETBAR Bei Gefährdung kein Alleingang – Team und Eigenschutz.

4A VERTRETBAR Zwangsmaßnahmen brauchen ärztliche Anordnung, rechtliche Grundlage, Überwachung und Dokumentation – nie im Alleingang.

4B RICHTIG Sehr gut – Zwang nur als Ultima Ratio mit rechtlicher Grundlage, ärztlicher Anordnung, Überwachung und Doku.

Merke: Psychotische Erregung: ruhig, reizarm, Distanz/Eigenschutz, deeskalierende Kommunikation (zuhören, einfache Sätze, Wahn nicht bestätigen, aber nicht streiten), Team und Arzt einbeziehen, Medikation nach AO anbieten; freiheitsentziehende Maßnahmen nur als Ultima Ratio bei akuter Gefahr mit ärztlicher Anordnung, rechtlicher Grundlage (PsychKG), Überwachung und Dokumentation.

Fall 38 · Getriebene, rastlose Patientin

1A	VERTRETBAR	Strenge Konfrontation führt zu Reibung/Eskalation – ruhig und strukturierend.
1B	RICHTIG	Richtig – Ruhe, Struktur, reizarm, Beziehung statt Machtkampf.
1C	VERTRETBAR	Das befeuert die Manie – freundlich, aber nicht in die Getriebenheit einsteigen.
2A	RICHTIG	Korrekt – Reizreduktion, Schlaf, Schutz vor selbstschädigenden Folgen, Grundbedürfnisse.
2B	VERTRETBAR	Bei fehlender Einsicht und Selbstgefährdung braucht es schützende Struktur.
3A	RICHTIG	Sehr gut – körperliche Erschöpfung/Exsikkose im Blick behalten.
3B	VERTRETBAR	Manie erschöpft auch körperlich – Flüssigkeit/Ernährung/Erschöpfung beachten.
4A	VERTRETBAR	Heimliche Gabe ist unzulässig – transparent vorgehen, bei Gefährdung rechtlich abgesicherte Maßnahmen.
4B	RICHTIG	Sehr gut – erst Motivation/Beziehung, Schutzmaßnahmen nur bei Gefährdung mit ärztlicher/rechtlicher Grundlage.

Merke: Akute Manie: ruhig, wertschätzend, klare Struktur, reizarme Umgebung, Schlaf fördern, Beziehung statt Machtkampf; vor selbstschädigenden Folgen (finanziell/sozial) und körperlicher Erschöpfung/Exsikkose schützen; Medikation nach AO anbieten; keine heimliche Gabe; Schutzmaßnahmen nur bei akuter Gefährdung mit ärztlicher Einschätzung/rechtlicher Grundlage (PsychKG).

Fall 39 · Tremor und Unruhe ohne Alkohol

1A	FALSCH	Alkoholentzug kann lebensbedrohlich werden (Delir/Krampf) – nicht bagatellisieren.
1B	RICHTIG	Richtig – Entzug erkennen, Vitalzeichen, Schweregrad erfassen, Arzt einbeziehen.
1C	FALSCH	Alkohol ist keine pflegerische Maßnahme – strukturierte Entzugsbehandlung nach AO.
2A	VERTRETBAR	Unbehandelt drohen Delir/Krampf – strukturierte Behandlung und Überwachung.
2B	RICHTIG	Korrekt – symptomorientierte Medikation nach Schema, Thiamin, Flüssigkeit, Monitoring.
3A	VERTRETBAR	Delir und Krampfanfall sind die gefährlichen Komplikationen – breiter beobachten.
3B	RICHTIG	Sehr gut – Delir und Entzugskrampf rechtzeitig erkennen, Sicherheit herstellen.
4A	VERTRETBAR	Entzug verläuft über Tage – weiter engmaschig überwachen.
4B	RICHTIG	Sehr gut – strukturierte, sichere, engmaschige Begleitung.

Merke: Alkoholentzugssyndrom: erkennen, Vitalzeichen + Schweregrad (Skala), Arzt einbeziehen; symptomorientierte Medikation nach Schema (z. B. Benzodiazepine), Thiamin (Wernicke-Prophylaxe), Flüssigkeit/Elektrolyte; auf Delir und Entzugskrampf achten; reizarme sichere Umgebung, engmaschige Überwachung über Tage; kein Alkohol als 'Therapie', kein Abwarten.

Fall 40 · Plötzliche Atemnot und Todesangst

1A	RICHTIG	Richtig – Ruhe ausstrahlen, präsent sein, beruhigend führen.
1B	VERTRETBAR	Eigene Hektik überträgt sich – ruhig und strukturiert bleiben.
1C	FALSCH	Abwertung verstärkt die Angst – ernst nehmen und beruhigend begleiten.
2A		

RICHTIG Korrekt – Panikattacke ist eine Ausschlussdiagnose; Somatik nicht übersehen.

2B VERTRETBAR Symptome können auch körperlich bedingt sein – im Zweifel abklären.

3A RICHTIG Sehr gut – ruhige Atemführung und Präsenz, keine Beschämung.

3B VERTRETBAR Schnelles Atmen verstärkt die Hyperventilation – zu langsamem Atmen anleiten.

4A RICHTIG Sehr gut – Nachgespräch, Psychoedukation, Anbindung.

4B VERTRETBAR Ein kurzes Nachgespräch und Sicherheit sind hilfreich.

Merke: Panikattacke: ruhig und präsent bleiben, ernst nehmen, beruhigen, zu langsamem Atmen anleiten; trotzdem bedrohliche körperliche Ursachen prüfen (Ausschlussdiagnose, Vitalzeichen/SpO_2, im Zweifel ärztlich abklären); nach der Attacke kurzes Nachgespräch, Psychoedukation und Anbindung; keine Abwertung, keine eigene Hektik.

Fall 41 · Fieber und Rigor unter Neuroleptika

1A RICHTIG Richtig – MNS ist ein lebensbedrohlicher Notfall: Arzt sofort, Vitalzeichen, Neuroleptikum-Stopp veranlassen.

1B FALSCH Neuroleptika sind der Auslöser – eine Erhöhung verschlimmert das MNS.

1C VERTRETBAR Rigor + Fieber + Bewusstseinstrübung unter Neuroleptika spricht für MNS – nicht nur als Infekt abtun.

2A VERTRETBAR Symptomatische Fiebersenkung allein reicht nicht – Trigger absetzen, supportiv/Intensiv.

2B RICHTIG Korrekt – Trigger absetzen, supportiv stabilisieren, Intensiv.

3A VERTRETBAR MNS kann zu Rhabdomyolyse/Nierenversagen führen – breiter überwachen.

3B RICHTIG Sehr gut – Rhabdomyolyse/Niere, Elektrolyte und Kreislauf im Blick.

4A RICHTIG Sehr gut – Intensivüberwachung und supportive Therapie.

4B VERTRETBAR MNS erfordert intensive Überwachung – nicht zu früh zurückverlegen.

Merke: Malignes neuroleptisches Syndrom: lebensbedrohlicher Notfall (Fieber, Rigor, Bewusstseinstrübung, autonome Entgleisung unter Neuroleptika) – Arzt sofort, auslösendes Neuroleptikum absetzen (nach AO), supportiv stabilisieren (kühlen, Flüssigkeit/Elektrolyte, Vitalfunktionen), auf Rhabdomyolyse/Nierenversagen achten, Intensivüberwachung; die Dosis nie erhöhen, nicht als reinen Infekt verkennen.

Fall 42 · Das erste Gespräch

1A VERTRETBAR Gut gemeint, kann aber Druck erzeugen.

1B RICHTIG Richtig – Beziehung beginnt mit Zuhören.

1C FALSCH Beziehungsangebot ist gerade jetzt wichtig.

2A FALSCH Veränderungen würden übersehen.

2B RICHTIG Sehr gut – wichtige Verlaufsbeobachtung.

2C VERTRETBAR Der Gesamteindruck zählt.

3A FALSCH Solche Hinweise dürfen nie verschwiegen werden.

3B VERTRETBAR Besser ernst nehmen und im Team besprechen.

3C RICHTIG Richtig – Hinweise auf Eigengefährdung immer weitergeben.

4A RICHTIG Genau richtig.

4B VERTRETBAR Verlässliche Begleitung ist wichtig.

Merke: 1. Lernjahr Psychiatrie: wertschätzende Beziehung, zuhören, Stimmung beobachten, Hinweise auf Eigengefährdung immer ans Team weitergeben.

Fall 43 · Wundliegen vorbeugen

1A	RICHTIG	Der Fingertest unterscheidet eine harmlose Rötung von einer beginnenden Druckschädigung (nicht wegdrückbar = Alarm).
1B	FALSCH	Gefährdete, gerötete Haut wird nicht massiert – das schädigt das Gewebe zusätzlich.
1C	VERTRETBAR	Bei bettlägerigen Menschen ist eine Rötung ein Warnzeichen – beobachten und handeln statt abwarten.
2A	RICHTIG	Druckentlastung durch Lagewechsel/Bewegung ist die zentrale Dekubitusprophylaxe.
2B	VERTRETBAR	Punktuelles Unterpolstern (z. B. 'Ring') kann den Druck sogar erhöhen – flächig entlasten und umlagern.
3A	VERTRETBAR	Auch kleine Eigenbewegung ist wertvoll – Ressourcen fördern statt komplett abnehmen.
3B	RICHTIG	

Merke: Dekubitusprophylaxe: gefährdete Haut mit dem Fingertest prüfen (nicht wegdrückbar = Alarm), nicht massieren, konsequent Druck entlasten (Lagewechsel/Bewegung), Haut pflegen und trocken halten, Eigenbewegung fördern und alles dokumentieren.

Fall 44 · Sicher auf den Beinen

1A	RICHTIG	Risikofaktoren erkennen und gezielt vorbeugen ist der richtige Einstieg.
1B	VERTRETBAR	Selbstbestimmung ja – aber Risiken aktiv ansprechen und das Umfeld sichern gehört zur Fürsorge.
1C	FALSCH	Freiheitsentziehende Maßnahmen sind kein Standard-Sturzschutz (rechtlich/ethisch heikel, Verletzungsgefahr) – erst Umfeld und Begleitung.
2A	VERTRETBAR	Das ist unverhältnismäßig – Wege sichern und begleiten statt einschränken.
2B	RICHTIG	Ein sicheres, gut beleuchtetes Umfeld senkt das Sturzrisiko deutlich.
3A	FALSCH	Allein und gehetzt ist die Sturzgefahr am höchsten.
3B	RICHTIG	

Merke: Sturzprophylaxe: Risikofaktoren erkennen (Schwäche, Unsicherheit, nächtliche Wege), Umfeld sichern (Stolperfallen weg, Licht, Rufanlage, Hilfsmittel), zeitnah begleiten und Tempo anpassen, Selbstbestimmung achten – freiheitsentziehende Maßnahmen sind kein Standard-Sturzschutz.

Fall 45 · Werte deuten und melden

1A	FALSCH	Fieber plus erhöhter Puls am OP-Tag ist ein Warnzeichen – nicht ignorieren.
1B	RICHTIG	Auffällige Werte vollständig erfassen, dokumentieren und melden – richtig.
1C	FALSCH	Medikamente gibt man nicht eigenmächtig – erst melden, Gabe nur nach AO.
2A	RICHTIG	Eine klare, strukturierte Übergabe hilft, schnell richtig zu reagieren.
2B	VERTRETBAR	Ohne konkrete Werte kann niemand richtig einschätzen.
3A	RICHTIG	
3B	VERTRETBAR	Bei auffälligen Werten ist Nachkontrolle wichtig.

Merke: Vitalzeichen: auffällige Werte vollständig erfassen (Temp, Puls, RR, Atmung, ggf. SpO_2), keine eigenmächtige Medikamentengabe, strukturiert und mit konkreten Werten melden, dokumentieren und nachkontrollieren.

Fall 46 · Ankommen und Vertrauen schaffen

1A	VERTRETBAR	Auch unter Zeitdruck kurz, aber zugewandt – das nimmt Angst und beugt Missverständnissen vor.
1B	RICHTIG	Eine wertschätzende, verständliche Kommunikation schafft Vertrauen.
1C	FALSCH	Sprich mit der Patientin selbst (Respekt/Autonomie) – Angehörige einbeziehen, aber nicht ersetzen.
2A	RICHTIG	Verständnis sichern statt Fachjargon.
2B	VERTRETBAR	Lauter ist nicht verständlicher – einfache Worte wählen.
3A	RICHTIG	
3B	VERTRETBAR	Gefühle ernst nehmen und Würde aktiv schützen.

Merke: Kommunikation/Aufnahme: sich vorstellen, Zeit nehmen, aktiv zuhören, in einfacher Sprache erklären und Verständnis sichern, mit der Patientin selbst sprechen (Autonomie), Gefühle ernst nehmen, Intimsphäre und Würde schützen, Selbstständigkeit fördern.

Fall 47 · Körperpflege mit Würde

1A	RICHTIG	Aktivierende Pflege fördert Selbstständigkeit und Würde.
1B	FALSCH	Intimsphäre wahren: Tür/Sichtschutz, vorher erklären und um Erlaubnis fragen.
1C	VERTRETBAR	Komplettübernahme baut Selbstständigkeit ab – nur so viel helfen wie nötig.
2A	VERTRETBAR	Das verletzt Würde und Schamgefühl – Privatsphäre konsequent schützen.
2B	RICHTIG	Intimsphäre und Beobachtung gehören zusammen.
3A	RICHTIG	
3B	VERTRETBAR	Hautveränderungen gehören beobachtet, dokumentiert und gemeldet.

Merke: Körperpflege: ressourcenorientiert arbeiten (selbst machen lassen, was geht, nur nötige Hilfe), vorher erklären und Einverständnis einholen, Intimsphäre und Würde schützen (Sichtschutz, nur Nötiges freilegen, angenehme Temperatur), Hautzustand beobachten, dokumentieren und melden.

Fall 48 · Atmen nach der OP

1A	FALSCH	Husten ist hier schützend; Medikamente nur nach AO – nicht eigenmächtig.
1B	VERTRETBAR	Reine Schonung erhöht das Pneumonierisiko – aktivierende Atem- und Bewegungsförderung ist richtig.
1C	RICHTIG	Flache Atmung plus Immobilität begünstigen eine Lungenentzündung – gezielt vorbeugen.
2A	RICHTIG	Aufrechte Position, tiefe Atmung und Mobilisation belüften die Lunge.
2B	VERTRETBAR	Flachlage erschwert die Atmung – Oberkörper hoch.
3A	VERTRETBAR	Schmerz ernst nehmen – sonst bleibt die Atmung flach.
3B	RICHTIG	

Merke: Pneumonieprophylaxe: Risiko erkennen (flache Atmung, wenig Husten, Immobilität), Oberkörper hoch, tiefe Atmung und Abhusten anleiten (Wunde stützen), regelmäßig mobilisieren, Schmerz ernst nehmen und melden (Therapie nach AO) – keine eigenmächtige Medikamentengabe.

Fall 49 · Genug trinken im Alter

1A	RICHTIG	Diese Zeichen sprechen für Flüssigkeitsmangel – gegensteuern und melden.
1B	FALSCH	Auch ältere Menschen brauchen ausreichend Flüssigkeit – das Durstgefühl ist im Alter oft vermindert.
1C	VERTRETBAR	Bei Zeichen von Austrocknung nicht abwarten – aktiv anbieten und beobachten.
2A	VERTRETBAR	Zwang und große Mengen auf einmal sind ungünstig – lieber regelmäßig kleine Mengen.
2B	RICHTIG	Niederschwellige, regelmäßige Trinkangebote helfen am meisten.
3A	VERTRETBAR	Anhaltend wenig Trinken plus Verschlechterung gehört gemeldet.
3B	RICHTIG	

Merke: Flüssigkeitsmangel im Alter: Zeichen erkennen (trockene Schleimhäute, stehende Hautfalte, Müdigkeit/Verwirrtheit, wenig Trinken), regelmäßig kleine Mengen anbieten und erinnern, beim Trinken helfen, Trinkmenge/Ein- und Ausfuhr erfassen, bei anhaltend wenig Trinken oder Verschlechterung melden und dokumentieren.

Fall 50 · Wenn der Appetit fehlt

1A	VERTRETBAR	Druck verstärkt die Ablehnung – Ursachen klären und das Essen anpassen.
1B	FALSCH	Nicht übergehen – wenig Essen und Gewichtsverlust sind ernst zu nehmen und zu melden.
1C	RICHTIG	Mangelernährung früh erkennen und gegensteuern.
2A	RICHTIG	Kost an Bedürfnisse anpassen und eine angenehme Esssituation schaffen.
2B	VERTRETBAR	Große, immer gleiche Portionen schrecken eher ab – lieber klein, abwechslungsreich, passend.
3A	VERTRETBAR	Anhaltender Gewichtsverlust gehört gemeldet und abgeklärt.
3B	RICHTIG	

Merke: Mangelernährung: Warnzeichen erkennen (wenig Essen, Gewichtsverlust, Kauprobleme), Essmenge und Gewicht beobachten/dokumentieren, Ursachen ansprechen, Kost an Bedürfnisse anpassen (Vorlieben, Konsistenz, kleine appetitliche Portionen, angenehme Esssituation), bei anhaltendem Gewichtsverlust melden und abklären lassen.

Fall 51 · Plötzliche Halbseitensymptomatik

1A	FALSCH	Bei akutem Defizit kein Abwarten – jede Minute zählt (Lyse-Fenster).
1B	RICHTIG	Schlaganfall ist 'time is brain': FAST, Zeitfenster, Team, Patient nüchtern.
1C	FALSCH	Bei Schluckstörung/Schlaganfall droht Aspiration – nüchtern lassen.
2A	RICHTIG	BZ messen (Hypoglykämie ahmt Schlaganfall nach!), CT vor Lyse, Vitalwerte.
2B	VERTRETBAR	Beim akuten ischämischen Schlaganfall wird der Blutdruck nicht vorschnell stark gesenkt – nach Schema/AO.
3A	VERTRETBAR	Erst Schluck-Screening; flaches Liegen und orale Gabe sind ungünstig bzw. riskant.
3B	RICHTIG	Schluck-Screening vor erster oraler Gabe, Oberkörper hoch, Neuromonitoring.
4A	VERTRETBAR	Engmaschiges Neuromonitoring ist nötig.
4B	RICHTIG	

Merke: Akuter Schlaganfall: FAST, Symptombeginn/Zeitfenster, sofort Stroke-Unit; BZ messen (Hypoglykämie als Mimic), CT vor Lyse, Blutdruck nach Schema (nicht vorschnell senken), nüchtern bis Schluck-Screening, Oberkörper 30°, engmaschiges Neuromonitoring.

Fall 52 · Anhaltender Krampfanfall

1A	RICHTIG	Schützen, nichts in den Mund, Atemweg/O_2, Dauer messen, Team.
1B	FALSCH	Ab >5 min = Status epilepticus, der durchbrochen werden muss – nicht abwarten.
1C	FALSCH	Nicht festhalten, nichts in den Mund (Verletzungsgefahr) – nur die Umgebung sichern.
2A	RICHTIG	Benzodiazepin als erste Stufe, BZ (Hypoglykämie!) prüfen.
2B	VERTRETBAR	Stufenweise nach Schema; unkontrollierte Mehrfachgabe riskiert Atemdepression.
3A	VERTRETBAR	Postiktal nicht sofort oral/mobilisieren – Vigilanz und Schlucken beachten.
3B	RICHTIG	Nach Benzodiazepin ist Atemdepression möglich – Atemweg sichern.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Re-Anfall und Atemdepression sind möglich – weiter überwachen.

Merke: Status epilepticus (>5 min): schützen, nichts in den Mund, Atemweg/O_2, Dauer messen; Benzodiazepin nach Schema, BZ prüfen; nach Sistieren Atemweg/Atemdepression beachten, Vigilanz/SpO_2/BZ überwachen, auf erneuten Anfall vorbereitet sein.

Fall 53 · Vernichtungskopfschmerz

1A	RICHTIG	Ein Donnerschlagkopfschmerz ist bis zum Beweis des Gegenteils eine SAB.
1B	FALSCH	Plötzlicher Vernichtungskopfschmerz ist keine banale Migräne – sofort abklären.
2A	RICHTIG	CT, Neuromonitoring, Blutdruck nach AO (Nachblutungsrisiko).
2B	VERTRETBAR	Pressen/Anstrengung erhöht das Nachblutungsrisiko – Ruhe.
3A	RICHTIG	Reizabschirmung, auf Nachblutungs-/Hirndruckzeichen achten.
3B	VERTRETBAR	Reize und Anstrengung sind ungünstig – reizarm und ruhig.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Neuromonitoring und Komplikationen im Blick behalten.

Merke: SAB (Donnerschlagkopfschmerz): sofort abklären (CT), nicht als Migräne abtun; strenge Ruhe, Reizabschirmung, Blutdruck nach AO, Pressen vermeiden, engmaschig Bewusstsein/Pupillen, auf Nachblutung/Hirndruck/Vasospasmus achten, Intensiv.

Fall 54 · Eintrübung mit weiter Pupille

1A	RICHTIG	Hirndruckzeichen + Cushing-Reflex = Notfall: Oberkörper hoch, Kopf neutral, Arzt sofort.
1B	FALSCH	Vigilanzabfall plus weite Pupille sind Alarmzeichen – nicht abwarten.
2A	VERTRETBAR	Kopftief-/Flachlage erhöht den Hirndruck – Oberkörper hoch, Kopf gerade.
2B	RICHTIG	Lagerung für venösen Abfluss, Hirndruck senken nach AO, Intensiv.
3A	VERTRETBAR	Starke Reize und unsachgemäßes Absaugen steigern den Hirndruck – schonend, nach AO.
3B	RICHTIG	GCS/Pupillen, hirndrucksteigernde Faktoren vermeiden.
4A	RICHTIG	

4B VERTRETBAR Kontinuierliches Neuromonitoring ist nötig.

Merke: Erhöhter Hirndruck/drohende Einklemmung (Vigilanzabfall, weite Pupille, Cushing-Reflex): Notfall – Oberkörper ~30°, Kopf in Mittelstellung (venöser Abfluss), O_2/Atemweg, hirndrucksteigernde Faktoren (Pressen/Husten/Schmerz/Halsknick) vermeiden, kontinuierlich GCS/Pupillen/Vitalzeichen, Therapie nach AO, Intensiv.

Fall 55 · Zunehmende Muskelschwäche

1A FALSCH Bei Schluckstörung droht Aspiration – nüchtern lassen, Atemweg sichern.

1B RICHTIG Die Atemmuskulatur ist gefährdet: Atmung/Schlucken im Fokus, Arzt sofort.

2A RICHTIG Vitalkapazität/Atemarbeit überwachen, rechtzeitig eskalieren.

2B VERTRETBAR Bei drohender Ateminsuffizienz engmaschig überwachen, nicht allein lassen.

3A RICHTIG Aspirationsschutz, Kräfteschonung, Medikamente nach AO.

3B VERTRETBAR Überlastung verstärkt die Schwäche – dosiert, Kräfte schonen.

4A RICHTIG

4B VERTRETBAR Die Krise kann rasch eskalieren – engmaschig bleiben.

Merke: Myasthene Krise: Atem- und Schluckmuskulatur gefährdet – Atmung/SpO_2/Vitalkapazität engmaschig, respiratorische Erschöpfung früh erkennen, O_2/Beatmungsbereitschaft, Aspirationsschutz (nüchtern bei Schluckstörung), Kräfte schonen, Medikamente exakt nach AO, Intensiv.

Fall 56 · Rückenschmerz mit Taubheit

1A FALSCH Mit diesen Red Flags ist das kein banaler Rückenschmerz – sofortige Abklärung.

1B RICHTIG Reithosenanästhesie plus Blasenstörung = Cauda-Notfall, sofort melden.

2A VERTRETBAR Bei Cauda-Syndrom drohen bleibende Schäden – rasche OP-Abklärung, kein Abwarten.

2B RICHTIG MRT dringlich, Blasenfunktion/Neurostatus dokumentieren; Zeit zählt für die Prognose.

3A RICHTIG Neurostatus, Blasenmanagement, OP-Vorbereitung.

3B VERTRETBAR Die neurologischen Ausfälle sind hier das Entscheidende – engmaschig beobachten.

4A RICHTIG

4B VERTRETBAR Dringlichkeit – nicht auf die Routine warten.

Merke: Cauda-equina-Syndrom (Reithosenanästhesie, Blasenentleerungsstörung, Beinschwäche): neurochirurgischer Notfall – sofort melden, dringend MRT, Neurostatus und Blasenfunktion dokumentieren/managen, rasche OP-Abklärung (Zeit beeinflusst die Prognose); nicht konservativ abwarten.

Fall 57 · Sturzgefahr nach Schlaganfall

1A FALSCH Bei Halbseitenschwäche ist das hochgefährlich.

1B FALSCH Fixierung ist freiheitsentziehend und nur mit Anordnung erlaubt.

1C RICHTIG Richtig – hohes Sturzrisiko.

2A VERTRETBAR Rutschgefahr – festes Schuhwerk ist sicherer.

2B RICHTIG Sehr gut – sicherer Transfer.

2C FALSCH Sturz- und Verletzungsgefahr.

3A	VERTRETBAR	Zu eng gefasst.
3B	FALSCH	Neurologische Verschlechterung würde übersehen.
3C	RICHTIG	Richtig – z. B. Aspirationsgefahr bei Schluckstörung.
4A	VERTRETBAR	Ein Teilaspekt – die Sturzprophylaxe ist umfassender.
4B	RICHTIG	Genau richtig.

Merke: 1. Lernjahr Neurologie: Sturzrisiko erkennen, sicherer Transfer, Schlucken/Orientierung beobachten, keine eigenmächtige Fixierung.

Fall 58 · Fieber unter Chemotherapie

1A	RICHTIG	Febrile Neutropenie ist ein Notfall – keine Zeit verlieren.
1B	FALSCH	Bei Neutropenie kann sich rasch eine Sepsis entwickeln – nicht abwarten.
2A	VERTRETBAR	Antibiose nicht bis zum Kulturergebnis verzögern – kalkuliert nach AO starten.
2B	RICHTIG	Blutkulturen, dann zügig Antibiose; Verzögerung verschlechtert die Prognose.
3A	RICHTIG	Schutzisolation und Sepsismonitoring.
3B	VERTRETBAR	Bei Neutropenie strenge Hygiene/Schutzmaßnahmen – Infektionsrisiko minimieren.
4A	VERTRETBAR	Sepsisgefahr – engmaschig bleiben.
4B	RICHTIG	

Merke: Febrile Neutropenie: onkologischer Notfall – sofort Arzt, Blutkulturen/Fokussuche vor Antibiose, dann zügige kalkulierte Antibiose nach AO (nicht auf das Kulturergebnis warten), Kreislauf-/Sepsismonitoring, strenge Schutzisolation/Hygiene, Intensiv bei Verschlechterung.

Fall 59 · Entgleisung nach Chemo-Start

1A	FALSCH	Die Elektrolytentgleisung (v. a. Hyperkaliämie) ist gefährlich – nicht abwarten.
1B	RICHTIG	Das Tumorlyse-Syndrom ist ein onkologischer Notfall mit Hyperkaliämie- und Nierenrisiko.
2A	VERTRETBAR	Gerade ausreichende Hydrierung schützt die Niere – nicht restriktiv (außer bei Anurie/Überwässerung nach AO).
2B	RICHTIG	Volumen, Elektrolyt-/Hyperkaliämiemanagement, Harnsäure, Niere im Blick.
3A	RICHTIG	Hyperkaliämie = EKG-Monitoring; Niere/Bilanz im Blick.
3B	VERTRETBAR	Beim TLS sind EKG/Elektrolyte/Niere entscheidend, nicht die Temperatur.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Den TLS-Verlauf engmaschig kontrollieren.

Merke: Tumorlyse-Syndrom: Notfall durch Zellzerfall (Hyperkaliämie/-phosphatämie/-urikämie, Hypokalzämie, Nierengefahr) – ausreichende Hydrierung nach AO, EKG-/Elektrolyt-/Nierenmonitoring, Hyperkaliämie und Harnsäure behandeln nach AO, Bilanz, ggf. Intensiv/Dialyse.

Fall 60 · Gestaute Halsvenen, Atemnot

1A	FALSCH	Flachlage verstärkt die Stauung und Atemnot – Oberkörper hochlagern.
1B	RICHTIG	Oberkörper hoch (venöser Rückfluss/Atmung), O_2, Arzt.

2A	VERTRETBAR	Zugänge/Messungen besser nicht am gestauten Bereich – die Stauung nicht verstärken.
2B	RICHTIG	Symptomatisch (Lagerung/O_2) plus rasche ursächliche Therapieplanung.
3A	RICHTIG	Atemwegssicherheit, Lagerung, Angst, Verlauf.
3B	VERTRETBAR	Flachlage/Anstrengung verstärken die Symptomatik – Oberkörper hoch, Ruhe.
4A	VERTRETBAR	Engmaschige Atemüberwachung ist nötig.
4B	RICHTIG	

Merke: Obere Einflussstauung (VCSS): Oberkörper hochlagern (venöser Rückfluss/Atmung), O_2 nach AO, Atmung/SpO_2 engmaschig, Zugänge/Messungen nicht am gestauten Bereich, Angst reduzieren, rasche ursächliche Therapieplanung nach AO; auf Atemwegsverlegung/Hirndruckzeichen achten, Intensiv bei Verschlechterung.

Fall 61 · Verwirrt und exsikkiert

1A	FALSCH	Die Hyperkalzämie ist behandelbar und gefährlich – nicht einfach abwarten.
1B	RICHTIG	Die Symptomtrias passt zur Hyperkalzämie – Arzt, Bilanz, Schutz.
2A	VERTRETBAR	Die Patientin ist exsikkiert – Hydrierung ist die Basistherapie, nicht Flüssigkeitsrestriktion.
2B	RICHTIG	Rehydrierung steht im Vordergrund, dann kalziumsenkende Therapie nach AO.
3A	RICHTIG	Neuro/EKG, Bilanz, Sturzschutz, Symptommanagement.
3B	VERTRETBAR	Bei Verwirrtheit/Schwäche besteht Sturzgefahr – Schutz und Begleitung.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Den Verlauf weiter kontrollieren.

Merke: Maligne Hyperkalzämie (Müdigkeit/Verwirrtheit, Übelkeit, Obstipation, Polyurie/Exsikkose): Arzt, ausreichende Rehydrierung nach AO als Basis, dann kalziumsenkende Therapie nach AO, EKG/Elektrolyte/Bilanz, Bewusstseins- und Sturzschutz, Symptommanagement; keine Flüssigkeitsrestriktion.

Fall 62 · Brennen an der Infusionsstelle

1A	FALSCH	Zytostatika-Paravasate können schwere Gewebeschäden verursachen – sofort stoppen.
1B	RICHTIG	Sofort stoppen, Zugang belassen, aspirieren nach Standard, Arzt, hochlagern.
1C	VERTRETBAR	Erst nach Standard aspirieren; Massieren verteilt die Substanz und schadet.
2A	RICHTIG	Substanzabhängige Maßnahmen nach Standard, Antidot nach AO, dokumentieren.
2B	VERTRETBAR	Kälte/Wärme sind substanzabhängig – nach Standard, nicht pauschal.
3A	VERTRETBAR	Engmaschige Beobachtung ist nötig – Komplikationen früh erkennen.
3B	RICHTIG	Beobachtung/Lagerung, Schmerz, Dokumentation, Aufklärung.
4A	VERTRETBAR	Spätschäden sind möglich – Verlauf beobachten.
4B	RICHTIG	

Merke: Zytostatika-Paravasat: Infusion sofort stoppen (Zugang zunächst belassen, Reste aspirieren nach Standard), Arzt, Extremität hochlagern, substanzspezifische Maßnahmen nach Standard (Kälte/Wärme/Antidot – nicht pauschal), nicht massieren, engmaschige Beobachtung und Dokumentation, bei Bedarf Fachstelle.

Fall 63 · Plötzliche Schmerzkrise

1A	RICHTIG	Erfassen, schnell wirksame Bedarfsmedikation nach AO, Präsenz.
1B	VERTRETBAR	Nicht-medikamentöse Maßnahmen ergänzen, ersetzen aber bei NRS 9 nicht die Bedarfsmedikation nach AO.
1C	FALSCH	Durchbruchschmerz wird mit Bedarfsmedikation behandelt – nicht auf die nächste Basisgabe warten.
2A	VERTRETBAR	Keine eigenmächtige Dosissteigerung – nach AO nachsteuern, Atemdepression vermeiden.
2B	RICHTIG	Wirkung reevaluieren und nach AO anpassen, Nebenwirkungen beobachten.
3A	RICHTIG	Opioid-Nebenwirkungen, Ursache bedenken, Doku, Zuwendung.
3B	VERTRETBAR	Auf Atmung/Sedierung und erneuten Schmerz weiter achten.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Wiederholte Reevaluation ist nötig.

Merke: Durchbruchschmerz/Schmerzkrise: strukturiert erfassen, schnell wirksame Bedarfsmedikation nach AO (nicht auf die nächste Basisgabe warten), Wirkung reevaluieren und nach AO nachsteuern (keine eigenmächtige Dosissteigerung), Opioid-Nebenwirkungen (Sedierung/Atemdepression, Obstipation/Übelkeit) beachten, nicht-medikamentöse Maßnahmen ergänzend, häufigen Durchbruchschmerz → Basistherapie ärztlich überprüfen.

Fall 64 · Patientin unter Chemotherapie

1A	FALSCH	Du könntest die Patientin gefährden.
1B	VERTRETBAR	Schutzmaßnahmen müssen konsequent sein.
1C	RICHTIG	Richtig – Schutz der abwehrgeschwächten Patientin.
2A	RICHTIG	Sehr gut – Schleimhäute und Haut sind gefährdet.
2B	FALSCH	Mukositis-Risiko wird übersehen.
2C	VERTRETBAR	Mund- und Hautbeobachtung sind hier zentral.
3A	RICHTIG	Richtig – neutropenes Fieber ernst nehmen.
3B	FALSCH	Verzögerung kann gefährlich werden.
3C	VERTRETBAR	Bei Immunschwäche zählt schon dieses Fieber.
4A	VERTRETBAR	Meldung und Gesamtdoku gehören dazu.
4B	RICHTIG	Genau richtig.

Merke: 1. Lernjahr Onkologie: konsequenter Infektionsschutz, Mund-/Hautpflege, Fieber bei Abwehrschwäche ist ein Notfall.

Fall 65 · Akuter Hodenschmerz

1A	FALSCH	Ein plötzlicher heftiger Hodenschmerz ist ein Notfall – nicht abwarten.
1B	VERTRETBAR	Bei drohender OP nüchtern lassen – orale Aufnahme verzögert den Eingriff.
1C	RICHTIG	Bei Torsionsverdacht zählt die Zeit (Hodenrettung) – sofort Urologie, nüchtern lassen.
2A	VERTRETBAR	Alleinige Schmerztherapie verschleppt die Diagnose – dringende Abklärung.
2B	RICHTIG	Doppler-Sono, OP-Vorbereitung, nüchtern – das Zeitfenster ist eng.
3A	VERTRETBAR	Eine Reposition ist ärztlich – nicht eigenmächtig manipulieren.
3B		

RICHTIG Nüchtern, OP-Vorbereitung, Schmerz nach AO, Dringlichkeit.

4A RICHTIG

4B VERTRETBAR Die Hodenrettung ist zeitabhängig – zügig handeln.

Merke: Hodentorsion: urologischer Notfall mit engem Zeitfenster – sofort Urologie, nüchtern lassen (OP), dringende Doppler-Sono, Schmerz nach AO, OP-Vorbereitung; nicht abwarten, nicht durch alleinige Schmerzmittelgabe verschleppen, Reposition ist ärztlich.

Fall 66 · Kein Wasserlassen möglich

1A VERTRETBAR Druck auf die volle Blase ist schmerzhaft und schädlich – nicht pressen.

1B FALSCH Die überdehnte Blase muss entlastet werden – nicht abwarten.

1C RICHTIG Praller Unterbauch + kein Wasserlassen = Harnverhalt, Entlastung nach AO.

2A RICHTIG Katheter nach AO, aseptisch, Menge erfassen.

2B VERTRETBAR Schlagartige komplette Entleerung kann Kreislaufprobleme/Entlastungsblutung auslösen – kontrolliert ablassen.

3A RICHTIG Bilanz, Kreislauf/Entlastungsblutung, Ursache.

3B VERTRETBAR Die Menge/Bilanz ist wichtig – dokumentieren.

4A VERTRETBAR Verlauf und mögliche Entlastungsblutung im Blick behalten.

4B RICHTIG

Merke: Akuter Harnverhalt: Blase per Katheter nach AO entlasten (aseptisch), kontrolliert/nicht schlagartig vollständig ablassen, Ein-/Ausfuhr erfassen, Kreislauf/Entlastungsblutung beobachten, Ursache abklären; nicht abwarten, nicht auf den Unterbauch pressen.

Fall 67 · Heftiger Flankenschmerz

1A VERTRETBAR Fieber bei Harnstau kann auf eine gefährliche Urosepsis hinweisen – immer mit prüfen.

1B RICHTIG Wellenartiger Flankenschmerz spricht für eine Kolik – Temperatur/Vitalzeichen mit beachten.

1C FALSCH Die typische Kolik gehört abgeklärt und behandelt – nicht abtun.

2A VERTRETBAR Die Kolik ist sehr schmerzhaft – Analgesie nach AO gehört dazu.

2B RICHTIG Schmerz-/Spasmolyse nach AO, Urin sieben, Temperatur im Blick.

3A RICHTIG Fieber/Schüttelfrost = Alarm (Urosepsis), sofort melden.

3B VERTRETBAR Fieber bei Harnstein/Harnstau ist ein Warnzeichen – nicht ignorieren.

4A RICHTIG

4B VERTRETBAR Verlauf und Warnzeichen weiter beobachten.

Merke: Nierenkolik (Harnstein): Schmerz-/Spasmolyse nach AO (Wärme lindert), Urin beobachten/sieben, Flüssigkeit nach AO; engmaschig auf Fieber/Schüttelfrost (Urosepsis-Gefahr!) und Harnverhalt achten und bei Fieber sofort melden.

Fall 68 · Katheter läuft nicht

1A RICHTIG Erst das System prüfen – häufige Ursachen sind Abknickung/Lage.

1B FALSCH Bei prallem Unterbauch droht eine Blasenüberdehnung – nicht abwarten.

1C

VERTRETBAR Ziehen kann verletzen (Ballon!) – nicht am Katheter zerren.

2A RICHTIG Erst einfache Ursachen, dann Anspülen/Wechsel nach Standard.

2B VERTRETBAR Unkontrolliertes Spülen mit Druck schadet – nach Standard/AO vorgehen.

3A RICHTIG Fluss/Bilanz, Blase, Asepsis, Verlauf.

3B VERTRETBAR Bilanz/Verlauf sind wichtig – dokumentieren.

4A VERTRETBAR Eine erneute Verstopfung im Blick behalten.

4B RICHTIG

Merke: Verstopfter Dauerkatheter: erst einfache Ursachen prüfen (Abknickung, Lage, Beutelhöhe), bei fortbestehender Obstruktion Anspülen/Wechsel nach AO/Standard (aseptisch), nicht am Katheter zerren, Urinfluss/Bilanz und Blase überwachen, auf Harnverhalt achten, dokumentieren.

Fall 69 · Blutiger Urin, plötzlich kein Abfluss

1A FALSCH Tamponade und Blutverlust sind gefährlich – nicht abwarten.

1B VERTRETBAR Bei Blutung droht ein Schock – Kreislauf engmaschig beachten.

1C RICHTIG Koagel-Tamponade + Blässe = Kreislauf im Blick, sofort Urologie.

2A RICHTIG Dauerspülung/Koagelausspülung nach AO, Kreislauf stützen.

2B VERTRETBAR Der Blutverlust ist das Hauptproblem – Kreislauf/Volumen nach AO.

3A VERTRETBAR Vorzeitiger Spülstopp begünstigt eine erneute Tamponade – nach AO weiterführen.

3B RICHTIG Kreislauf, Spülung/Abfluss, Bilanz, erneute Tamponade.

4A VERTRETBAR Bei Blutung engmaschig überwachen.

4B RICHTIG

Merke: Makrohämaturie mit Blasentamponade: Harnverhalt durch Koagel – sofort Urologie, Dauerspülung/Koagelausspülung nach AO (aseptisch), engmaschig Kreislauf/Vitalzeichen wegen Blutverlust, Volumen/Transfusion nach AO, Bilanz, Spülung/Abfluss überwachen; nicht abwarten, den Kreislauf nie aus dem Blick verlieren.

Fall 70 · Verwirrt nach Prostata-OP

1A RICHTIG Verwirrtheit nach TUR-P mit Spülung = an Hyponatriämie/TUR-Syndrom denken.

1B FALSCH Diese Zeichen können ein TUR-Syndrom sein – nicht einfach abwarten.

1C VERTRETBAR Das Grundproblem ist die Elektrolytentgleisung – nicht nur das Symptom behandeln.

2A VERTRETBAR Zusätzliche freie Flüssigkeit verstärkt die Verdünnungshyponatriämie – nicht eigenmächtig.

2B RICHTIG Natrium/Elektrolyte und Bilanz nach AO, engmaschig überwachen.

3A RICHTIG Neuro/Vitalzeichen, genaue Bilanz, Elektrolyte nach AO.

3B VERTRETBAR Engmaschiges Monitoring ist nötig.

4A VERTRETBAR Den Verlauf engmaschig kontrollieren.

4B RICHTIG

Merke: TUR-Syndrom (Verdünnungshyponatriämie durch Spülflüssigkeitsaufnahme bei TUR-P): Verwirrtheit/Übelkeit/Kopfschmerz/Kreislaufveränderung ernst nehmen – sofort Arzt/Anästhesie, Vitalzeichen/Neurostatus engmaschig, Natrium/Elektrolyte und Bilanz nach AO, keine eigenmächtige zusätzliche freie Flüssigkeit, Intensivüberwachung; nicht als bloßes 'Narkose-Nachwirken' abtun.

Fall 71 · Der Blasenkatheter

1A	RICHTIG	Richtig – Rückfluss vermeiden, System geschlossen halten.
1B	FALSCH	Über Blasenniveau droht Rückfluss und Infektion.
1C	FALSCH	Eigenmächtiges Abklemmen kann Harnstau verursachen.
2A	FALSCH	Hauptübertragungsweg für Keime.
2B	RICHTIG	Sehr gut – Hygiene senkt das HWI-Risiko.
2C	VERTRETBAR	Regelmäßige, sorgfältige Pflege ist nötig.
3A	FALSCH	Kann auf Harnstau oder Nierenproblem hinweisen.
3B	VERTRETBAR	Trinken hilft, die geringe Ausfuhr muss aber gemeldet werden.
3C	RICHTIG	Richtig – Ursache suchen und melden.
4A	RICHTIG	Genau richtig.
4B	VERTRETBAR	Ein- und Ausfuhr gehören vollständig erfasst.

Merke: 1. Lernjahr Urologie: geschlossenes System, Beutel unter Blasenniveau, Hygiene, Ein-/Ausfuhr bilanzieren, Infektzeichen melden.

Fall 72 · Starke Blutung nach der Geburt

1A	FALSCH	Starke anhaltende Blutung ist kein normaler Wochenfluss – sofort handeln.
1B	RICHTIG	Weicher Uterus + starke Blutung = Atonie, sofort Hilfe holen.
1C	VERTRETBAR	Bei starker Blutung droht ein Schock – Kreislauf engmaschig beachten.
2A	RICHTIG	Fundusmassage + Blasenentleerung + Uterotonika nach AO.
2B	VERTRETBAR	Bei Atonie hilft die Fundusmassage, den Uterus zu kontrahieren – nicht unterlassen.
3A	RICHTIG	Kreislauf, Blutung/Uterustonus, Volumen nach AO.
3B	VERTRETBAR	Den Blutverlust einschätzen und dokumentieren ist wichtig.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Bei Blutung engmaschig überwachen.

Merke: Postpartale Blutung (häufig Uterusatonie): sofort Hilfe – Fundusmassage, Blase entleeren, uteruskontrahierende Medikamente nach AO, Zugang/Volumen/Transfusion nach AO, engmaschig Kreislauf/Vitalzeichen und Blutungsstärke, Blutverlust einschätzen/dokumentieren; nicht als normalen Wochenfluss verkennen.

Fall 73 · Hoher Blutdruck mit Warnzeichen

1A	FALSCH	Diese Zeichen kündigen einen Krampfanfall an – nicht abwarten.
1B	RICHTIG	Diese Trias bei Hypertonie spricht für Präeklampsie mit Krampfgefahr.
1C	VERTRETBAR	Reize können einen Krampf begünstigen – reizarm und ruhig.

2A	RICHTIG	Reizarm, RR engmaschig, Magnesium nach AO, Krampfbereitschaft.
2B	VERTRETBAR	Bei Krampfgefahr nicht allein lassen – Überwachung und Bereitschaft.
3A	VERTRETBAR	Nichts in den Mund, nicht festhalten – nur die Umgebung sichern.
3B	RICHTIG	Schützen, nichts in den Mund, Atemweg/O_2, Therapie nach AO.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Weiter engmaschig überwachen (erneuter Krampf möglich).

Merke: Präeklampsie/Eklampsie (Hypertonie + Kopfschmerz/Sehstörung/Oberbauchschmerz, Krampfgefahr): sofort Arzt, reizarme ruhige Umgebung, RR/Vitalzeichen engmaschig, Krampfprophylaxe (Magnesium) nach AO, Krampfbereitschaft; bei Krampf schützen (nichts in den Mund), Atemweg/O_2, Mutter und Kind überwachen.

Fall 74 · Akuter Unterbauchschmerz in der Frühschwangerschaft

1A	RICHTIG	Frühschwangerschaft + akuter Schmerz + Schock = an rupturierte EUG denken.
1B	FALSCH	Mit Schockzeichen ist das ein Notfall – nicht als Regelschmerz abtun.
1C	VERTRETBAR	Blässe/Tachykardie/Hypotonie sind Schockzeichen – ernst nehmen.
2A	VERTRETBAR	Bei drohender OP nüchtern lassen – orale Aufnahme verzögert den Eingriff.
2B	RICHTIG	Kreislauf stützen, nüchtern, OP-Vorbereitung.
3A	RICHTIG	Schockzeichen, Blutung, OP-Vorbereitung, nüchtern.
3B	VERTRETBAR	Die Schmerztherapie ersetzt nicht die dringende Abklärung/OP.
4A	VERTRETBAR	Bei Schockgefahr engmaschig überwachen.
4B	RICHTIG	

Merke: Rupturierte Extrauteringravidität (Frühschwangerschaft + akuter einseitiger Unterbauchschmerz + Schock): lebensbedrohlich – sofort Arzt/Notfall, Zugang/Volumen nach AO, nüchtern lassen (OP), OP-Vorbereitung, Transfusionsbereitschaft, engmaschig Kreislauf/Schockzeichen; nicht als Regelschmerz verkennen.

Fall 75 · Brustentzündung in der Stillzeit

1A	FALSCH	Ein Stillstopp begünstigt den Milchstau und verschlimmert die Mastitis – weiter entleeren.
1B	RICHTIG	Lokale Entzündung + Fieber in der Stillzeit = Mastitis; weiter entleeren.
1C	VERTRETBAR	Mastitis sollte früh behandelt werden – nicht abwarten.
2A	RICHTIG	Entleeren, schonende Maßnahmen, Therapie nur nach AO.
2B	VERTRETBAR	Medikamente (auch Antibiotika) nur nach AO – nicht eigenmächtig.
3A	VERTRETBAR	Eine Abszessbildung muss erkannt werden – nicht ignorieren.
3B	RICHTIG	Verlauf (Abszess?), Stillunterstützung, Symptommanagement.
4A	VERTRETBAR	Den Verlauf (Abszess?) im Blick behalten.
4B	RICHTIG	

Merke: Mastitis puerperalis (Rötung/Schmerz/Überwärmung + Fieber in der Stillzeit): weiter regelmäßig entleeren/stillen (Milchstau lösen!), schonende Maßnahmen nach Vorgabe, Schmerz-/Fiebermanagement und Antibiotika nur nach AO, Verlauf beobachten (Abszess?), Stillunterstützung; Stillen nicht abrupt stoppen, keine eigenmächtige Medikamentengabe.

Fall 76 · Starkes Erbrechen in der Schwangerschaft

1A	RICHTIG	Häufiges Erbrechen + Exsikkose-Zeichen = Hyperemesis, einschätzen und melden.
1B	FALSCH	Mit Gewichtsverlust/Exsikkose ist das mehr als normale Übelkeit – nicht abwarten.
1C	VERTRETBAR	Große Mahlzeiten verstärken das Erbrechen – kleine Mengen anbieten.
2A	VERTRETBAR	Medikamente nur nach AO – gerade in der Schwangerschaft nicht eigenmächtig.
2B	RICHTIG	Flüssigkeit/Antiemese nach AO, kleine Mengen, Bilanz.
3A	RICHTIG	Bilanz/Gewicht, Exsikkose-Zeichen, Reize meiden.
3B	VERTRETBAR	Bilanz/Gewicht sind wichtig – erfassen.
4A	VERTRETBAR	Den Flüssigkeits-/Ernährungszustand weiter im Blick behalten.
4B	RICHTIG	

Merke: Hyperemesis gravidarum (häufiges Erbrechen mit Exsikkose): Flüssigkeit/Elektrolyte und Antiemese nach AO (oft i.v.), kleine leichte Mahlzeiten/Schlucke, Reize/Gerüche meiden, Ein-/Ausfuhr und Gewicht erfassen, auf Verschlechterung achten; nicht zum Essen zwingen, keine eigenmächtige Medikamentengabe.

Fall 77 · Schwindel in Rückenlage (Schwangerschaft)

1A	FALSCH	Die Rückenlage ist die Ursache – Lagerung sofort ändern.
1B	RICHTIG	In Rückenlage drückt der Uterus auf die V. cava – sofort Linksseitenlage.
1C	VERTRETBAR	Ruckartiges Aufrichten kann den Kreislauf weiter belasten – kontrolliert in Linksseitenlage.
2A	VERTRETBAR	Bei Blutdruckabfall die Lagerung ändern und überwachen – nicht abwarten.
2B	RICHTIG	Linksseitenlage, Vitalzeichen, meist rasche Besserung.
3A	RICHTIG	Rückenlage meiden, anleiten, Mutter/Kind beobachten.
3B	VERTRETBAR	Die Schwangere sollte die Rückenlage meiden – dazu anleiten.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Lagerung und Befinden weiter im Blick behalten.

Merke: V.-cava-Kompressionssyndrom (Blutdruckabfall der Hochschwangeren in Rückenlage): sofort in Linksseitenlage bringen (oder linke Hüfte unterpolstern), Vitalzeichen kontrollieren, meist rasche Besserung, Arzt informieren; künftig Rückenlage meiden und die Schwangere dazu anleiten.

Fall 78 · Im Wochenbett

1A	RICHTIG	Richtig – einfühlsam und vollständig.
1B	FALSCH	Erst informieren und Einverständnis einholen.
1C	VERTRETBAR	Wichtig zu beobachten – sachlich und respektvoll ansprechen.
2A	FALSCH	Eine verstärkte Blutung würde übersehen.
2B	VERTRETBAR	Beobachtung gehört dazu, nicht nur die Frage.

2C	RICHTIG	Sehr gut – wichtige Verlaufsbeobachtung.
3A	FALSCH	Im Wochenbett ist Begleitung wichtig.
3B	RICHTIG	Richtig – frühe, dosierte Mobilisation.
3C	VERTRETBAR	Längere Bettruhe erhöht das Thromboserisiko.
4A	RICHTIG	Genau richtig.
4B	VERTRETBAR	Dokumentation nicht vergessen.

Merke: 1. Lernjahr Gynäkologie: respektvoll kommunizieren, Wochenfluss beobachten, Mobilisation und Prophylaxe, Blutung sofort melden.

Fall 79 · Starkes Nasenbluten

1A	RICHTIG	Aufrecht, Kopf nach vorne, Nasenflügel komprimieren, kühlen – richtig.
1B	VERTRETBAR	Bei starker Blutung Kreislauf im Blick behalten.
1C	FALSCH	Kopf in den Nacken lässt Blut in den Rachen/Magen laufen (Verschlucken/Übelkeit) – Kopf nach vorne.
2A	RICHTIG	HNO/Tamponade nach AO, Ursache bedenken.
2B	VERTRETBAR	Ständiges Loslassen verhindert die Gerinnung – durchgehend komprimieren.
3A	VERTRETBAR	Blutungsstärke/-menge im Blick behalten.
3B	RICHTIG	Kreislauf, Tamponade-Pflege, Ursache.
4A	VERTRETBAR	Auf erneute Blutung/Kreislauf achten.
4B	RICHTIG	

Merke: Starkes Nasenbluten: aufrecht hinsetzen, Kopf nach vorne, Nasenflügel 10–15 min durchgehend komprimieren, Nacken kühlen, Blut ausspucken lassen (nicht schlucken, Kopf nicht in den Nacken); bei anhaltender Blutung HNO/Tamponade nach AO, Vitalzeichen/Kreislauf beobachten, Ursache (Antikoagulation/Hypertonie) bedenken.

Fall 80 · Atemnot bei Tracheostoma

1A	VERTRETBAR	Bei Tracheostoma muss am Stoma gehandelt werden – Mund-/Nasen-O_2 allein geht am Atemweg vorbei.
1B	RICHTIG	Am Stoma handeln: absaugen, Innenkanüle prüfen – richtig.
1C	FALSCH	Bei Atemnot mit fallender SpO_2 nicht abwarten.
2A	RICHTIG	Absaugen/Innenkanüle, sonst Kanülenwechsel/Arzt, Notfallset bereit.
2B	VERTRETBAR	Unkontrolliertes tiefes Absaugen schädigt die Schleimhaut und verschlimmert die Hypoxie – nach Standard.
3A	VERTRETBAR	Bei Tracheostoma müssen Ersatzkanülen/Notfallset immer griffbereit sein.
3B	RICHTIG	Atmung/SpO_2, Befeuchtung, Notfallset bereit.
4A	VERTRETBAR	Erneute Verlegung im Blick behalten.
4B	RICHTIG	

Merke: Verlegte Trachealkanüle / Atemnot bei Tracheostoma: Notfall – Hilfe rufen, O_2, Oberkörper hoch, am Stoma handeln (absaugen nach Standard, Innenkanüle reinigen/wechseln, ggf. Kanülenwechsel/Arzt), Atmung/SpO_2 engmaschig, Befeuchtung nach AO, Ersatzkanülen/Notfallset immer griffbereit; nicht abwarten, nicht nur über Mund/Nase am Stoma vorbei arbeiten.

Fall 81 · Nachblutung nach Mandel-OP

1A	FALSCH	Frisches Blut/häufiges Schlucken ist eine Nachblutung – nicht abwarten.
1B	VERTRETBAR	Bei Blutung droht ein Schock – Kreislauf beachten.
1C	RICHTIG	Häufiges Schlucken + frisches Blut = Nachblutung, sofort Arzt, nüchtern.
2A	VERTRETBAR	Bei drohender OP und Blutung nüchtern lassen – orale Aufnahme erhöht Aspirations-/OP-Risiko.
2B	RICHTIG	Arzt/HNO, nüchtern, kühlen nach AO, OP-Vorbereitung.
3A	VERTRETBAR	Verschlucktes Blut unterschätzt den Blutverlust – beachten.
3B	RICHTIG	Kreislauf, Aspirationsschutz, nüchtern, OP-Vorbereitung.
4A	VERTRETBAR	Bei Blutung engmaschig überwachen.
4B	RICHTIG	

Merke: Nachblutung nach Tonsillektomie: Notfall – sofort Arzt/HNO, nüchtern lassen (mögliche OP), Oberkörper hoch/Kopf zur Seite und Blut ausspucken lassen (Aspirationsschutz), Vitalzeichen/Kreislauf engmaschig (Kinder verschlucken Blut → Blutverlust wird unterschätzt!), kühlen/OP-Vorbereitung nach AO, beruhigen; nicht als normal abtun, nichts oral geben.

Fall 82 · Atemnot mit Speichelfluss

1A	RICHTIG	Diese Konstellation ist ein Atemwegsnotfall – sitzen lassen, Ruhe, Notfall.
1B	FALSCH	Eine Racheninspektion kann bei Epiglottitis die Atemwege komplett verlegen – unterlassen!
1C	VERTRETBAR	Flachlage verschlimmert die Atemnot – sitzen lassen.
2A	RICHTIG	Sitzen, Ruhe, O_2, Intubationsbereitschaft, nichts in den Mund.
2B	VERTRETBAR	Bei drohender Atemwegsverlegung nichts zu trinken (Aspiration/Reiz) – nüchtern.
3A	RICHTIG	Atmung/SpO_2, sitzen, Ruhe, Bereitschaft.
3B	VERTRETBAR	Bei drohender Atemwegsverlegung nicht allein lassen.
4A	VERTRETBAR	Die Atemwege können rasch komplett verlegen – engmaschig bleiben.
4B	RICHTIG	

Merke: Epiglottitis (akuter Atemwegsnotfall: hohes Fieber, kloßige Sprache, Speichelfluss, sitzende vornübergebeugte Haltung, Atemnot): sitzen lassen, Ruhe/nicht reizen, O_2 nach AO, sofort Notfall/Anästhesie/HNO mit Intubationsbereitschaft, nichts in den Mund und KEINE Racheninspektion (kann die Atemwege komplett verlegen!), engmaschig Atmung/SpO_2, nicht allein lassen; nicht flach hinlegen, nichts zu trinken geben.

Fall 83 · Heftiger Drehschwindel-Anfall

1A	RICHTIG	Sturzprophylaxe steht im Vordergrund – sicher hinsetzen/-legen.
1B	FALSCH	Bei Drehschwindel und Fallneigung droht ein Sturz – nicht allein gehen lassen.
1C	VERTRETBAR	Reize verstärken Schwindel/Übelkeit – reizarm und ruhig.
2A	VERTRETBAR	Medikamente nur nach AO – nicht eigenmächtig.
2B	RICHTIG	Antivertiginosa/Antiemese nach AO, ruhige Lagerung.
3A	RICHTIG	Sturzprophylaxe, Begleitung, reizarm.
3B	VERTRETBAR	Im Anfall nicht unbeaufsichtigt aufstehen lassen – Sturzgefahr.

4A	VERTRETBAR	Sturzrisiko bleibt – weiter begleiten.
4B	RICHTIG	

Merke: Akuter Drehschwindel (z. B. Menière-Anfall): Sturzprophylaxe steht im Vordergrund – sicher hinsetzen/-legen, nicht allein gehen lassen/begleiten, reizarme ruhige Umgebung, Antiemetika/Antivertiginosa nach AO, Erbrechen managen, beruhigen und zu Verhalten im Anfall anleiten; keine eigenmächtige Medikamentengabe.

Fall 84 · Plötzliche einseitige Hörminderung

1A	RICHTIG	Plötzliche einseitige Hörminderung = HNO-Eilfall, zeitnah abklären.
1B	FALSCH	Ein Hörsturz wird zeitnah behandelt – nicht tagelang abwarten.
1C	VERTRETBAR	Medikamente nur nach AO – nicht eigenmächtig.
2A	VERTRETBAR	Manipulation/Spülung ist hier nicht angezeigt – HNO-Abklärung.
2B	RICHTIG	HNO-Abklärung, Kortison nur nach AO, Ruhe.
3A	RICHTIG	Ruhe, Sturzprophylaxe bei Schwindel, psychische Unterstützung.
3B	VERTRETBAR	Die Angst ernst nehmen – psychische Unterstützung gehört dazu.
4A	VERTRETBAR	Verlauf und Befinden weiter im Blick behalten.
4B	RICHTIG	

Merke: Hörsturz (plötzliche einseitige, schmerzlose Hörminderung, oft mit Tinnitus): als HNO-Eilfall zeitnah abklären lassen, Medikamente (z. B. Kortison) nur nach AO mit Wirkungs-/Nebenwirkungskontrolle, Ruhe/Stressreduktion, bei Schwindel Sturzprophylaxe, psychische Unterstützung und Edukation; nicht tagelang abwarten, keine eigenmächtige Gabe/Manipulation am Ohr.

Fall 85 · Nach der Mandel-OP

1A	RICHTIG	Richtig – Nachblutung ist die Hauptgefahr.
1B	VERTRETBAR	Aktive Beobachtung ist besser als reines Abwarten.
1C	FALSCH	Wärme fördert die Blutung – kühle Kost ist richtig.
2A	FALSCH	Das kann die Wunde aufreißen.
2B	RICHTIG	Sehr gut – schont die Wundflächen.
2C	VERTRETBAR	Leicht erhöhter Kopf ist günstiger.
3A	VERTRETBAR	Auch häufiges Schlucken ist ein frühes Zeichen.
3B	RICHTIG	Richtig erkannt.
3C	FALSCH	Eine Nachblutung kann lebensbedrohlich werden.
4A	VERTRETBAR	Zeitnah melden und dokumentieren.
4B	RICHTIG	Genau richtig.

Merke: 1. Lernjahr HNO: nach Tonsillektomie auf Nachblutung achten (häufiges Schlucken!), kühle Kost, sofort melden.

Fall 86 · Sturz mit Hüftschmerz im Alter

1A	FALSCH	Bei Frakturverdacht nicht belasten/mobilisieren – Dislokations- und Schadensgefahr.

1B	RICHTIG	Verkürztes/außenrotiertes Bein nach Sturz spricht für eine hüftnahe Fraktur – ruhigstellen, DMS prüfen.
1C	VERTRETBAR	Schmerz erfassen und behandeln (nach AO) gehört dazu.
2A	VERTRETBAR	Bei möglicher OP nüchtern lassen.
2B	RICHTIG	Ruhigstellen, Schmerz nach AO, nüchtern, OP-Vorbereitung.
3A	VERTRETBAR	Gerade bei Immobilität sind Prophylaxen wichtig.
3B	RICHTIG	Prophylaxen, Delir im Blick, Schmerz/Lagerung.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Verlauf/DMS/Delir weiter beobachten.

Merke: Hüftgelenknahe Fraktur (Schenkelhals) nach Sturz (verkürztes/außenrotiertes Bein): Bein ruhigstellen/nicht belasten, Schmerztherapie nach AO, nüchtern lassen (OP), DMS kontrollieren, OP-Vorbereitung; konsequente Prophylaxen (Dekubitus/Thrombose/Pneumonie) und auf Delir beim alten Menschen achten; nicht zum Aufstehen auffordern, nichts oral geben.

Fall 87 · Atemnot Tage nach Knochenbruch

1A	VERTRETBAR	Das Hauptproblem ist die respiratorische/zerebrale Beteiligung – nicht nur den Schmerz.
1B	FALSCH	Diese Zeichen sind ein Notfall – nicht abwarten.
1C	RICHTIG	Diese Trias nach Röhrenknochenbruch passt zum Fettembolie-Syndrom.
2A	RICHTIG	O_2, engmaschiges Monitoring, Intensiv.
2B	VERTRETBAR	Bei Atemnot/instabiler Lage nicht forcieren – schonen und überwachen.
3A	VERTRETBAR	Engmaschiges Monitoring ist nötig.
3B	RICHTIG	Atmung/SpO_2/Bewusstsein, Intensiv.
4A	VERTRETBAR	Verlauf engmaschig kontrollieren.
4B	RICHTIG	

Merke: Fettembolie-Syndrom (1–3 Tage nach Röhrenknochenbruch: Atemnot + Verwirrtheit + Petechien): Notfall – sofort Arzt, O_2 nach AO, engmaschig Atmung/SpO_2/Bewusstsein, Intensivüberwachung, Therapie nach AO; nicht als Erschöpfung abtun, nicht nur den Schmerz behandeln.

Fall 88 · Schmerzen und Taubheit unter dem Gips

1A	FALSCH	Der zunehmende Schmerz ist ein Warnzeichen – nicht nur überdecken/abwarten.
1B	VERTRETBAR	Tieflagerung verstärkt die Schwellung – hochlagern.
1C	RICHTIG	Diese Zeichen sind Alarm – DMS prüfen, hochlagern, Arzt, Gips nach AO spalten.
2A	VERTRETBAR	Engeres Wickeln verstärkt den Druck – nach AO lockern/spalten.
2B	RICHTIG	Hochlagern, Gips nach AO spalten, DMS engmaschig.
3A	VERTRETBAR	Schmerzmittel überdecken den Warnschmerz – DMS/Ursache angehen.
3B	RICHTIG	DMS engmaschig, Schwellung/Schmerz, hochlagern.
4A	VERTRETBAR	DMS weiter engmaschig prüfen.
4B	RICHTIG	

Merke: Zu enger Gips / drohende Durchblutungs-/Nervenstörung (zunehmender Schmerz, Kribbeln/Taubheit, blasse kühle Zehen): DMS (Durchblutung/Motorik/Sensibilität) engmaschig prüfen, Bein hochlagern, sofort Arzt und Gips nach AO spalten/lockern; nicht abwarten, nicht enger wickeln, nicht tief lagern, den Warnschmerz nicht nur mit Schmerzmitteln überdecken.

Fall 89 · Geschwollene, schmerzhafte Wade

1A	FALSCH	Massieren kann ein Gerinnsel lösen (Emboliegefahr!) – niemals massieren.
1B	RICHTIG	Einseitige geschwollene, warme Wade = TVT-Verdacht: nicht massieren, Arzt.
1C	VERTRETBAR	Bei TVT-Verdacht nicht eigenmächtig forcieren – erst abklären/AO.
2A	RICHTIG	Arzt/Diagnostik, Antikoagulation nach AO, auf LE-Zeichen achten.
2B	VERTRETBAR	Medikamente nur nach AO.
3A	RICHTIG	Nicht massieren, Therapie nach AO, LE-Zeichen melden.
3B	VERTRETBAR	Plötzliche Atemnot/Brustschmerz kann eine Lungenembolie sein – sofort melden!
4A	VERTRETBAR	Weiter auf LE-Zeichen achten.
4B	RICHTIG	

Merke: Tiefe Venenthrombose (einseitig geschwollene, überwärmte, schmerzhafte Wade nach Immobilisation/OP): Bein ruhigstellen, NICHT massieren/kneten (Emboliegefahr!), Arzt/Diagnostik, Antikoagulation und Lagerung nach AO, engmaschig auf Lungenembolie-Zeichen (plötzliche Atemnot/Brustschmerz/Tachykardie) achten und sofort melden, Edukation/Prophylaxe; keine eigenmächtige Medikamentengabe.

Fall 90 · Erste Mobilisation nach Hüft-TEP

1A	RICHTIG	Luxationsprophylaxe: verbotene Bewegungen vermeiden, Beine abspreizen.
1B	VERTRETBAR	Starke Beugung über 90° ist eine verbotene Bewegung – vermeiden.
1C	FALSCH	Überkreuzen/Übereinanderschlagen kann die TEP luxieren – vermeiden.
2A	VERTRETBAR	Ruckartig/ohne Hilfsmittel droht Sturz/Luxation – langsam und sicher.
2B	RICHTIG	Nach Vorgabe/Physio, erlaubte Bewegungen, Hilfsmittel.
3A	VERTRETBAR	Prophylaxen (Thrombose/Dekubitus/Pneumonie) sind wichtig.
3B	RICHTIG	Luxationsprophylaxe + weitere Prophylaxen, Wunde/DMS.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Weiter zu erlaubten Bewegungen anleiten.

Merke: Nach Hüft-TEP – Luxationsprophylaxe: verbotene Bewegungen vermeiden (Beine nicht überkreuzen/übereinanderschlagen, keine Beugung über 90°, kein starkes Innendrehen), Beine abspreizen, nach Vorgabe/Physiotherapie sicher mobilisieren (erlaubte Bewegungen, Hilfsmittel), Schmerz/Wunde/DMS beobachten, Thrombose-/Dekubitus-/Pneumonieprophylaxe, Edukation.

Fall 91 · Sturz aus Höhe mit Rückenschmerz

1A	FALSCH	Aufsetzen/Hinstellen kann bei instabiler Wirbelsäule das Rückenmark schädigen – nicht bewegen.
1B	RICHTIG	Bei diesem Mechanismus an instabile Wirbelsäule denken – nicht bewegen, Achse schützen.
1C	VERTRETBAR	Unkoordiniertes Umlagern gefährdet das Rückenmark – nur koordiniert im Team.
2A		

VERTRETBAR Allein/ruckartig ist gefährlich – nur koordiniert im Team.

2B	RICHTIG	Achse wahren, koordiniert im Team, Neurostatus, Notfallteam.
3A	VERTRETBAR	Die neurologischen Befunde sind hier entscheidend – engmaschig erfassen.
3B	RICHTIG	Achse, Neurostatus, koordiniert, Vitalzeichen.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Achse/Immobilisation konsequent wahren.

Merke: Verdacht auf (instabile) Wirbelsäulenverletzung (Sturz aus Höhe + Rückenschmerz + neurologische Zeichen): Patienten nicht aufsetzen/hinstellen, flach und ruhig lagern, Achse/HWS wahren, Bewegungen nur koordiniert im Team (Logroll) nach Vorgabe, sofort Notfall, Neurostatus engmaschig dokumentieren, Vitalzeichen/Wärmeerhalt; keine unkoordinierte oder alleinige Umlagerung.

Fall 92 · Nach der neuen Hüfte

1A	VERTRETBAR	Korrekte Lagerung mit Abduktion ist sicherer.
1B	RICHTIG	Richtig – schützt vor Luxation der Prothese.
1C	FALSCH	Luxationsgefahr durch falsche Bewegung.
2A	RICHTIG	Sehr gut – Thromboserisiko nach OP.
2B	VERTRETBAR	Bewegungslosigkeit erhöht das Thromboserisiko.
2C	FALSCH	Hohes Thromboserisiko wird ignoriert.
3A	FALSCH	Sturz- und Luxationsgefahr.
3B	RICHTIG	Richtig – dosiert und sicher.
3C	VERTRETBAR	Frühe, dosierte Mobilisation ist erwünscht.
4A	VERTRETBAR	Wunde und Beobachtung gehören dazu.
4B	RICHTIG	Genau richtig.

Merke: 1. Lernjahr Orthopädie nach Hüft-TEP: Abduktion, keine Beugung über 90°, Thromboseprophylaxe, sichere Mobilisation.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.